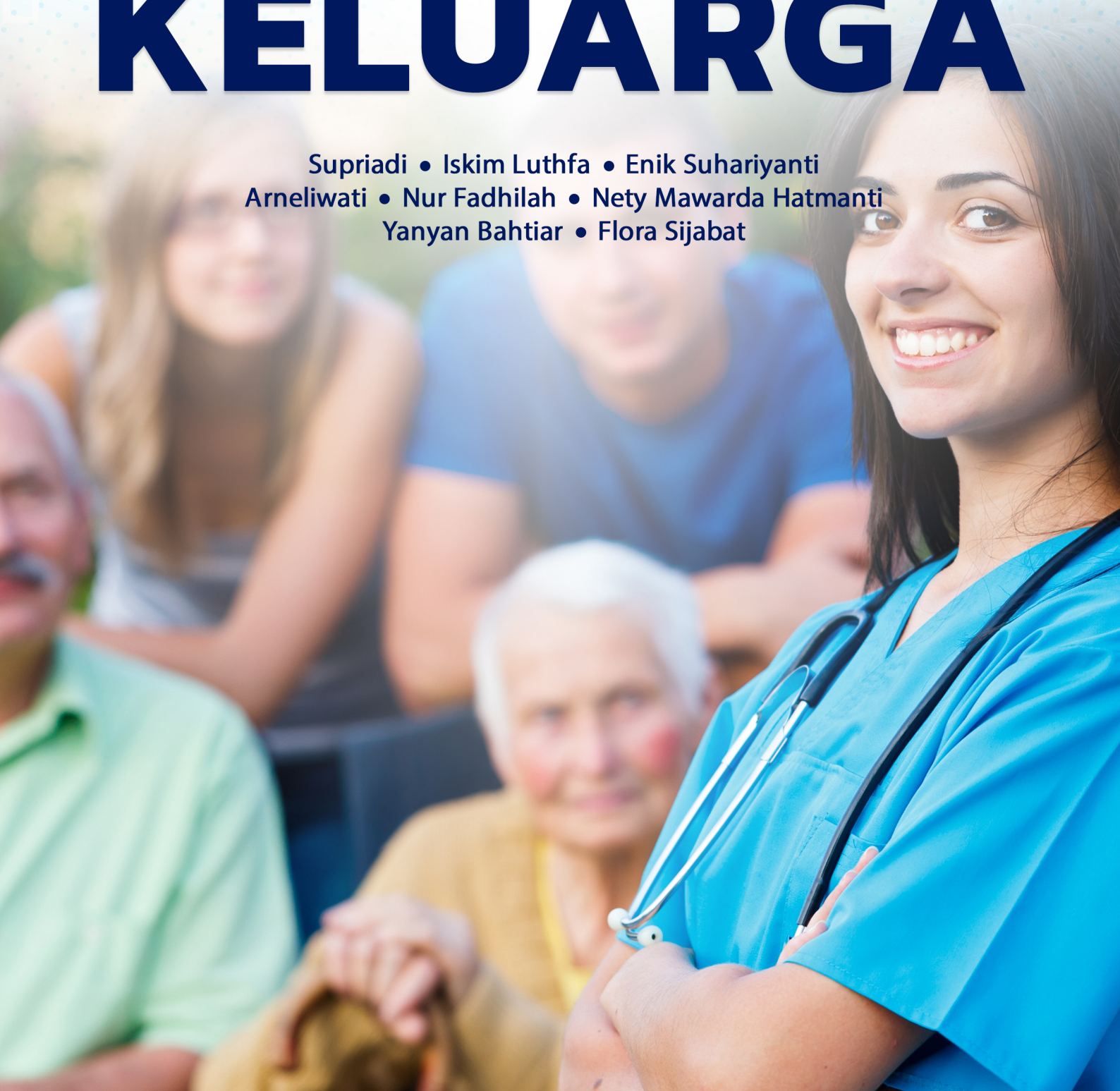


Buku Ajar

KEPERAWATAN KELUARGA

Supriadi • Iskim Luthfa • Enik Suhariyanti
Arneliwati • Nur Fadhilah • Nety Mawarda Hatmanti
Yanyan Bahtiar • Flora Sijabat



BUKU AJAR

KEPERAWATAN KELUARGA

Penulis:

Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.

Dr. Iskim Luthfa, S.Kep., Ns., M.kep.

Enik Suhariyanti, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. Arneliwati, M.Kep.

Nur Fadhilah, M.Kes., Ph.D.

Nety Mawarda Hatmanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Yanyan Bahtiar, S.Kp., M.Kep.

Ns Flora Sijabat, S.Kep., MNS.

BUKU AJAR KEPERAWATAN KELUARGA

Penulis: Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.

Dr. Iskim Luthfa, S.Kep., Ns., M.kep.

Enik Suhariyanti, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. Arneliwati, M.Kep.

Nur Fadhilah, M.Kes., Ph.D.

Nety Mawarda Hatmanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Yanyan Bahtiar, S.Kp., M.Kep.

Ns Flora Sijabat, S.Kep., MNS.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-623-10-9648-7

Cetakan Pertama : Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku ajar yang berjudul "**Keperawatan Keluarga**" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya dalam menunjang kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan keperawatan, sekaligus sebagai referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan praktisi kesehatan dalam memahami secara lebih mendalam tentang konsep dan praktik keperawatan keluarga.

Perkembangan ilmu keperawatan dewasa ini menuntut pendekatan yang lebih luas dan komprehensif. Keperawatan tidak lagi hanya berfokus pada individu sebagai penerima asuhan, tetapi telah berkembang ke arah pendekatan keluarga sebagai satu kesatuan sistem yang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan anggota-anggotanya. Keluarga dipandang sebagai unit dasar dalam masyarakat yang berperan penting dalam pencegahan penyakit, promosi kesehatan, perawatan, serta pemulihan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keperawatan keluarga menjadi hal yang sangat esensial bagi setiap perawat profesional.

Buku ajar ini disusun dengan mengacu pada kurikulum pendidikan keperawatan terkini dan mengintegrasikan berbagai referensi ilmiah yang relevan dan mutakhir. Materi dalam buku ini mencakup landasan teori keperawatan keluarga, model-model pendekatan asuhan keperawatan berbasis keluarga, penilaian terhadap keluarga, hingga strategi intervensi dalam berbagai kondisi kesehatan dan dinamika keluarga. Diharapkan, buku ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan aplikatif dalam penerapan keperawatan keluarga di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, baik di komunitas maupun di fasilitas kesehatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari keterbatasan, baik dalam hal ruang lingkup pembahasan maupun kedalaman materi. Namun demikian, besar harapan kami agar buku ini dapat menjadi pijakan awal yang kokoh bagi mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar serta peran perawat dalam konteks keluarga. Kami juga berharap agar buku ini dapat memotivasi pengembangan pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut melalui kajian literatur tambahan, diskusi ilmiah, dan pengalaman praktik lapangan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih khusus disampaikan kepada rekan sejawat, tim pengajar, serta mahasiswa yang telah memberikan masukan dan inspirasi selama proses penulisan berlangsung.

Akhir kata, semoga buku ajar "Keperawatan Keluarga" ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi dunia pendidikan keperawatan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna menyempurnakan edisi-edisi berikutnya.

Penulis

Mei, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	v
------------------------	----------

BAB 1 KONSEP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (PRIMARY HEALTH CARE/PHC)	1
--	----------

A. Pelayanan Kesehatan Primer	4
B. Penerapan Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia	19
C. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)	23
D. Latihan Soal	27
E. Rangkuman Materi	29
F. Glosarium.....	31
G. Daftar Pustaka.....	32

BAB 2 KONSEP KOMUNITAS	36
-------------------------------------	-----------

A. Keperawatan Komunitas.....	39
B. Struktur dan Dinamika Komunitas	41
C. Peran Perawat dalam Komunitas	44
D. Tantangan dan Isu dalam Keperawatan Keluarga Berbasis Komunitas	46
E. Perkembangan Keperawatan Keluarga dalam Konteks Komunitas di Masa Depan.....	55
F. Latihan Soal	57
G. Rangkuman Materi	59
H. Glosarium.....	60
I. Daftar Pustaka.....	61

BAB 3 KONSEP KELUARGA	63
------------------------------------	-----------

A. Definisi Keluarga dalam Berbagai Perspektif.....	66
B. Peran dan Fungsi Keluarga dalam Masyarakat	67
C. Perkembangan Konsep Keluarga dari Waktu ke Waktu.....	68
D. Perspektif Teoretis tentang Keluarga	69
E. Bentuk dan Struktur Keluarga	70
F. Dinamika dan Interaksi dalam Keluarga	72
G. Perubahan Sosial dan Implikasinya terhadap Keluarga.....	73

H. Nilai, Norma, dan Budaya dalam Keluarga	74
I. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Keluarga	74
J. Kebijakan dan Dukungan Sosial untuk Keluarga.....	75
K. Masa Depan Keluarga	76
L. Latihan Soal	77
M. Rangkuman Materi	79
N. Glosarium.....	80
O. Daftar Pustaka.....	82
 BAB 4 MODEL KONSEPTUAL KEPERAWATAN KELUARGA	87
A. Pengantar Model Konseptual Keperawatan Keluarga.....	89
B. Model Friedman.....	90
C. Calgary Family Assessment Model (CFAM)	92
D. Model McGill.....	95
E. Model Bio-Psiko-Sosial-Spiritual	95
F. Teori Sistem Keluarga dan Model Struktural-Fungsional	96
G. Latihan Soal	96
H. Rangkuman Materi	97
I. Glosarium.....	98
J. Daftar Pustaka.....	98
 BAB 5 MANAJEMEN SUMBER DAYA KELUARGA.....	99
A. Konsep Dasar Sumber Daya Keluarga	102
B. Klasifikasi Sumber Daya Keluarga.....	102
C. Penggunaan Sumber Daya Keluarga.....	105
D. Cara Mengukur Sumber Daya Keluarga.....	107
E. Pengertian Manajemen Sumber Daya Keluarga.....	108
F. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Sumber Daya Keluarga.....	109
G. Sistem/Proses Manajemen Sumber Daya Keluarga	110
H. Sifat Manajemen Sumber Daya Keluarga.....	114
I. Latihan Soal	116
J. Rangkuman Materi	119
K. Glosarium.....	121
L. Daftar Pustaka.....	122

BAB 6 PENGKAJIAN KEPERAWATAN KELUARGA	123
A. Pengkajian Keperawatan Keluarga.....	125
B. Sumber Data Pengkajian Keluarga.....	125
C. Alat Pengkajian Keluarga	126
D. Model Pengkajian Keluarga Friedman.....	131
E. Latihan Soal	145
F. Rangkuman Materi	147
G. Glosarium.....	148
H. Daftar Pustaka.....	148
 BAB 7 TINDAKAN KEPERAWATAN KELUARGA.....	 149
A. Intervensi dan Tindakan Keperawatan.....	151
B. Tindakan Keperawatan dalam Mencapai 5 Tugas Kesehatan Keluarga.....	160
C. Soal Latihan	162
D. Rangkuman Materi	164
E. Glosarium.....	164
F. Daftar Pustaka.....	165
 BAB 8 TREN DAN ISSUE KEPERAWATAN KELUARGA	 167
A. Perubahan Tren dalam Keperawatan Keluarga.....	169
B. Isu-Isu Kontemporer Dalam Keperawatan Keluarga.....	171
C. Implikasi terhadap Praktik Keperawatan Keluarga	174
D. Latihan Soal	176
E. Rangkuman Materi	178
F. Glosarium.....	179
G. Daftar Pustaka.....	182
 PROFIL PENULIS	 183

BAB 1

KONSEP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (PRIMARY HEALTH CARE/PHC)

Tujuan Instruksional

1. Menjelaskan Pengertian Pelayanan Kesehatan Primer
2. Menyebutkan Tujuan Pelayanan Kesehatan Primer
3. Menguraikan Komponen Pelayanan Kesehatan Primer
4. Menjelaskan Karakteristik Pelayanan Kesehatan Primer
5. Menyebutkan Manfaat Pelayanan Kesehatan Primer Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan
6. Menjelaskan Pelayanan Kesehatan Primer/PHC dan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)
7. Menjelaskan Penerapan Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia
8. Menjelaskan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)

Capaian Pembelajaran

Mampu menerapkan konsep pelayanan kesehatan primer dalam asuhan keperawatan keluarga dengan baik.

1. Mampu mengintegrasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan (arti, tujuan, komponen, karakteristik, dan manfaat) pelayanan kesehatan primer asuhan keperawatan keluarga.
2. Mampu menerapkan pelayanan kesehatan primer dalam konteks pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD) dengan fokus pada keluarga
3. Mampu mempraktikkan integrasi pelayanan kesehatan primer dalam melaksanakan asuhan keperawatan keluarga.

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan primer atau *primary health care* (PHC) merupakan landasan awal yang penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Banyak studi telah membuktikan peran PHC sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang memberikan manfaat dari segi efektivitas, efisiensi, dan biaya pelayanan kesehatan. Pada Deklarasi Alma-Ata tahun 1978, *World Health Organization* (WHO) mendeklarasi bahwa pelayanan kesehatan primer adalah kunci untuk pencapaian tujuan "kesehatan

untuk semua" (*health for all/HFA*). Deklarasi ini disepakati oleh 140 negara (termasuk Indonesia) dan menjadi tonggak utama bidang kesehatan masyarakat. Deklarasi Alma Ata menyerukan gerakan PHC di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Deklarasi ini menegaskan bahwa akses ke layanan kesehatan dasar adalah hak asasi manusia yang fundamental.

Fakta-fakta yang melandasi pentingnya PHC, diantaranya lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia berisiko jatuh ke dalam kemiskinan karena pengeluaran kesehatan mandiri sebesar 10% atau lebih dari anggaran rumah tangga mereka, peningkatan intervensi pelayanan kesehatan primer (PHC) di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat menyelamatkan 60 juta jiwa dan meningkatkan harapan hidup rata-rata hingga 3,7 tahun pada tahun 2030, mayoritas intervensi penting (90%) untuk cakupan kesehatan universal dapat diberikan menggunakan pendekatan PHC, dan diperkirakan 75% dari keuntungan kesehatan yang diproyeksikan dari tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui pelayanan kesehatan primer.

Negara-negara anggota telah berkomitmen untuk pembaruan dan implementasi pelayanan kesehatan primer sebagai landasan sistem kesehatan berkelanjutan untuk *Universal Health Coverage* (UHC), Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). PHC menyediakan mesin programatik untuk UHC, SDGs terkait kesehatan, dan keamanan kesehatan. Komitmen ini telah dikodifikasi dan ditegaskan kembali dalam Deklarasi Astana, Resolusi Majelis Kesehatan Dunia yang menyertainya, Laporan Pemantauan Global tentang UHC, dan deklarasi tingkat tinggi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang UHC.

PHC merupakan pendekatan yang paling inklusif, adil, hemat biaya, dan efisien untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat, serta kesejahteraan sosial. Bukti dampak investasi yang luas dalam PHC terus bertambah di seluruh dunia, terutama di masa krisis seperti pandemi COVID-19. Di seluruh dunia, investasi dalam PHC meningkatkan pemerataan dan akses, kinerja pelayanan kesehatan, akuntabilitas sistem kesehatan, dan hasil kesehatan. Meskipun beberapa faktor ini terkait langsung dengan sistem kesehatan dan akses ke layanan kesehatan, bukti menunjukkan bahwa berbagai faktor di luar layanan kesehatan memainkan peran penting dalam membentuk kesehatan dan kesejahteraan. Faktor-faktor ini meliputi perlindungan sosial, sistem pangan, pendidikan, dan faktor lingkungan, antara lain. PHC juga penting untuk membuat sistem kesehatan lebih tangguh menghadapi situasi krisis, lebih proaktif dalam mendeteksi tanda-tanda awal epidemi, dan lebih siap bertindak dini dalam menanggapi lonjakan permintaan layanan. PHC diakui sebagai pintu depan sistem kesehatan dan menyediakan dasar untuk memperkuat fungsi kesehatan masyarakat yang penting untuk menghadapi berbagai masalah kesehatan masyarakat.

WHO mendorong negara-negara untuk mengubah orientasi sistem kesehatan mereka menuju PHC sebagai cara utama untuk mencapai UHC dan SDGs, dan keamanan kesehatan. Sistem kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan konteks, dan sesuai dengan tujuan. Penguatan sistem kesehatan melibatkan penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan; tenaga kesehatan; gender, kesetaraan, dan hak; sistem informasi; kualitas dan keselamatan pasien, kesehatan ibu, bayi baru lahir, anak, dan remaja hingga usia lanjut yang sehat; kesehatan seksual dan reproduksi; obat-obatan dan perlengkapan medis; kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan darurat; penanganan penyakit menular dan tidak menular, dan lain-lain.

Pada ulang tahun keempat puluh Deklarasi Alma-Ata, peserta Konferensi Global tentang Pelayanan Kesehatan Primer yang diselenggarakan di Astana, Kazakhstan pada tanggal 25 dan 26 Oktober 2018 mengeluarkan Deklarasi Astana yang menegaskan kembali komitmen yang diungkapkan dalam Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 dan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dalam mengejar “Kesehatan untuk Semua”. Dengan melakukan hal itu, mereka berkomitmen untuk membuat pilihan politik yang berani untuk kesehatan di semua sektor, membangun pelayanan kesehatan primer yang berkelanjutan, memberdayakan individu dan masyarakat dan menyelaraskan dukungan pemangku kepentingan terhadap kebijakan, strategi, dan rencana nasional, yaitu melalui pengetahuan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk kesehatan, teknologi, dan pembiayaan.

Uraian Materi

A. Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan Kesehatan Primer atau *Primary Health Care* (PHC) telah berulang kali ditafsirkan dan didefinisikan selama bertahun-tahun sejak tahun 1978.

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan Kesehatan Primer atau *Primary Health Care* (PHC) adalah pelayanan kesehatan yang penting, didasarkan pada metode dan teknologi yang praktis, ilmiah, dan dapat diterima secara sosial, yang dapat diakses secara universal oleh individu dan keluarga di masyarakat, melalui partisipasi penuh mereka dan dengan biaya yang dapat ditanggung oleh masyarakat dan negara pada setiap tahap perkembangan mereka dalam semangat kemandirian dan penentuan nasib sendiri (WHO, 1978). Pelayanan ini merupakan bagian integral dari sistem kesehatan negara, yang merupakan fungsi dan fokus utama dari keseluruhan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pelayanan ini merupakan tingkat kontak pertama antara individu, keluarga, dan masyarakat dengan sistem kesehatan yang membawa pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan tempat tinggal dan tempat kerja orang-orang, dan merupakan elemen pertama dari proses pelayanan kesehatan berkelanjutan.

PHC merupakan pendekatan kesehatan menyeluruh yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin dan distribusinya yang adil dengan berfokus pada kebutuhan masyarakat dan sedini mungkin sepanjang rangkaian dari promosi kesehatan dan pencegahan penyakit hingga pengobatan, rehabilitasi dan perawatan paliatif, dan sedekat mungkin dengan lingkungan sehari-hari masyarakat. (WHO dan UNICEF).

WHO telah mengidentifikasi tiga bidang kerja strategis untuk memperkuat PHC di seluruh dunia: 1) Menyediakan mekanisme 'satu atap' untuk dukungan implementasi PHC bagi negara anggota, yang disesuaikan dengan konteks dan prioritas negara, termasuk menerapkan kerangka kerja operasional, membangun sistem kesehatan berbasis PHC yang lebih baik. Fungsi inti ini didorong oleh dan dibangun berdasarkan pekerjaan dan pengalaman yang ada dari negara dan kawasan di seluruh dunia, 2) Menghasilkan bukti dan inovasi yang berorientasi pada PHC, dengan fokus yang lebih tajam pada orang-orang yang tertinggal. Hal ini didasarkan pada bukti implementasi yang ada, panduan praktik terbaik dan solusi implementasi, keahlian dari negara-negara yang berhasil, dan literatur untuk mendorong solusi inovatif. dan 3) Mempromosikan pembaruan PHC melalui kepemimpinan kebijakan, advokasi, dan kemitraan strategis dengan pemerintah, organisasi nonpemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra

pembangunan, badan-badan PBB, donor, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat global, regional, dan negara.

John H. Bryant dan Julius B. Richmond (2017) mengemukakan bahwa Pelayanan Kesehatan Primer adalah pelayanan kesehatan penting, yang dapat diakses secara universal oleh individu dan keluarga di masyarakat melalui cara yang dapat diterima oleh mereka, melalui partisipasi penuh mereka dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat dan negara. Pelayanan kesehatan primer merupakan bagian integral dari sistem kesehatan negara yang menjadi intinya dan dari keseluruhan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. PHC merupakan pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang dapat diterima secara umum oleh individu, keluarga dan masyarakat melalui partisipasi mereka sepenuhnya, serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri dan menentukan nasib sendiri. Dari beberapa pengertian diatas, maka Pelayanan Kesehatan Primer/PHC:

- a. Menggambarkan keadaan sosial ekonomi, budaya dan politik masyarakat dan berdasarkan penerapan hasil penelitian kesehatan-sosial-biomedis dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Ditujukan untuk mengatasi masalah utama kesehatan masyarakat dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- c. Minimal mencakup: penyuluhan tentang masalah kesehatan utama dan cara pencegahan dan pengendaliannya, penyediaan makanan dan peningkatan gizi, penyediaan sanitasi dasar dan air bersih, pembinaan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, imunisasi terhadap penyakit menular utama dan penyegahan penyakit endemik, pengobatan penyakit umum dan cedera serta penediaan obat esensial.
- d. Melibatkan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor dan aspek-aspek pembangunan nasional dan masyarakat di samping sektor kesehatan, terutama pertanian, peternakan, industri makanan, pendidikan, penerangan, agama, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan dan sebagainya.
- e. Membutuhkan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri serta masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian PHC serta penggunaan sumberdaya yang ada.
- f. Ditunjang oleh sistem rujukan upaya kesehatan secara terpadu, fungsional dan timbal balik guna memberikan pelayanan secara menyeluruh, dengan memprioritaskan golongan masyarakat yang paling membutuhkan.

- g. Didukung oleh tenaga kesehatan professional dan masyarakat, termasuk tenaga kesehatan tradisional yang terlatih di bidang teknis dan sosial untuk bekerja sebagai tim kesehatan yang mampu bekerja bersama masyarakat dan membangunkan peran serta masyarakat.

Dengan demikian, pelayanan kesehatan primer merupakan pelayanan kesehatan esensial yang dibuat dan bisa terjangkau secara universal oleh individu dan keluarga di masyarakat. Fokus dari pelayanan kesehatan primer luas jangkauannya dan merangkum berbagai aspek masyarakat dan kebutuhan kesehatan. PHC merupakan pola penyajian pelayanan kesehatan dimana konsumen pelayanan kesehatan menjadi mitra dengan profesi dan ikut serta mencapai tujuan umum kesehatan yang lebih baik.

2. Tujuan Pelayanan Kesehatan Primer

Tujuan utama Pelayanan Kesehatan Primer atau *Primary Health Care/PHC* adalah untuk memastikan bahwa seluruh individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan esensial yang diperlukan, tanpa mengalami kesulitan finansial. PHC merupakan pendekatan mendasar untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. (WHO, 1978). Berikut adalah beberapa tujuan utama PHC:

a. Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Kesehatan

Menjamin bahwa semua orang, termasuk kelompok rentan, memiliki akses terhadap layanan kesehatan esensial.

b. Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Memberikan pendidikan kesehatan, promosi gaya hidup sehat, dan pencegahan penyakit melalui vaksinasi, skrining dini, serta deteksi risiko kesehatan.

c. Menyediakan Layanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

Menyediakan layanan yang komprehensif meliputi pengobatan umum, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.

d. Penguatan Komunitas

Melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan, sehingga program lebih relevan dengan kebutuhan lokal.

e. Efisiensi Biaya

Mengurangi biaya kesehatan melalui pencegahan penyakit dan pengobatan dini, sehingga dapat mengurangi kebutuhan layanan kesehatan sekunder dan tersier.

f. Koordinasi Lintas Sektor

Mengintegrasikan upaya kesehatan dengan sektor lain seperti pendidikan, sanitasi, dan lingkungan untuk meningkatkan determinan kesehatan secara keseluruhan.

g. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

PHC menjadi komponen penting dalam mencapai tujuan SDG, yakni memastikan kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan untuk semua usia.

3. Komponen Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan primer menerapkan paradigma sehat sebagai dasar upaya strategik bagi pencapaian sehat untuk semua (*health for all*) dan semua untuk sehat (*all to health*). Penanganan pasien harus dilakukan dengan pendekatan *people-centered* (biopsikososio-kultural), berdasarkan keluhan fisik, mental, dan rohani, serta ikut mempertimbangkan kehidupan sekitar yang mempengaruhi hidup dan penyakit pasien. Pendekatan tersebutlah yang membedakan pelayanan kesehatan primer/PHC dengan pelayanan kesehatan spesialis di tingkat lanjutan. Dalam pelaksanaannya, PHC menggunakan pendekatan komprehensif, yaitu upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan dari penyakit, serta perawatan paliatif.

Pendekatan yang dilakukan PHC mencakup tiga komponen (WHO & UNICEF, 1978. *Declaration of Alma-Ata*. Geneva. yaitu:

a. Memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar/primer kepada seluruh lapisan masyarakat (*health for all*),

PHC menekankan akses universal terhadap pelayanan kesehatan esensial yang terjangkau, relevan, dan berbasis masyarakat sebagai landasan sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. PHC menuju *health for all*, memiliki makna untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lokasi geografis, memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar yang memadai. Sebagai contoh diterapkannya program kesehatan masyarakat seperti UHC.

b. Memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat untuk ikut serta bertanggungjawab terhadap kesehatan diri (*all for health*)

All for health memiliki makna, bahwa kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan saja, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari semua sektor masyarakat, termasuk individu, komunitas, dan sektor swasta. Konsep yang mendasarinya adalah pendekatan holistik dan lintas sektor untuk memastikan tercapainya kesehatan optimal melalui kontribusi bersama.

c. Melibatkan kerjasama lintas sektoral.

Kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh layanan kesehatan, tetapi juga oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor.

1) Determinan Sosial Kesehatan

Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pendidikan, pekerjaan, lingkungan, perumahan, dan infrastruktur. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan pemangku kepentingan dari berbagai bidang untuk mengatasi akar penyebab masalah kesehatan, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketidaksetaraan sosial.

2) Penggunaan Sumber Daya yang Lebih Efisien

Kerja sama lintas sektor memungkinkan penggabungan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi untuk menghindari duplikasi dan memastikan efisiensi dalam intervensi kesehatan.

3) Pendekatan Holistik

Isu kesehatan sering kali kompleks dan membutuhkan pendekatan multidimensional. Misalnya, untuk mengurangi tingkat obesitas, diperlukan kerja sama sektor kesehatan dengan sektor pendidikan (program edukasi gizi), sektor transportasi (promosi penggunaan sepeda), dan sektor pangan (penyediaan makanan sehat).

4) Keterpaduan Kebijakan

Kebijakan kesehatan yang efektif memerlukan harmonisasi dengan kebijakan di bidang lain, seperti kebijakan lingkungan, ketenagakerjaan, dan pembangunan ekonomi, untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.

5) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kerja sama lintas sektor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan menciptakan sinergi dalam kampanye dan program yang menyangkut kesehatan masyarakat.

4. Karakteristik Pelayanan Kesehatan Primer

Berikut adalah uraian mengenai karakteristik pelayanan kesehatan primer (WHO, 1978):

a. Aksesibilitas (*Accessibility*)

Pelayanan kesehatan primer dirancang untuk mudah diakses oleh masyarakat tanpa hambatan geografis, ekonomi, atau sosial.

b. Komprehensivitas (*Comprehensiveness*)

PHC mencakup berbagai layanan seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

c. Kontinuitas (*Continuity*)

Pelayanan yang berkesinambungan, memastikan bahwa pasien dapat mengikuti perawatan jangka panjang sesuai kebutuhannya.

d. Koordinasi (*Coordination*)

PHC bertindak sebagai penghubung antara pasien dengan layanan kesehatan sekunder atau tersier, memastikan pengelolaan rujukan yang efektif.

e. Berorientasi pada komunitas (*Community-Oriented*)

Pelayanan PHC dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik komunitas setempat, dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi layanan.

f. Berpusat pada pasien (*Patient-Centered*)

Menempatkan pasien sebagai fokus utama, dengan mempertimbangkan nilai, preferensi, dan budaya pasien.

5. Manfaat Pelayanan Kesehatan Primer dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan primer atau PHC dinilai dapat memberikan manfaat dalam menurunkan pengeluaran biaya kesehatan, memberikan akses ke pelayanan kesehatan yang lebih tepat, dan memberikan pelayanan kesehatan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan alasan tersebut, WHO mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi dalam rangka memperkuat PHC dalam sistem pelayanan kesehatan.

a. PHC berperan penting dalam mencapai SDGs di bidang kesehatan

Berperan penting dalam mencapai SDGs di bidang kesehatan dengan adanya upaya kesehatan esensial yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana (KIA-KB), pelayanan gizi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P).

b. Akses Pelayanan Kesehatan ke Seluruh Lapisan Masyarakat

PHC memastikan bahwa layanan kesehatan primer memungkinkan setiap orang menggunakan hak mereka untuk sehat, yaitu dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata (*equitable access to health care*) ke seluruh lapisan masyarakat. Akses terhadap PHC didukung dengan adanya jaminan kesehatan nasional di masing-masing negara, sebagai bagian dari program WHO yaitu UHC. UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, bermutu, dan dengan biaya terjangkau.

c. Pelayanan Kesehatan Berkesinambungan

PHC menyediakan pelayanan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dengan membina hubungan yang erat

dan setara antara dokter dengan pasien. Terjalannya pelayanan yang berkelanjutan (*continuity of care*) terbukti dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan pasien, meningkatkan efisiensi waktu konsultasi, serta secara signifikan menurunkan kunjungan pasien ke spesialis maupun ke unit gawat darurat (UGD), baik atas kemauan sendiri maupun keperluan rujukan. Menurut studi, dibutuhkan minimal 2 tahun *continuity of care* untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada setiap pasien. Pasien yang memiliki relasi dengan tenaga kesehatan PHC akan mendapatkan pelayanan preventif yang lebih baik. Masalah/penyakit pasien akan lebih dimengerti/dikenali dengan diagnosis yang lebih akurat, penggunaan tes diagnostik dan obat-obatan menjadi lebih sedikit, tingkat rawat inap dan kunjungan UGD yang lebih rendah, dan pengeluaran biaya kesehatan yang lebih kecil.

d. Biaya Kesehatan

PHC bergerak dalam upaya promotif dan preventif untuk mencapai kesehatan fisik, mental, dan sosial setiap orang sepanjang hidupnya, sehingga PHC dapat menekan biaya kesehatan untuk pengobatan penyakit-penyakit yang dapat dicegah. PHC berupaya untuk manajemen kasus secara paripurna sesuai kompetensinya, sehingga menurunkan angka rujukan kasus non spesialisik yang tidak perlu/tidak tepat yang berimbas pada pengeluaran dana berlebih.

e. Pencegahan dan Manajemen Penyakit

PHC dengan fungsinya yang bersifat preventif meliputi edukasi menyusui, aktivitas fisik (olah raga), asupan makanan sehat dan bergizi, edukasi untuk tidak merokok, termasuk edukasi dampak merokok pada sistem kardiovaskular, bahaya merokok pada wanita, termasuk juga edukasi penggunaan sabuk pengaman saat berkendara.

f. Luaran Status Kesehatan Masyarakat

Luaran (*outcome*) status kesehatan masyarakat (rentang hidup dan mortalitas). Hasil studi menunjukkan bahwa daerah dengan rasio tenaga kesehatan per penduduk yang lebih tinggi, memiliki status kesehatan yang lebih baik, memiliki rentang hidup yang lebih panjang dan mortalitas yang lebih rendah.

6. Komponen Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan primer menerapkan paradigma sehat sebagai dasar upaya strategik bagi pencapaian sehat untuk semua (*health for all*) dan semua untuk sehat (*all to health*). Penanganan pasien harus dilakukan dengan pendekatan *people-centered* (biopsikososio-kultural), berdasarkan keluhan fisik, mental, dan rohani, serta ikut mempertimbangkan kehidupan sekitar yang mempengaruhi hidup dan penyakit pasien. Pendekatan tersebutlah yang membedakan pelayanan kesehatan primer/PHC dengan pelayanan kesehatan

spesialistik di tingkat lanjutan. Dalam pelaksanaannya, PHC menggunakan pendekatan komprehensif, yaitu upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan dari penyakit, serta perawatan paliatif.

Pendekatan yang dilakukan PHC mencakup tiga komponen (WHO & UNICEF, 1978. *Declaration of Alma-Ata*. Geneva. yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar/primer kepada seluruh lapisan masyarakat (*health for all*),

PHC menekankan akses universal terhadap pelayanan kesehatan esensial yang terjangkau, relevan, dan berbasis masyarakat sebagai landasan sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. PHC menuju *health for all*, memiliki makna untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lokasi geografis, memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar yang memadai. Sebagai contoh diterapkannya program kesehatan masyarakat seperti UHC.

- b. Memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat untuk ikut serta bertanggungjawab terhadap kesehatan diri (*all for health*)

All for health memiliki makna, bahwa kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan saja, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari semua sektor masyarakat, termasuk individu, komunitas, dan sektor swasta. Konsep yang mendasarinya adalah pendekatan holistik dan lintas sektor untuk memastikan tercapainya kesehatan optimal melalui kontribusi bersama.

- c. Melibatkan kerjasama lintas sektoral.

Kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh layanan kesehatan, tetapi juga oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor.

1) Determinan Sosial Kesehatan

Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pendidikan, pekerjaan, lingkungan, perumahan, dan infrastruktur. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan pemangku kepentingan dari berbagai bidang untuk mengatasi akar penyebab masalah kesehatan, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketidaksetaraan sosial.

2) Penggunaan Sumber Daya yang Lebih Efisien

Kerjasama lintas sektor memungkinkan penggabungan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi untuk menghindari duplikasi dan memastikan efisiensi dalam intervensi kesehatan.

3) Pendekatan Holistik

Isu kesehatan sering kali kompleks dan membutuhkan pendekatan multidimensional. Misalnya, untuk mengurangi tingkat obesitas, diperlukan kerja sama sektor kesehatan dengan sektor pendidikan (program edukasi gizi), sektor transportasi (promosi penggunaan sepeda), dan sektor pangan (penyediaan makanan sehat).

4) Keterpaduan Kebijakan

Kebijakan kesehatan yang efektif memerlukan harmonisasi dengan kebijakan di bidang lain, seperti kebijakan lingkungan, ketenagakerjaan, dan pembangunan ekonomi, untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.

5) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kerja sama lintas sektor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan menciptakan sinergi dalam kampanye dan program yang menyangkut kesehatan masyarakat.

7. Karakteristik Pelayanan Kesehatan Primer

Berikut adalah uraian mengenai karakteristik pelayanan kesehatan primer (WHO, 1978):

a. Aksesibilitas (*Accessibility*)

Pelayanan kesehatan primer dirancang untuk mudah diakses oleh masyarakat tanpa hambatan geografis, ekonomi, atau sosial.

b. Komprehensivitas (*Comprehensiveness*)

PHC mencakup berbagai layanan seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

c. Kontinuitas (*Continuity*)

Pelayanan yang berkesinambungan, memastikan bahwa pasien dapat mengikuti perawatan jangka panjang sesuai kebutuhannya.

d. Koordinasi (*Coordination*)

PHC bertindak sebagai penghubung antara pasien dengan layanan kesehatan sekunder atau tersier, memastikan pengelolaan rujukan yang efektif.

e. Berorientasi pada komunitas (*Community-Oriented*)

Pelayanan PHC dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik komunitas setempat, dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi layanan.

f. Berpusat pada pasien (*Patient-Centered*)

Menempatkan pasien sebagai fokus utama, dengan mempertimbangkan nilai, preferensi, dan budaya pasien.

8. Manfaat Pelayanan Kesehatan Primer dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan primer atau PHC dinilai dapat memberikan manfaat dalam menurunkan pengeluaran biaya kesehatan, memberikan akses ke

pelayanan kesehatan yang lebih tepat, dan memberikan pelayanan kesehatan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan alasan tersebut, WHO mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi dalam rangka memperkuat PHC dalam sistem pelayanan kesehatan.

a. PHC berperan penting dalam mencapai SDGs di bidang kesehatan

Berperan penting dalam mencapai SDGs di bidang kesehatan dengan adanya upaya kesehatan esensial yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana (KIA-KB), pelayanan gizi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P).

b. Akses Pelayanan Kesehatan ke Seluruh Lapisan Masyarakat

PHC memastikan bahwa layanan kesehatan primer memungkinkan setiap orang menggunakan hak mereka untuk sehat, yaitu dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata (*equitable access to health care*) ke seluruh lapisan masyarakat. Akses terhadap PHC didukung dengan adanya jaminan kesehatan nasional di masing-masing negara, sebagai bagian dari program WHO yaitu UHC. UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, bermutu, dan dengan biaya terjangkau.

c. Pelayanan Kesehatan Berkesinambungan

PHC menyediakan pelayanan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dengan membina hubungan yang erat dan setara antara dokter dengan pasien. Terjalinnya pelayanan yang berkelanjutan (*continuity of care*) terbukti dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan pasien, meningkatkan efisiensi waktu konsultasi, serta secara signifikan menurunkan kunjungan pasien ke spesialis maupun ke unit gawat darurat (UGD), baik atas kemauan sendiri maupun keperluan rujukan. Menurut studi, dibutuhkan minimal 2 tahun *continuity of care* untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada setiap pasien. Pasien yang memiliki relasi dengan tenaga kesehatan PHC akan mendapatkan pelayanan preventif yang lebih baik. Masalah/penyakit pasien akan lebih dimengerti/dikenali dengan diagnosis yang lebih akurat, penggunaan tes diagnostik dan obat-obatan menjadi lebih sedikit, tingkat rawat inap dan kunjungan UGD yang lebih rendah, dan pengeluaran biaya kesehatan yang lebih kecil.

d. Biaya Kesehatan

PHC bergerak dalam upaya promotif dan preventif untuk mencapai kesehatan fisik, mental, dan sosial setiap orang sepanjang hidupnya, sehingga PHC dapat menekan biaya kesehatan untuk pengobatan penyakit-penyakit yang dapat dicegah. PHC berupaya untuk manajemen kasus secara paripurna sesuai

kompetensinya, sehingga menurunkan angka rujukan kasus non spesialisistik yang tidak perlu/tidak tepat yang berimbas pada pengeluaran dana berlebih.

e. Pencegahan dan Manajemen Penyakit

PHC dengan fungsinya yang bersifat preventif meliputi edukasi menyusui, aktivitas fisik (olah raga), asupan makanan sehat dan bergizi, edukasi untuk tidak merokok, termasuk edukasi dampak merokok pada sistem kardiovaskular, bahaya merokok pada wanita, termasuk juga edukasi penggunaan sabuk pengaman saat berkendara.

f. Luaran Status Kesehatan Masyarakat

Luaran (*outcome*) status kesehatan masyarakat (rentang hidup dan mortalitas). Hasil studi menunjukkan bahwa daerah dengan rasio tenaga kesehatan per penduduk yang lebih tinggi, memiliki status kesehatan yang lebih baik, memiliki rentang hidup yang lebih panjang dan mortalitas yang lebih rendah.

9. Pelayanan Kesehatan Primer/PHC dan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)

Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) merupakan cikal bakal dan sebagai bentuk operasional dari PHC di Indonesia, yang dicetuskan pada tahun 1980-an. PKMD dan PHC menjadi tonggak penting dalam pendekatan kesehatan berbasis masyarakat untuk mencapai pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau. PKMD bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan mereka sendiri melalui partisipasi aktif dan pendekatan yang terintegrasi dengan kebutuhan lokal. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program, seperti Posyandu, program imunisasi, dan peningkatan akses ke fasilitas kesehatan di tingkat desa. PKMD berlandaskan pada pendekatan PHC yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan.

a. Pengertian PKMD

PKMD merupakan suatu pendekatan pembangunan kesehatan yang berbasis masyarakat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan mereka secara aktif dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program-program kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. PKMD merupakan bentuk operasional dari PHC yang menekankan partisipasi masyarakat, penggunaan sumber daya lokal, dan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dalam menjaga kesehatan. (Depkes RI. 1984)

Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) adalah bentuk operasional dari PHC di Indonesia. PKMD mencakup serangkaian kegiatan swadaya masyarakat berazaskan gotong royong, yang didukung oleh pemerintah

melalui koordinasi lintas sektoral dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan atau yang terkait dengan kesehatan, agar masyarakat dapat hidup sehat guna mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik. PKMD adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar gotong royong dan swadaya dalam rangka menolong diri sendiri dalam memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhannya dibidang kesehatan dan dibidang lain yang berkaitan agar mampu mencapai kehidupan sehat sejahtera.

b. Tujuan PKMD

Departemen Kesehatan RI. (1984) mengemukakan tujuan dari PKMD adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

PKMD secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu hidup.

2) Tujuan Khusus

Secara khusus PKMD bertujuan untuk:

- a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya untuk menolong diri mereka sendiri dalam meningkatkan mutu hidup mereka.
- b) Mengembangkan kemampuan dan prakarsa masyarakat untuk berperan secara aktif dan berswadaya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
- c) Menghasilkan lebih banyak tenaga – tenaga masyarakat setempat yang mampu, terampil serta mau berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa.
- d) Meningkatkan kesehatan masyarakat dalam arti memenuhi beberapa indikator, seperti angka kesakitan menurun, angka kematian menurun terutama angka Kematian ibu, bayi dan anak, angka kelahiran menurun serta angka kekurangan gizi pada anak balita menurun.

c. Ciri Utama PKMD

Depkes RI, (1990) mengemukakan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat desa memiliki ciri, yaitu:

1) Berbasis Masyarakat

Masyarakat menjadi pelaku utama, bukan hanya sebagai penerima manfaat, mengandung arti kegiatan dan programnya dirancang untuk melibatkan masyarakat secara aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. PKMD memanfaatkan sumber daya lokal, baik manusia, alam, maupun sosial-budaya, untuk mendukung upaya peningkatan

kesehatan, sebagai contoh adalah penggunaan kader kesehatan desa yang berasal dari masyarakat setempat untuk mendidik dan memberikan layanan kesehatan dasar.

2) Partisipasi Aktif

Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program, dari perencanaan hingga evaluasi. PKMD mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam mengidentifikasi masalah kesehatan di lingkungannya dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*), yang penting untuk keberlanjutan program. PKMD mencerminkan prinsip dasar PHC, yaitu memberikan akses kesehatan yang adil dan merata dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat serta keberlanjutan program melalui partisipasi aktif komunitas lokal. Hal ini juga selaras dengan komitmen global dalam Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput.

3) Berorientasi pada Kemandirian

PKMD berorientasi pada kemandirian, tujuannya adalah agar masyarakat mampu mengelola program kesehatan secara mandiri. PKMD dirancang berdasarkan musyawarah bersama antara masyarakat, perangkat desa, dan petugas kesehatan, mengedepankan pendekatan *bottom-up*, di mana keputusan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan instruksi dari tingkat pusat (*top-down*). PKMD tidak hanya fokus pada penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian mereka dalam menjaga kesehatan, sebagai contoh adalah pelatihan keterampilan sederhana untuk mencegah penyakit atau menangani masalah kesehatan ringan.

4) Penggunaan Sumber Daya Lokal

PKMD memanfaatkan potensi yang ada di desa, seperti tenaga, bahan, dan infrastruktur lokal. PKMD dikatakan berbasis masyarakat. PKMD memanfaatkan sumber daya lokal, baik manusia, alam, maupun sosial-budaya, untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan, sebagai contoh adalah penggunaan kader kesehatan desa yang berasal dari masyarakat setempat untuk mendidik dan memberikan layanan kesehatan dasar. PKMD bekerja sama dengan organisasi masyarakat, seperti Posyandu, PKK, atau kelompok tani, yang ada di desa, untuk memperkuat sistem kesehatan desa secara berkelanjutan.

5) Kerja Sama Lintas Sektor

PKMD melibatkan berbagai sektor, seperti pendidikan, pertanian, pekerjaan umum, dan lembaga sosial, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. PKMD juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan tokoh adat, dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. PKMD sering diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti Posyandu, promosi kesehatan berbasis komunitas, dan lain-lain. Konsep ini menjadi salah satu upaya penting untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih adil dan merata.

6) Upaya Kesehatan Dasar

PKMD mempunyai delapan upaya kesehatan dasar yang mencakup: 1) Pendidikan masyarakat tentang masalah kesehatan dan upaya penanggulangannya, 2) Pemberantasan dan pencegahan penyakit endemik setempat, 3) Program Imunisasi, 4) Kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, 5) Pengadaan obat esensial, 6) Pengadaan pangan dan gizi, 7) Pengobatan penyakit umum dan cedera, dan 8) Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan,

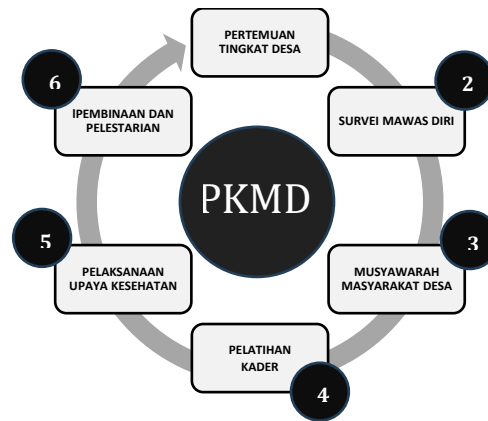
d. Prinsip Kegiatan PKMD

PKMD dalam melaksanakan kegiatannya dengan prinsip:

- 1) Kegiatan masyarakat sebaiknya dimulai dengan kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat walaupun kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan kesehatan secara langsung, kegiatan tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan saja, melainkan juga mencakup aspek- aspek kehidupan lainnya yang secara tidak langsung menunjang peningkatan taraf kesehatan.
- 2) Dalam membina kegiatan masyarakat diperlukan kerja sama yang baik antara dinas, instansi, lembaga lainnya yang bersangkutan dan antara dinas, instansi, lembaga tersebut dengan masyarakat.
- 3) Dalam keadaan dimana masyarakat tidak dapat memecahkan masalah atau kebutuhannya sendiri, maka pelayanan langsung diberikan oleh sektor yang bersangkutan.

e. Langkah PKMD

PKMD dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut :



Gambar.1 Langkah PKMD

1) Pertemuan Tingkat Desa

Langkah PKMD diawali dengan pengadakan pertemuan dengan tujuan terjadi pemahaman yang sama terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan berbasis atau bersumberdaya masyarakat. Kegiatan dilakukan berupa sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

2) Survei Mawas Diri (SMD)

Langkah berikutnya adalah melaksanakan survei mawas diri (SMD), atau melakukan asesmen/pengkajian terhadap seluruh populasi untuk menemukan masalah kesehatan dan memahami kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

3) Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

Jika data-data dan masalah telah diketahui, maka selanjutnya dilakukan musyawarah, dengan tujuan akhir disepakati pemecahan masalah dari berbagai dimensi, yang memungkinkan masyarakat mampu melakukannya.

4) Pelatihan Kader

Langkah berikutnya melakukan pelatihan kader, karena kader merupakan perpanjangan tangan petugas kesehatan sekaligus upaya pemberdayaan dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat di wilayahnya.

5) Pelaksanaan Upaya Kesehatan

Setelah kader di latih, selanjutnya kader bersama masyarakat di bawah bimbingan petugas kesehatan melakukan upaya-upaya kesehatan yang telah direncanakan dan disepakati dalam MMD.

6) Pembinaan dan PelestarianKegiatan

Pembinaan dan pelestarian kegiatan merupakan upaya yang dilakukan oleh petugas kesehatan maupun para pemangku kepentingan di wilayah supaya kegiatan yang telah berhasil dijalankan dapat terus dilakukan bahkan dikembangkan.

Strategi pembinaan PKMD dilakukan sebagai berikut:

- a. Tim pembina PKMD di masing-masing tingkat sekaligus dijadikan sebagai forum koordinasi dimasing-masing tingkat
- b. Setiap kegiatan partisipasi masyarakat yang akan dipromosikan oleh salah satu sektor, terlebih dahulu dibahas dalam forum koordinasi untuk memungkinkan bantuan dari sektor-sektor lain untuk menghindari tumpang tindih.
- c. Jenis bantuan apapun yang akan dijalankan harus selalu berdasarkan pada proporsi kebutuhan masyarakat setempat.
- d. Seluruh tahap kegiatan, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pembinaan sampai pada perluasan dilakukan oleh masyarakat sendiri dan di mana perlu dibantu oleh Pemerintah secara lintas program dan lintas sektoral.
- e. Wadah kegiatan PKMD adalah LKMD sesuai Surat Keputusan Presiden No. 28 tentang Penyempurnaan dan Penempatan Fungsi Lembaga Swadaya Desa menjadi LKMD. Maka pada dasarnya LKMD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- f. PKMD adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat. Pengembangan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu pendekatan, bukan program yang berdiri sendiri.

B. Penerapan Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia

Sejak Deklarasi Alma Ata tahun 1978, Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer atau *Primary Health Care* (PHC) sebagai landasan sistem kesehatan nasional. Beberapa kebijakan dan langkah yang telah diambil Indonesia dalam mewujudkan komitmen tersebut adalah:

1. Pendirian Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) didirikan sebagai ujung tombak layanan kesehatan primer di Indonesia. Puskesmas berperan sebagai kontak pertama individu, keluarga, atau masyarakat dengan sistem pelayanan kesehatan, menyediakan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebelum PHC di deklarasikan, di Indonesia Konsep Puskesmas dicetuskan pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) I tahun 1968 di Jakarta, Dimana berbagai layanan kesehatan diintegrasikan menjadi layanan kesehatan tingkat pertama yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri, seperti Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), Balai Pengobatan (BP), dan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (P4M), ke dalam satu organisasi bernama Puskesmas. Selanjutnya pada

Rakerkesnas III tahun 1970, dilakukan pembagian Puskesmas berdasarkan wilayah kerja. Pada tahun 1975 melalui Instruksi Presiden, ditetapkan pembangunan satu Puskesmas di setiap kecamatan untuk mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan.

Tahun 1984, dikembangkan program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana di Puskesmas, meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Gizi, Penanggulangan Diare, dan Imunisasi. Pada awal 1990-an, Puskesmas bertransformasi menjadi organisasi kesehatan fungsional yang berperan sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat serta memberdayakan peran serta masyarakat. Pada tahun 2014, diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menetapkan standar pelayanan, ketenagaan, dan sarana Puskesmas untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar, dan sampai saat ini, menurut laporan Kementerian Kesehatan tahun 2023, terdapat 10.180 Puskesmas di seluruh Indonesia, yang berperan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Program Indonesia Sehat

Puskesmas terus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Indonesia, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, seperti Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Program ini menekankan pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan dan mendorong upaya promotif serta preventif. Hal ini sejalan dengan prinsip PHC yang menekankan akses kesehatan yang mudah di tengah masyarakat.

PIS-PK adalah inisiatif Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga sebagai unit intervensi. Program ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, serta menekankan pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan. PIS-PK mulai dilaksanakan pada tahun 2016 di 9 provinsi, mencakup 64 kabupaten/kota dengan total 470 puskesmas prioritas. Pada tahun 2018, program ini diperluas ke lebih banyak puskesmas di seluruh Indonesia. Puskesmas diwajibkan mendata seluruh keluarga di wilayah kerjanya melalui kunjungan rumah yang terjadwal dan rutin. Evaluasi capaian indikator PIS-PK terus dilakukan untuk memastikan efektivitas programnya.

PIS-PK bertujuan meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif. Terdapat 12 indikator utama yang digunakan untuk menilai status kesehatan keluarga, yaitu: 1) Keluarga mengikuti program Keluarga

Berencana (KB), 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, 4) Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok, 10) Keluarga memiliki akses terhadap air bersih, 11) Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban sehat, dan 12) Keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Beberapa evaluasi menunjukkan bahwa PIS-PK telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat keluarga, namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan pemahaman masyarakat terhadap program ini masih perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal.

3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pelaksanaan JKN melalui BPJS Kesehatan memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan biaya. Dalam sistem ini, layanan kesehatan primer berfungsi sebagai *gatekeeper* yang menapis rujukan serta mengendalikan mutu dan biaya pelayanan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyediakan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk melalui mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib. Program ini bertujuan memastikan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya.

JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Program JKN resmi diluncurkan pada 1 Januari 2014, dengan target mencapai cakupan kesehatan semesta (*universal health coverage*) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun 2014, sekitar 48% populasi Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Jumlah ini meningkat menjadi 75% (195 juta orang) pada April 2018, dengan target mencakup seluruh populasi pada tahun 2019. JKN beroperasi berdasarkan prinsip gotong royong, di mana peserta yang mampu membantu yang kurang mampu, dan yang sehat membantu yang sakit, serta bermanfaat memberikan layanan kesehatan komprehensif yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk penyediaan obat dan bahan medis.

Sejak diluncurkan, JKN telah membawa perubahan signifikan dalam sistem kesehatan Indonesia dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya perbaikan terus dilakukan untuk memastikan program ini berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh penduduk Indonesia.

4. Deklarasi Astana

Pada pertemuan *Global Conference on Primary Health Care* di Astana, Kazakhstan, Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap PHC sebagai dasar untuk mencapai UHC dan SDGs 2030. Hal ini menunjukkan kontinuitas komitmen Indonesia sejak Deklarasi Alma Ata. UHC merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial. Konsep ini mencakup berbagai layanan kesehatan yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif. UHC bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. UHC menjadi salah satu elemen kunci dalam SDGs 2030, yang diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda pembangunan global. SDGs memiliki 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek pembangunan, dengan tujuan utamanya untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia pada tahun 2030.

Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (*Good Health and Well-being*), secara langsung mendukung UHC dengan memastikan akses yang merata ke layanan kesehatan, serta upaya untuk mengurangi kematian yang dapat dicegah, akses ke obat-obatan yang terjangkau, vaksin, dan layanan kesehatan dasar lainnya. Serta menjamin akses universal kepada layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta melindungi dari beban finansial akibat pengeluaran kesehatan yang besar. UHC memainkan peran penting dalam pencapaian SDGs, karena memastikan semua orang dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka perlukan tanpa mempengaruhi kualitas hidup mereka secara finansial, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

5. Transformasi Kesehatan

Transformasi kesehatan melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2023. ILP menjadi bagian integral dari transformasi kesehatan di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di tingkat primer. Transformasi kesehatan melalui integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan

upaya untuk memperkuat sistem kesehatan dengan fokus pada pelayanan yang komprehensif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, yang disesuaikan dengan siklus hidup individu.

C. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)

1. Pendahuluan

Pelayanan Kesehatan Primer dilakukan dengan mendorong peningkatan Upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. WHO merekomendasikan pendekatan PHC melalui tiga strategi utama yaitu integrasi pelayanan kesehatan primer perorangan dan masyarakat, pemberdayaan individu dan masyarakat, serta kebijakan dan aksi multi sektor. Strategi global pelayanan kesehatan berfokus pada individu (people-centred, terintegrasi guna mewujudkan pelayanan yang lebih komprehensif, responsif dan terjangkau untuk mengatasi beragam kebutuhan kesehatan yang diperlukan masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan setiap orang memiliki pengetahuan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mampu membuat keputusan dan berpartisipasi dalam perawatan kesehatannya. Penguatan pelayanan kesehatan primer penting dilakukan karena fakta yang ada menunjukkan capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2021 masih jauh dari target yang ditetapkan dan beban kesehatan yang masih tinggi serta sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan primer belum cukup kuat dalam merespon masalah kesehatan.

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dilaksanakan oleh Puskesmas yang saat ini berjumlah 10.374 Puskesmas dengan 27.768 Puskesmas Pembantu (Pusdatin, 2022) bersama fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya dan berbagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Keberadaan berbagai UKBM sebagai jejaring Puskesmas, seperti Poskesdes (42.051) dan Posyandu (301.068, Komdat Kesmas 2022), Posyandu Lansia (109.415, Komdat Kesmas 2022), Posyandu Remaja (18.300, Komdat Kesmas 2022), Posbindu (79.099, SIPTM 2022) menunjukkan belum terintegrasinya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Di sisi lain, masih terdapat 18.193 desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dalam bentuk Pustu/Poskesdes/Posyandu (laporan daerah per tanggal 20 Desember 2022) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melaksanakan transformasi pelayanan kesehatan primer dengan menerapkan konsep PHC melalui integrasi pelayanan kesehatan primer, yang diperkuat dengan munculnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. Pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau hingga tingkat masyarakat, keluarga, dan individu. Penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring, dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan.

Sistem ini tidak dapat dijalankan hanya melalui Puskesmas dan jejaringnya, namun memerlukan peran serta aktif masyarakat serta pemerintah daerah setempat untuk dapat diimplementasikan

2. Pengertian Integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP)

ILP merupakan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat. Integrasi pelayanan kesehatan primer menitikberatkan pada: 1) Penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif dan paliatif, 2) Pendekatan pelayanan kesehatan melalui sistem jejaring pelayanan kesehatan primer mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga, dan 3) Penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa/kelurahan, serta kunjungan keluarga/kunjungan rumah.

3. Tujuan ILP

Integrasi pelayanan kesehatan primer bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat. ILP bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas jejaring layanan hingga tingkat desa/kelurahan dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui dashboard situasi kesehatan. Sasaran utama dari integrasi ini meliputi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi dan anak pra-sekolah, usia sekolah dan remaja, usia dewasa, dan lansia. Selain itu, pengendalian penyakit menular dan layanan lintas klaster seperti laboratorium, farmasi, kegawatdaruratan, dan rawat inap juga menjadi fokus. Pelayanan

diharapkan dapat diberikan secara komprehensif melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu di tingkat desa/kelurahan dan dusun.

4. Penyelenggaraan ILP

Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan transformasi layanan primer sebagai pilar pertama dalam transformasi kesehatan nasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat aktivitas promotif dan preventif guna menciptakan lebih banyak individu yang sehat, meningkatkan skrining kesehatan, serta meningkatkan kapasitas layanan primer. Fokus utama dari transformasi ini meliputi: 1) Edukasi Penduduk: Penguatan peran kader kesehatan, kampanye kesehatan, dan pembangunan gerakan melalui platform digital serta tokoh masyarakat, 2) Pencegahan Primer: Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia, 3) Pencegahan Sekunder: Skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining stunting, dan peningkatan *ante natal care* (ANC) untuk kesehatan ibu dan bayi, 4) Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Primer: Revitalisasi jaringan dan standarisasi layanan di Puskesmas, posyandu, dan kunjungan rumah.

Implementasi ILP diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum, sesuai dengan tujuan transformasi sistem kesehatan pada pilar pertama. Upaya ini diyakini mampu memperkuat sistem kesehatan dengan memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

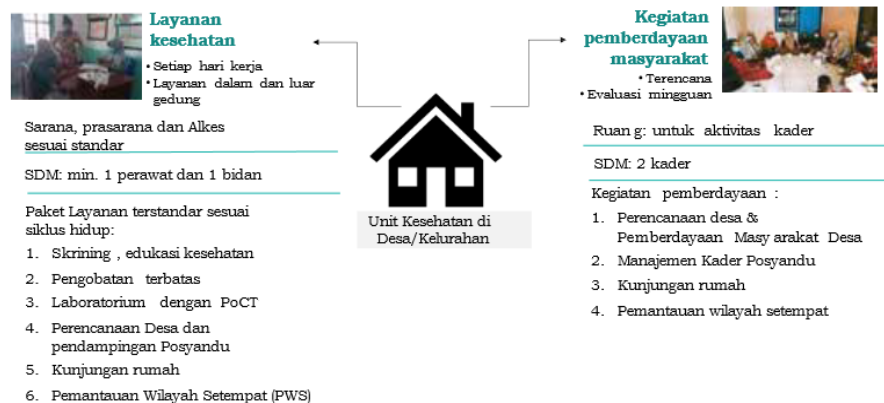
a. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Puskesmas

Cara kerja di Puskesmas dilakukan dengan mengoordinasikan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup dan tidak lagi berbasis program. Kepala Puskesmas akan menetapkan pembagian seluruh petugas Puskesmas ke dalam klaster-klaster dan menetapkan struktur organisasi Puskesmas berdasarkan pembagian klaster, yaitu: 1) Klaster 1 : Manajemen, 2) Klaster 2 : Ibu dan Anak, 3) Klaster 3 : Usia Dewasa dan Lanjut Usia, 4) Klaster 4 : Penanggulangan Penyakit Menular, dan 5) Lintas Klaster



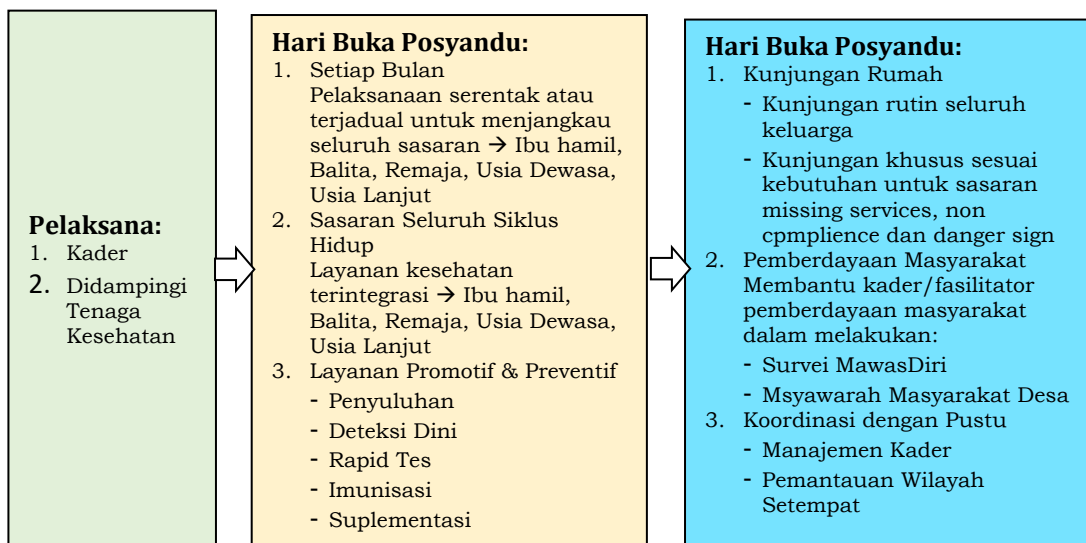
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Puskesmas (sumber: Kemenkes RI, 2023)

- b. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Pustu/Desa/Kelurahan
- Unit Pelayanan kesehatan di Desa/Kelurahan yang memberikan pelayanan kesehatan dan mendukung pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.



Gambar 1.3. Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (sumber: Kemenkes RI, 2023)

- c. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Posyandu
- Posyandu merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) yang merupakan wadah partisipasi masyarakat, bertugas membantu kepala desa/lurah di bidang pelayanan kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan. Posyandu berada di tingkat dusun/RT/RW yang dibentuk berdasarkan prakarsa pemerintah desa/ kelurahan dan masyarakat yang ditetapkan dalam peraturan desa atau peraturan bupati/walikota. Penataan posyandu yang berbasis program antara lain posyandu KIA, posyandu remaja, posbindu PTM, posyan lansia menjadi posyandu yang melayani seluruh siklus hidup.



Gambar 1.4 . Posyandu Terintegrasi (sumber: Kemenkes RI,

D. Latihan Soal

Setelah membaca dan menyimak materi terkait konsep pelayanan kesehatan primer, dipersilahkan saudara menjawab soal di bawah ini.

1. Apa prinsip utama dari Pelayanan Kesehatan Primer (PHC) yang menekankan bahwa semua individu memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi?
 - A. Pendidikan kesehatan
 - B. Pencegahan lebih diutamakan
 - C. Akses universal
 - D. Koordinasi lintas sektor
 - E. Pelayanan kesehatan dasar

2. Apa saja komponen utama dari PHC yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebiasaan hidup sehat?
 - A. Perawatan berkelanjutan
 - B. Pendidikan kesehatan
 - C. Promosi kesehatan
 - D. Pencegahan lebih diutamakan
 - E. Pelayanan kesehatan dasar

3. Salah satu tujuan dari Pelayanan Kesehatan Primer (PHC) adalah...
 - A. Mengutamakan tindakan kuratif dibanding promotive

- B. Meningkatkan kesenjangan sosial dalam kesehatan
 - C. Memastikan keberlanjutan layanan kesehatan
 - D. Mengutamakan pengobatan penyakit menular saja
 - E. Mengabaikan koordinasi lintas sector
4. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi PHC, terutama di daerah terpencil dan marginal?
- A. Kurangnya minat masyarakat terhadap layanan kesehatan
 - B. Ketimpangan akses layanan kesehatan
 - C. Tidak adanya tenaga kesehatan di perkotaan
 - D. Kurangnya dukungan sektor swasta
 - E. Berlebihnya alokasi dana kesehatan
5. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk...
- A. Memusatkan pelayanan kesehatan di kota besar
 - B. Menghapuskan prinsip PHC
 - C. Mewujudkan PHC yang efektif
 - D. Mengurangi partisipasi aktif masyarakat
 - E. Mengganti PHC dengan layanan kesehatan sekunder
6. Apa tujuan utama dari Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)?
- A. Mengurangi jumlah tenaga medis di fasilitas kesehatan primer
 - B. Menyediakan layanan kesehatan spesialis
 - C. Memastikan akses yang adil, meningkatkan koordinasi, dan efisiensi layanan
 - D. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi
 - E. Memberikan pelayanan kesehatan hanya untuk penyakit tertentu
7. Berikut ini yang termasuk komponen utama ILP adalah...
- A. Edukasi kesehatan, diagnosis penyakit, dan layanan konsultasi ekonomi
 - B. Imunisasi, diagnosis penyakit umum, dan layanan rehabilitatif
 - C. Skrining penyakit, layanan kuratif, dan pengobatan spesialis
 - D. Rehabilitasi fisik, pengelolaan infrastruktur, dan promosi wisata
 - E. Layanan preventif, kuratif, dan peningkatan ekonomi rumah tangga
8. Salah satu prinsip utama ILP adalah...
- A. Fokus pada fasilitas kesehatan mewah
 - B. Memberikan layanan hanya kepada masyarakat perkotaan
 - C. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya kesehatan

- D. Menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua
 - E. Memberikan layanan terbatas pada kesehatan fisik saja
9. Apa strategi yang diperlukan untuk implementasi ILP secara optimal....
- A. Mengurangi pelatihan tenaga kesehatan untuk efisiensi biaya
 - B. Menyediakan fasilitas kesehatan tanpa memperhatikan teknologi
 - C. Penguatan infrastruktur, kolaborasi antar sektor, dan teknologi informasi
 - D. Fokus pada layanan spesialis di rumah sakit besar
 - E. Mengembangkan pelayanan kesehatan tanpa berkolaborasi dengan sektor lain
10. Apa manfaat dari penerapan ILP yang efektif.....
- A. Menurunkan biaya pengobatan rumah sakit tanpa deteksi dini
 - B. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi sumber daya
 - C. Memprioritaskan wilayah perkotaan dibandingkan daerah terpencil
 - D. Mengurangi jumlah tenaga kesehatan di fasilitas primer
 - E. Mengalihkan fokus dari kesehatan masyarakat ke pembangunan ekonomi

Kunci Jawaban:

- 1. C
- 2. B
- 3. C
- 4. B
- 5. C
- 6. C
- 7. B
- 8. C
- 9. C
- 10. B

E. Rangkuman Materi

Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care/PHC*) merupakan pendekatan kesehatan yang menekankan pada akses universal terhadap layanan kesehatan dasar yang terjangkau, adil, dan efektif. PHC berfokus pada pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan promosi kesehatan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi lintas sektor. Prinsip utama PHC, meliputi: Akses universal, semua individu berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi, Keterlibatan masyarakat, dimana masyarakat berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan kesehatan, Lebih mengutamakan

pencegahan, yakni fokus pada tindakan promotif dan preventif, dibandingkan kuratif, serta koordinasi lintas sektor, untuk mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Komponen Utama dalam pelayanan kesehatan primer/PHC: 1) Pelayanan Kesehatan Dasar, mencakup imunisasi, kesehatan ibu dan anak, gizi, air bersih, dan sanitasi, 2) Pendidikan kesehatan, untuk meningkatkan kesadaran tentang kebiasaan hidup sehat, 3) Promosi kesehatan untuk mencegah penyakit melalui perubahan gaya hidup dan lingkungan sehat, dan 4) Perawatan berkelanjutan, penanganan penyakit umum hingga kronis di tingkat pertama. Sedangkan tujuan PHC adalah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, mengurangi kesenjangan kesehatan antar kelompok sosial, dan memastikan keberlanjutan layanan kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Primer merupakan landasan utama sistem kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk memastikan semua orang dapat hidup sehat melalui layanan yang terjangkau dan berkualitas. Untuk mewujudkan PHC yang efektif, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Saat ini Indonesia menerapkan PHC dalam Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP), yakni pendekatan yang menyatukan berbagai layanan kesehatan primer secara holistik, terkoordinasi, dan berkesinambungan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat. Tujuan ILP, meliputi: 1) Memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan, 2) Meningkatkan koordinasi antar penyedia layanan kesehatan, 3) Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan 4) Memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan individu dan komunitas.

ILP dilaksanakan dengan prinsip: Holistik, yakni menyediakan layanan yang meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial, Berpusat pada pasien, yakni pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan individu, Aksesibilitas, yakni mudah dijangkau oleh masyarakat di daerah terpencil maupun perkotaan, dan Efisiensi, yakni menghindari duplikasi layanan untuk memaksimalkan manfaat. Dalam implementasinya diperlukan strategi: 1) Peningkatan kapasitas SDM, dengan melatih tenaga agar mampu menangani berbagai layanan, 2) Penguatan infrastruktur, dengan menyediakan fasilitas kesehatan primer yang memadai, 3) Teknologi informasi, yakni mengintegrasikan data kesehatan melalui sistem digital, serta 4) Kolaborasi antar sektor, yakni menggandeng sektor pendidikan, sosial, dan swasta untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Integrasi pelayanan kesehatan primer menjadi kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

F. Glosarium

Continuity of care: konsep dalam pelayanan kesehatan yang mengacu pada penyediaan layanan kesehatan yang konsisten, terintegrasi, dan berkesinambungan kepada pasien selama periode waktu tertentu, bahkan saat pasien berpindah antara berbagai penyedia layanan atau tingkat perawatan.

Deklarasi Alma-Ata: deklarasi yang dihasilkan dari Konferensi Internasional tentang Pelayanan Kesehatan Primer yang diselenggarakan oleh WHO Tahun 1978 di Alma Ata.

Deklarasi Astana: deklarasi yang dihasilkan dari Konferensi Global tentang Pelayanan Kesehatan Primer Tahun 2018 di Astana, Kazakhstan sebagai kelanjutan dan pembaruan dari Deklarasi Alma Ata 1978.

Health for All/HFA: tingkat kesehatan yang memungkinkan semua orang di dunia menjalani kehidupan produktif secara sosial dan ekonomi.

ILP (Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer): konsep yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama melalui penyatuan berbagai layanan kesehatan primer dalam sistem yang terintegrasi.

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional): program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang menyediakan akses layanan kesehatan yang terjangkau melalui sistem asuransi kesehatan.

PIS-PK (Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga): program kesehatan yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan yang lebih terfokus pada keluarga.

PKMD: sebuah konsep atau program yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dan berbasis masyarakat.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu): merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatanarganya.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat): merupakan fasilitas kesehatan di Indonesia yang menyediakan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

PKP/PHC: Pelayanan kesehatan primer atau primary health care (PHC) adalah pendekatan kesehatan menyeluruh untuk memastikan tingkat kesehatan dan

kesejahteraan setinggi mungkin dan distribusinya yang adil dengan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

PTM (Penyakit Tidak Menular): kelompok penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang dan biasanya berkembang perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit-penyakit ini sering kali berhubungan dengan faktor risiko gaya hidup, seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol yang berlebihan, atau merokok.

Sustainable Development Goals (SDGs): Tujuan Pembangunan Milenium Berkelanjutan, terutama pada SDG ke-3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua di segala usia."

Transformasi Kesehatan: Transformasi kesehatan merujuk pada perubahan besar dan terencana dalam sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan, meliputi peningkatan teknologi, aksesibilitas dan penyempurnaan sistem kesehatan.

Universal Health Coverage (UHC): sistem pelayanan kesehatan yang memastikan semua individu dan komunitas mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa menghadapi kesulitan keuangan

G. Daftar Pustaka

Barbara Starfield, (1998), *Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology*, Oxford University Press.

Depkes RI. (1984). *Pedoman Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)*. Departemen Kesehatan RI. Jakarta

Depkes RI. (1990). *Primary Health Care di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Jakarta

John H. Bryant , Julius B. Richmond, 2017, *Ensiklopedia Internasional Kesehatan Masyarakat*, Edisi Kedua

Kemenkes RI & WHO Indonesia, (2023). *Laporan tentang implementasi PHC dan PKMD di Indonesia*, Jakarta

Kementerian Dalam Negeri RI (2024). *Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu*, Kemendagri RI, Jakarta

Kementerian Kesehatan RI (2016). *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga*. 2016.

- Kementerian Kesehatan RI, (1980), *Pedoman dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)*, Kemkes RI, Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI, (2023), *Pedoman Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan*, Kemkes RI, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, (2023). KepMenKes RI Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes RI, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia*, Penulis: Kemenkes RI, Tahun: Beragam edisi (sesuai kebutuhan), Penerbit: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Retnowati E, dkk, (2015). *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*, Edisi pertama, Wahana Iptek Bandung.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2010). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta
- Tahlil, T., et al. 2020, *Pembangunan Kesehatan yang Terpadu: Perspektif Indonesia*, UI Press, Jakarta
- UN General Assembly, (2019). *Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier World*. WHO, Geneva, Switzerland.
- United Nations (UN), *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*, WHO, <https://sdgs.un.org/goals>.
- United Nations. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- World Health Organization (WHO) & UNICEF, (1978). *Declaration of Alma-Ata*. World Health Organization Geneva
- World Health Organization (WHO), (2008), *Primary Health Care: Now More Than Ever*, World Health Organization Press
- World Health Organization (WHO), (2018). *Multisectoral Action for a Healthier World*, World Health Organization, Geneva

World Health Organization (WHO), (2021). *Tracking Universal Health Coverage : Global Monitoring Report*. Geneva.

World Health Organization (WHO), *Universal Health Coverage*. WHO, <https://www.who.int>.

BAB 2

KONSEP KOMUNITAS

Tujuan Intruksional:

1. Menjelaskan konsep komunitas dalam konteks keperawatan keluarga.
2. Menjelaskan peran komunitas dalam mendukung kesejahteraan keluarga.
3. Menjelaskan struktur dan dinamika komunitas.
4. Menjelaskan peran perawat dalam komunitas.
5. Menjelaskan tantangan dan isu dalam keperawatan keluarga berbasis komunitas.
6. Menjelaskan perkembangan keperawatan keluarga dalam konteks komunitas di masa depan.

Capaian Pembelajaran:

1. Memahami konsep komunitas dalam konteks keperawatan keluarga.
2. Menganalisis peran komunitas dalam mendukung kesejahteraan keluarga.
3. Memahami struktur dan dinamika komunitas.
4. Menganalisis peran perawat dalam komunitas.
5. Menganalisis tantangan dan isu dalam keperawatan keluarga berbasis komunitas.
6. Menganalisis perkembangan keperawatan keluarga dalam konteks komunitas di masa depan.

Pendahuluan

Keperawatan keluarga dalam konteks komunitas merupakan pendekatan holistik yang tidak hanya berorientasi pada kesehatan individu, tetapi juga pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Komunitas sebagai lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan geografis tempat keluarga tinggal, berperan penting dalam membentuk pola hidup, perilaku kesehatan, serta tingkat kesejahteraan keluarga. Dalam pendekatan ini, keluarga dilihat bukan sekadar sebagai unit individu yang terisolasi, melainkan sebagai bagian integral dari komunitas yang dinamis dan interaktif.

Pemahaman terhadap konsep komunitas sangat penting bagi perawat keluarga, karena memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi berbagai determinan sosial yang berdampak signifikan pada kesehatan keluarga, seperti norma sosial, sumber daya komunitas, dukungan sosial, serta tantangan ekonomi dan geografis. Peran

komunitas dalam memberikan akses terhadap layanan kesehatan, menyediakan dukungan sosial, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan keluarga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi keperawatan keluarga.

Perawat keluarga memiliki peran kunci dalam menghubungkan keluarga dengan komunitas melalui berbagai aktivitas promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Melalui pemahaman struktur dan dinamika komunitas, perawat mampu merancang intervensi yang tepat, sensitif secara budaya, serta sesuai dengan kebutuhan unik dari setiap keluarga dalam komunitas. Peran perawat tidak hanya terbatas pada pelayanan langsung kepada keluarga, tetapi juga melibatkan advokasi, edukasi kesehatan, fasilitasi akses terhadap sumber daya komunitas, serta koordinasi layanan lintas disiplin.

Namun demikian, implementasi keperawatan keluarga berbasis komunitas juga menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi kesehatan, hingga isu-isu terkait perbedaan budaya dan stigma sosial terhadap penyakit tertentu. Pemahaman mendalam tentang tantangan tersebut akan membantu perawat dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan yang ada, serta meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan keluarga.

Dalam menghadapi tantangan di masa depan, perkembangan teknologi dan digitalisasi di bidang kesehatan menawarkan peluang baru bagi keperawatan keluarga berbasis komunitas. Teknologi seperti telemedicine, perangkat wearable, serta aplikasi kesehatan berbasis mobile akan semakin banyak digunakan untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan efektivitas pelayanan keperawatan keluarga di tingkat komunitas. Di samping itu, pendekatan interdisipliner serta integrasi layanan kesehatan primer dan layanan sosial lainnya diharapkan semakin memperkuat peran perawat keluarga dalam mendukung kesejahteraan keluarga secara holistik dan berkelanjutan.

Dengan mempelajari berbagai aspek tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara mendalam mengenai peran penting komunitas dalam konteks keperawatan keluarga, serta mampu mengaplikasikan konsep ini secara efektif dalam praktik keperawatan mereka di masyarakat. Pembelajaran ini bertujuan untuk menyiapkan perawat keluarga yang kompeten, adaptif, dan responsif terhadap berbagai dinamika sosial di dalam komunitas, guna mendukung pencapaian kesejahteraan keluarga yang optimal.

Uraian Materi

Komunitas merupakan elemen penting dalam konteks keperawatan keluarga, karena keluarga tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat mereka tinggal dan berkembang, serta dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Komunitas bukan hanya sekadar lingkungan fisik yang diisi oleh individu dan keluarga, tetapi juga mencakup hubungan sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terkait. Keperawatan keluarga berfokus pada pemberdayaan keluarga untuk mencapai kesehatan optimal dalam konteks sosial yang lebih luas, yang mencakup faktor-faktor yang ada di dalam komunitas tempat mereka tinggal (McMurray & Clendon, 2022).

Pendekatan komunitas berbasis keperawatan keluarga tidak hanya berfokus pada perawatan individu, tetapi juga pada dinamika keluarga yang dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan komunitas. Konsep komunitas dalam keperawatan keluarga mengajak perawat untuk melihat keluarga sebagai unit yang berada dalam jaringan sosial yang lebih besar, yang sering kali memengaruhi kesehatan mereka (Stanhope & Lancaster, 2020). Melalui pendekatan ini, perawat dapat mengenali dan mengatasi determinan sosial kesehatan yang ada di tingkat komunitas, seperti kondisi lingkungan, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta faktor sosial dan ekonomi yang berdampak pada keluarga.

Komunitas dalam konteks keperawatan keluarga merujuk pada jaringan hubungan yang memungkinkan perawat untuk mendekati masalah kesehatan dari perspektif yang lebih holistik (Balestra, 2019). Dalam konteks ini, perawat tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan yang membantu keluarga berinteraksi lebih efektif dengan komunitas mereka untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang komunitas, termasuk struktur, budaya, dan sumber daya yang ada di dalamnya, sangat penting untuk merancang intervensi keperawatan yang efektif. Keberhasilan intervensi keperawatan keluarga sangat bergantung pada hubungan simbiotik antara keluarga dan komunitas, yang perlu dipahami dengan baik oleh perawat dalam praktik sehari-hari.

A. Keperawatan Komunitas

Definisi komunitas dalam konteks keperawatan keluarga

Keperawatan komunitas adalah cabang dari keperawatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks komunitas. Tujuan utamanya adalah untuk merawat, mencegah, dan mempromosikan kesehatan dalam lingkungan yang lebih luas, yakni komunitas, dengan memahami determinan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kesehatan mereka. Keperawatan komunitas berupaya menciptakan perubahan yang positif dalam kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui pendidikan, intervensi, serta penguatan kapasitas komunitas dalam menangani isu-isu kesehatan.

Keperawatan komunitas mencakup pemberian perawatan yang berfokus pada keluarga dan individu dalam konteks sosial mereka, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan (Stanhope & Lancaster, 2020). Ini melibatkan pemahaman terhadap dinamika komunitas dan cara-cara di mana faktor-faktor sosial dan lingkungan memengaruhi perilaku kesehatan.

Sementara itu, menurut Nies dan McEwen (2021), keperawatan komunitas juga melibatkan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan kesehatan mereka sendiri, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam komunitas untuk mencapai tujuan kesehatan bersama.

Dalam konteks keperawatan keluarga, komunitas merujuk pada kelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah geografis atau memiliki karakteristik sosial yang sama, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Komunitas ini berfungsi sebagai lingkungan tempat keluarga berada, dan dapat memengaruhi kesejahteraan serta kesehatan mereka. Keperawatan keluarga berfokus pada pemberdayaan keluarga untuk mengelola kesehatan mereka dalam konteks lingkungan sosial yang lebih luas, di mana komunitas memainkan peran penting dalam mendukung atau menghambat kesehatan keluarga.

Komunitas dalam keperawatan keluarga meliputi berbagai aspek, termasuk kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, serta layanan kesehatan yang tersedia untuk keluarga. Perawat keluarga bekerja dengan keluarga dalam konteks komunitas untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, merencanakan intervensi, dan mendukung keluarga dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan. Menurut McMurray dan Clendon (2022), komunitas dalam keperawatan keluarga adalah tempat di mana keluarga dapat mengakses dukungan sosial, layanan kesehatan, dan fasilitas lainnya yang memengaruhi gaya hidup dan kesejahteraan

mereka.

Keperawatan keluarga berbasis komunitas juga melibatkan pendekatan yang lebih holistik, di mana perawat tidak hanya memfokuskan perhatian pada perawatan individu atau keluarga semata, tetapi juga melihat bagaimana dinamika sosial, budaya, dan ekonomi komunitas berperan dalam membentuk kesehatan keluarga. Dalam hal ini, perawat keluarga memiliki peran dalam menghubungkan keluarga dengan sumber daya yang ada dalam komunitas serta mengadvokasi perubahan kebijakan yang dapat mendukung kesejahteraan keluarga secara lebih luas.

Peran komunitas dalam mendukung kesejahteraan keluarga

Komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu dan keluarga itu sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan sumber daya yang tersedia di komunitas. Komunitas dapat menyediakan dukungan sosial, akses ke layanan kesehatan, peluang ekonomi, dan kegiatan yang berkontribusi pada kesejahteraan fisik, mental, dan emosional keluarga.

Beberapa cara komunitas mendukung kesejahteraan keluarga antara lain (Friedman et al., 2014; Nies & McEwen, 2021):

1. Dukungan Sosial dan Emosional

Komunitas yang kuat memberikan dukungan sosial bagi keluarga melalui jaringan sosial, kelompok pendukung, serta interaksi antar anggota masyarakat. Dukungan ini penting untuk mengurangi stres keluarga, memberikan rasa aman, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebuah komunitas yang saling mendukung memungkinkan keluarga untuk lebih mudah mengatasi tantangan kehidupan seperti masalah keuangan, penyakit, atau masalah lainnya.

2. Akses terhadap Layanan Kesehatan

Komunitas memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa keluarga memiliki akses yang cukup terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Layanan kesehatan komunitas seperti klinik kesehatan, layanan pencegahan penyakit, dan pendidikan kesehatan sangat penting dalam menjaga kesehatan keluarga. Keberadaan fasilitas ini membantu keluarga untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, serta memfasilitasi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

3. Pemberdayaan dan Pendidikan Kesehatan

Komunitas dapat memberikan pendidikan kesehatan yang sangat berguna untuk keluarga. Program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh komunitas membantu keluarga memahami pentingnya kesehatan, gizi, perawatan diri, serta pencegahan penyakit. Dengan pemberdayaan melalui pendidikan, keluarga dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan

kesehatan mereka.

4. Keterlibatan dalam Aktivitas Sosial dan Ekonomi

Komunitas menyediakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi juga mendukung kesejahteraan keluarga. Program seperti pelatihan keterampilan, peluang kerja, serta kegiatan rekreasi dan sosial membantu keluarga untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan menjaga keseimbangan emosional. Keterlibatan dalam aktivitas sosial juga memperkuat ikatan antar anggota keluarga dan masyarakat.

5. Pengelolaan Krisis

Dalam situasi krisis, seperti bencana alam atau wabah penyakit, komunitas memiliki peran penting dalam menyediakan bantuan darurat dan memastikan bahwa keluarga tetap terlindungi dan aman. Komunitas yang siap menghadapi krisis dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga dan membantu mereka dalam pemulihan pasca-krisis.

6. Peran dalam Menyediakan Sumber Daya dan Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur yang mendukung, seperti transportasi, sekolah, dan fasilitas umum lainnya, juga berperan dalam kesejahteraan keluarga. Komunitas yang menyediakan akses yang mudah ke fasilitas ini memungkinkan keluarga untuk lebih mudah mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas penting lainnya.

Secara keseluruhan, komunitas yang sehat dan mendukung memberikan lingkungan yang kondusif bagi keluarga untuk berkembang, bertumbuh, dan menjaga kesejahteraan mereka.

B. Struktur dan Dinamika Komunitas

Karakteristik komunitas

Komunitas dapat dilihat melalui beberapa karakteristik utama, yaitu geografis, demografis, dan budaya (Anderson & McFarlan, 2015).

1. **Karakteristik Geografis:** Komunitas geografis merujuk pada suatu kelompok orang yang tinggal di wilayah atau area tertentu, yang dapat berupa lingkungan perumahan, desa, kota, atau wilayah pedesaan. Karakteristik ini sering melibatkan faktor-faktor seperti batas wilayah, iklim, dan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut.
2. **Karakteristik Demografis:** Karakteristik demografis menggambarkan komposisi populasi dalam suatu komunitas, seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat sosial ekonomi. Karakteristik ini penting untuk memahami kebutuhan kesehatan, sosial, dan ekonomi dari

anggota komunitas.

3. Karakteristik Budaya: Komunitas budaya mengacu pada norma, nilai, kepercayaan, bahasa, dan kebiasaan yang dianut oleh kelompok dalam komunitas tersebut. Karakteristik budaya ini memengaruhi cara anggota komunitas berinteraksi, berkomunikasi, dan membuat keputusan terkait dengan masalah kesehatan atau sosial.

Struktur sosial dalam komunitas

Struktur sosial dalam komunitas mencakup berbagai elemen yang membentuk hubungan sosial dan pola interaksi antar anggota komunitas. Beberapa elemen penting dalam struktur sosial komunitas adalah kelompok sosial, norma, dan nilai. Struktur sosial dalam komunitas meliputi kelompok sosial, norma sosial dan nilai sosial.

1. Kelompok Sosial: Kelompok sosial merujuk pada sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki kesamaan dalam satu atau lebih aspek kehidupan, seperti minat, tujuan, atau identitas. Kelompok ini dapat bersifat formal (misalnya, organisasi atau lembaga) atau informal (misalnya, keluarga atau teman-teman). Kelompok sosial berfungsi untuk mendukung kebutuhan sosial anggotanya dan dapat memengaruhi perilaku individu dalam komunitas (Berkman et al., 2000).
2. Norma Sosial: Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota komunitas. Norma ini mencakup ekspektasi tentang bagaimana individu seharusnya bertindak dalam berbagai situasi sosial. Norma sosial membantu menjaga keteraturan dan kestabilan dalam komunitas serta memengaruhi cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan membuat keputusan (Giddens, 2006).
3. Nilai Sosial: Nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh anggota komunitas dan mendasari tindakan serta keputusan mereka. Nilai ini mencerminkan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, dan menjadi pedoman dalam hidup bersama. Nilai sosial dalam komunitas dapat berbeda-beda tergantung pada budaya dan tradisi yang ada di dalamnya, namun secara umum, nilai tersebut mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat (Henslin, 2014).

Dinamika interaksi keluarga dan komunitas

Dinamika interaksi antara keluarga dan komunitas mencakup hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara unit keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu komunitas. Interaksi ini dapat menciptakan perubahan dalam aspek sosial, kesehatan, dan kesejahteraan anggota keluarga serta masyarakat itu sendiri.

1. Peran Keluarga dalam Komunitas: Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat yang memainkan peran penting dalam membentuk pola perilaku, norma, dan nilai sosial. Keluarga berfungsi sebagai agen sosial pertama bagi individu, membentuk pola interaksi sosial yang selanjutnya berlanjut ke komunitas. Sebagai contoh, anggota keluarga dapat terlibat dalam kegiatan sosial atau organisasi di tingkat komunitas yang memengaruhi kebijakan atau praktik kesehatan dan kesejahteraan di tingkat lokal (McGoldrick, 2016).
2. Peran Komunitas dalam Keluarga: Komunitas memberikan dukungan sosial dan sumber daya bagi keluarga. Keterlibatan keluarga dalam komunitas dapat meningkatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan emosional yang dibutuhkan. Komunitas yang kuat menyediakan jaringan sosial yang dapat memperkuat kemampuan keluarga untuk mengatasi tantangan, seperti krisis ekonomi atau kesehatan (Lynch & Hanson, 2011). Sebaliknya, tekanan dari komunitas, seperti norma sosial atau ekspektasi budaya, juga dapat memengaruhi keputusan keluarga, seperti pengasuhan anak atau peran gender dalam rumah tangga.
3. Interaksi Dua Arah: Dinamika ini melibatkan komunikasi dan interaksi yang memengaruhi kedua belah pihak. Misalnya, keluarga yang mendukung kebijakan kesehatan masyarakat atau berpartisipasi dalam program komunitas dapat membantu mengubah lingkungan sosial mereka, sementara perubahan sosial dalam komunitas, seperti peningkatan akses ke layanan kesehatan atau perubahan dalam norma masyarakat, dapat memengaruhi cara keluarga beroperasi dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari (Schaefer, 2015).

Pengaruh komunitas terhadap perilaku kesehatan keluarga

Komunitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kesehatan keluarga. Lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan dukungan yang ada dalam komunitas dapat membentuk pola perilaku kesehatan keluarga dalam berbagai cara. Pengaruh tersebut dapat dilihat melalui beberapa faktor (Glanz et al., 2008):

1. Akses terhadap Sumber Daya Kesehatan: Komunitas yang menyediakan akses yang baik ke layanan kesehatan, seperti klinik, rumah sakit, dan program promosi kesehatan, dapat memengaruhi perilaku kesehatan keluarga. Keluarga yang tinggal di komunitas dengan fasilitas kesehatan yang terbuka dan mudah diakses lebih mungkin untuk melakukan pemeriksaan rutin, mengikuti program imunisasi, dan menjaga kesehatan secara umum.
2. Norma Sosial dan Budaya: Komunitas dengan norma sosial yang mendukung perilaku sehat dapat mendorong keluarga untuk mengadopsi gaya hidup sehat, seperti pola makan seimbang, aktivitas fisik, dan perilaku pencegahan penyakit.

Sebaliknya, komunitas dengan norma budaya yang tidak mendukung kesehatan, seperti merokok atau konsumsi alkohol yang tinggi, dapat meningkatkan risiko perilaku tidak sehat dalam keluarga.

3. Dukungan Sosial dan Jaringan: Komunitas yang memiliki jaringan sosial yang kuat, seperti kelompok dukungan keluarga, teman, atau kelompok agama, dapat membantu keluarga mengatasi stres dan tantangan kesehatan, seperti penyakit kronis atau masalah mental. Dukungan sosial ini juga dapat mendorong keluarga untuk lebih aktif dalam mencari informasi kesehatan dan mengikuti nasihat medis.
4. Pengaruh Ekonomi: Kondisi ekonomi komunitas juga dapat memengaruhi perilaku kesehatan keluarga. Komunitas dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah cenderung memiliki keluarga yang lebih mampu untuk membeli makanan sehat, mendapatkan perawatan medis, dan mengikuti program-program pencegahan penyakit. Sebaliknya, kemiskinan dalam komunitas dapat membatasi akses keluarga terhadap sumber daya kesehatan dan meningkatkan risiko perilaku kesehatan yang buruk.

C. Peran Perawat dalam Komunitas

Perawat komunitas berperan sebagai agen perubahan yang membantu meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Perawat berfokus pada pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan pengelolaan kesehatan populasi. Berikut peran perawat dalam komunitas antara lain (Allender et al., 2014; Friedman et al., 2014; Stanhope & Lancaster, 2020):

1. Peran perawat sebagai penghubung antara keluarga dan sumber daya komunitas

Tugas perawat: Perawat memiliki peran penting sebagai penghubung antara keluarga dan sumber daya komunitas. Dalam konteks keperawatan keluarga, peran ini bertujuan untuk memastikan keluarga dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Contoh: Merujuk pasien dengan masalah kesehatan mental ke layanan konseling komunitas.

2. Mengidentifikasi Kebutuhan Keluarga

Tugas perawat: Perawat mengidentifikasi kebutuhan kesehatan keluarga berdasarkan penilaian holistik, termasuk kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan lingkungan. Dengan memahami kebutuhan ini, perawat dapat membantu keluarga menentukan sumber daya komunitas yang relevan.

Contoh: Perawat dapat menemukan bahwa keluarga membutuhkan dukungan untuk mengelola penyakit kronis, seperti diabetes, atau layanan konseling psikologis.

3. Pemberi Informasi

Tugas Perawat: Perawat memberikan informasi kepada keluarga tentang layanan komunitas, seperti fasilitas kesehatan, program pemerintah, organisasi sosial, dan layanan rehabilitasi.

Contoh: Perawat menjelaskan program imunisasi anak atau mengarahkan keluarga untuk mendapatkan bantuan gizi dari pusat pelayanan sosial.

4. Fasilitator Akses

Tugas perawat: Perawat membantu keluarga dalam mengakses sumber daya dengan: Menjelaskan prosedur atau persyaratan untuk mendapatkan layanan tertentu, membantu keluarga dalam mengisi dokumen atau formulir yang diperlukan dan menghubungi penyedia layanan atas nama keluarga jika diperlukan.

Contoh: Perawat membantu seorang ibu tunggal mendaftarkan anaknya ke program imunisasi gratis di puskesmas.

5. Pendorong Kemandirian Keluarga

Tugas perawat: Perawat tidak hanya menghubungkan keluarga dengan sumber daya, tetapi juga memberdayakan mereka agar mandiri dalam memanfaatkan layanan tersebut di masa depan.

Contoh: Perawat memberikan pelatihan kepada keluarga tentang cara mencari informasi kesehatan atau cara menggunakan fasilitas komunitas.

6. Koordinator Layanan

Perawat mengkoordinasikan layanan antara berbagai pihak, seperti penyedia layanan kesehatan, organisasi masyarakat, dan keluarga.

Contoh: Perawat memastikan bahwa keluarga yang membutuhkan perawatan jangka panjang mendapatkan rujukan yang tepat ke pusat rehabilitasi atau layanan *home care*.

7. Pemberi Edukasi

Perawat memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya komunitas untuk meningkatkan kesehatan.

Contoh: Perawat mengadakan sesi edukasi tentang layanan kesehatan preventif yang disediakan oleh pemerintah.

Perawat komunitas berfungsi sebagai jembatan antara sistem kesehatan formal dan masyarakat. Perawat memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses secara merata, memberdayakan masyarakat dan keluarga untuk menjaga

kesehatannya, serta mendukung pencapaian tujuan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya Peran Perawat komunitas dalam keluarga karena membantu:

1. Mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan.
2. Memastikan keluarga mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Meningkatkan kesadaran keluarga terhadap potensi sumber daya di komunitas.
4. Memberdayakan keluarga untuk menjadi lebih mandiri dalam menjaga kesehatan.

D. Tantangan dan Isu dalam Keperawatan Keluarga Berbasis Komunitas

Keperawatan keluarga berbasis komunitas berfokus pada peningkatan kesehatan keluarga di lingkungan komunitas mereka. Meskipun pendekatan ini memiliki banyak manfaat, perawat sering menghadapi tantangan dan isu yang kompleks. Berikut adalah tantangan dan isu dalam keperawatan keluarga berbasis komunitas (Allender et al., 2014; Friedman et al., 2014; Stanhope & Lancaster, 2020):

1. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan besar dalam implementasi keperawatan keluarga berbasis komunitas. Faktor-faktor seperti keterbatasan tenaga medis, peralatan medis, dana, serta fasilitas kesehatan yang tidak memadai sangat memengaruhi efektivitas layanan keperawatan yang diberikan kepada keluarga dalam komunitas.

a. Keterbatasan tenaga perawat

Banyak komunitas, terutama yang terletak di daerah terpencil atau padat penduduk, kekurangan tenaga perawat yang terlatih dan berlisensi. Keterbatasan ini memperburuk kualitas perawatan dan penanganan kesehatan keluarga.

b. Keterbatasan fasilitas kesehatan

Di beberapa komunitas, terutama yang berada di daerah pedesaan atau daerah yang kurang berkembang, fasilitas kesehatan tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini mencakup keterbatasan rumah sakit, klinik, puskesmas, atau pusat kesehatan komunitas.

c. Keterbatasan Peralatan Medis dan Obat-obatan

Keterbatasan peralatan medis dasar dan obat-obatan di tingkat komunitas menghambat kemampuan perawat untuk memberikan perawatan yang efektif, terutama bagi keluarga dengan kondisi penyakit kronis atau yang membutuhkan pengobatan khusus.

d. Keterbatasan Dana

Dana yang terbatas, baik dari pemerintah maupun sumber lain, menjadi hambatan besar dalam penyelenggaraan program keperawatan keluarga berbasis komunitas. Tanpa dukungan finansial yang memadai, banyak program kesehatan keluarga tidak dapat berjalan dengan maksimal.

e. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Transportasi

Komunitas di daerah terpencil sering kali menghadapi masalah infrastruktur, seperti jalan yang buruk atau tidak adanya sarana transportasi yang memadai untuk mengakses fasilitas kesehatan.

f. Keterbatasan Teknologi

Keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga dapat menghambat akses keluarga terhadap informasi kesehatan atau layanan jarak jauh yang dapat mengurangi beban kerja perawat di komunitas.

2. Kurangnya Edukasi dan Literasi Kesehatan

Edukasi dan literasi kesehatan yang rendah di tingkat keluarga dan komunitas dapat menjadi salah satu tantangan terbesar dalam keperawatan keluarga berbasis komunitas. Literasi kesehatan merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatannya. Kurangnya literasi kesehatan dapat menghambat upaya perawat dalam meningkatkan kesehatan keluarga, khususnya dalam hal pencegahan penyakit, pengelolaan penyakit kronis, dan promosi kesehatan.

a. Pemahaman Kesehatan yang Terbatas

Banyak keluarga, terutama di komunitas dengan tingkat pendidikan rendah, mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep dasar kesehatan, pencegahan penyakit, atau pentingnya perawatan medis preventif.

b. Ketidaktahuan Tentang Penyakit dan Pengobatan

Banyak individu atau keluarga tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi medis yang mereka alami, seperti penyakit kronis (misalnya diabetes, hipertensi) atau penyakit menular. Hal ini menyulitkan mereka untuk memahami cara mengelola kondisi tersebut dengan benar.

c. Kurangnya Akses ke Sumber Informasi Kesehatan yang Akurat

Di beberapa komunitas, terutama yang berada di daerah terpencil, sulit untuk mengakses informasi kesehatan yang benar dan terpercaya. Keluarga mungkin mengandalkan informasi yang salah atau tidak akurat dari sumber yang tidak dapat dipercaya, seperti rumor atau informasi dari media sosial.

d. Rendahnya Keterlibatan dalam Program Kesehatan Preventif

Kurangnya literasi kesehatan juga berpengaruh pada rendahnya keterlibatan keluarga dalam program kesehatan preventif yang disarankan oleh perawat atau penyedia layanan kesehatan. Program-program tersebut termasuk vaksinasi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan promosi gaya hidup sehat.

e. Kurangnya Program Edukasi Kesehatan yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Lokal

Banyak program edukasi kesehatan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan tidak disesuaikan dengan kebutuhan, bahasa, atau budaya lokal. Program yang tidak sesuai ini dapat menyebabkan rendahnya efektivitas edukasi kesehatan.

3. Perbedaan Budaya dan Keyakinan

Keperawatan keluarga berbasis komunitas seringkali dihadapkan pada tantangan yang berkaitan dengan perbedaan budaya dan keyakinan dalam masyarakat. Budaya, nilai-nilai, dan sistem kepercayaan yang dimiliki oleh keluarga atau komunitas dapat memengaruhi cara mereka memandang kesehatan, penyakit, serta pilihan pengobatan yang mereka terima. Perawat yang bekerja dalam konteks ini perlu untuk memahami dan menghormati perbedaan ini agar intervensi yang dilakukan dapat diterima dan efektif.

a. Perbedaan Persepsi Terhadap Kesehatan dan Penyakit

Di banyak komunitas, terutama yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, pandangan tentang kesehatan dan penyakit dapat sangat bervariasi. Beberapa budaya menganggap penyakit sebagai akibat dari kekuatan supranatural, karma, atau pelanggaran terhadap norma agama atau sosial.

b. Hambatan dalam Penerimaan Layanan Kesehatan

Beberapa komunitas mungkin memiliki ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan formal atau lembaga medis. Hal ini sering kali terkait dengan pengalaman negatif masa lalu atau nilai-nilai budaya yang lebih memprioritaskan pengobatan alternatif atau tradisional.

c. Perbedaan dalam Praktik Keagamaan dan Ritual Kesehatan

Ritual keagamaan atau adat tertentu dapat memengaruhi praktik kesehatan dalam keluarga. Beberapa keyakinan mengharuskan adanya pelaksanaan ritual atau doa tertentu sebagai bagian dari proses penyembuhan.

d. Kesulitan dalam Komunikasi Antar Budaya

Perawat yang bekerja di komunitas dengan beragam budaya dan bahasa mungkin menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga, terutama jika mereka tidak mengerti bahasa atau istilah medis yang digunakan.

e. Perbedaan dalam Pemahaman tentang Autonomi Keluarga

Dalam beberapa budaya, keputusan kesehatan sering kali dibuat oleh kepala keluarga atau individu yang lebih tua, sementara dalam budaya lain, keputusan tersebut lebih bersifat kolektif atau dipengaruhi oleh konsensus keluarga.

4. Stigma terhadap Penyakit Tertentu

Stigma terhadap penyakit tertentu merupakan tantangan yang signifikan dalam keperawatan keluarga berbasis komunitas. Stigma ini sering kali berasal dari persepsi sosial yang negatif terhadap individu yang menderita penyakit tertentu, baik itu penyakit fisik maupun mental. Penyakit yang terstigma, seperti HIV/AIDS, gangguan mental, atau penyakit menular tertentu, sering kali menyebabkan penderita dan keluarganya menghadapi diskriminasi dan isolasi sosial. Keberadaan stigma ini dapat menghambat upaya perawat dalam memberikan perawatan yang efektif, karena pasien dan keluarga mungkin enggan untuk mencari bantuan medis atau mengikuti perawatan yang disarankan.

a. Stigma terhadap Penyakit Menular

Penyakit menular, seperti HIV/AIDS atau tuberkulosis (TB), sering kali disertai dengan stigma yang kuat dalam banyak budaya dan masyarakat. Stigma ini seringkali didasarkan pada asumsi negatif bahwa orang yang terinfeksi adalah "berdosa" atau bertanggung jawab atas penyakit mereka, atau bahwa penyakit tersebut mudah menular dan dapat menyebabkan ketakutan dan kecemasan di kalangan masyarakat.

b. Stigma terhadap Penyakit Mental

Penyakit mental sering kali dianggap sebagai tanda kelemahan atau kegagalan pribadi dalam banyak budaya, yang dapat memperburuk stigma terhadap individu yang mengalaminya. Stigma ini juga dapat diperburuk oleh kurangnya pemahaman tentang penyakit mental sebagai gangguan medis yang dapat diobati.

c. Stigma terhadap Penyakit yang Berhubungan dengan Gaya Hidup

Penyakit yang dianggap terkait dengan gaya hidup atau perilaku tertentu, seperti obesitas, diabetes tipe 2, atau penyakit jantung yang berhubungan dengan kebiasaan merokok atau pola makan yang buruk, sering kali disertai

dengan stigma sosial. Masyarakat sering menganggap individu yang menderita penyakit ini sebagai "bertanggung jawab" atas kondisi kesehatan mereka.

- d. Stigma dalam Komunitas Terhadap Penyakit yang Terkait dengan Seksual
Penyakit yang terkait dengan perilaku seksual, seperti HIV/AIDS atau penyakit menular seksual (PMS), sering kali disertai dengan stigma yang kuat. Hal ini sering kali berkaitan dengan norma sosial dan moral yang mengaitkan perilaku seksual tertentu dengan "kejahatan" atau "perilaku tidak bermoral."
- e. Stigma terhadap Penyakit yang Memiliki Tanda Fisik yang Terlihat
Beberapa penyakit memiliki gejala atau tanda fisik yang sangat terlihat, seperti cacat fisik atau luka akibat kondisi medis, yang dapat menyebabkan individu yang menderita penyakit tersebut merasa terstigma. Penyakit seperti kusta atau kanker yang menyebabkan perubahan fisik yang mencolok sering kali disertai dengan stigma sosial.

5. Kurangnya Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan merupakan elemen penting untuk keberhasilan program keperawatan keluarga berbasis komunitas. Namun, kurangnya dukungan kebijakan dapat menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan dan pengembangan program keperawatan yang efektif. Tantangan ini sering kali mencakup alokasi sumber daya yang tidak memadai, kurangnya regulasi yang mendukung, atau tidak adanya strategi yang jelas untuk mendukung peran perawat dalam komunitas.

a. Minimnya Alokasi Anggaran untuk Program Komunitas

Banyak negara atau wilayah yang tidak menyediakan anggaran yang memadai untuk program keperawatan komunitas. Hal ini dapat berdampak pada keterbatasan fasilitas, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung perawat dan keluarga dalam komunitas.

b. Kurangnya Regulasi yang Mendukung Peran Perawat Komunitas

Dalam banyak sistem kesehatan, regulasi yang mendukung praktik perawat komunitas sering kali kurang jelas atau tidak ada. Hal ini menyulitkan perawat untuk menjalankan peran mereka secara efektif, terutama dalam hal pemberian layanan kesehatan yang berbasis rumah atau komunitas.

c. Fokus Kebijakan pada Perawatan Kuratif daripada Preventif

Banyak kebijakan kesehatan lebih menekankan pada perawatan kuratif di fasilitas medis dibandingkan dengan upaya preventif di tingkat komunitas. Hal ini membuat program keperawatan keluarga berbasis komunitas sering kali diabaikan atau diprioritaskan lebih rendah.

d. Tidak Meratanya Implementasi Kebijakan di Tingkat Lokal

Meskipun ada kebijakan yang mendukung kesehatan keluarga di tingkat nasional, implementasinya di tingkat lokal sering kali tidak konsisten atau tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan atau kurangnya pemahaman di tingkat lokal.

e. Kurangnya Kebijakan untuk Meningkatkan Kompetensi Perawat

Kebijakan untuk mendukung pelatihan dan pengembangan profesional bagi perawat komunitas sering kali tidak tersedia atau tidak memadai. Hal ini dapat membatasi kemampuan perawat untuk menangani tantangan kompleks dalam komunitas.

f. Kebijakan yang Tidak Sensitif terhadap Kondisi Lokal

Kebijakan kesehatan sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan unik di tingkat lokal, seperti kondisi geografis, budaya, atau sosial-ekonomi masyarakat. Kebijakan yang "seragam" ini dapat menjadi kurang efektif di berbagai komunitas.

6. Tantangan Geografis

Tantangan geografis merupakan hambatan signifikan dalam pelaksanaan keperawatan keluarga berbasis komunitas. Faktor geografis mencakup lokasi yang terpencil, aksesibilitas yang terbatas, kondisi jalan yang buruk, serta tantangan akibat bencana alam atau kondisi lingkungan tertentu. Semua faktor ini dapat memengaruhi ketersediaan layanan kesehatan dan kemampuan perawat untuk memberikan perawatan secara optimal.

a. Lokasi yang Terpencil dan Terisolasi

Komunitas yang tinggal di daerah terpencil atau terisolasi sering kali sulit dijangkau oleh tenaga kesehatan. Jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan membuat masyarakat sulit mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

b. Infrastruktur yang Buruk

Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan yang rusak, tidak adanya transportasi umum, atau kurangnya fasilitas komunikasi, menjadi penghalang dalam penyediaan layanan kesehatan.

c. Akses Terbatas ke Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan sering kali tidak merata, dengan komunitas terpencil memiliki akses terbatas atau tidak ada sama sekali ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit.

d. Kondisi Geografis Ekstrem

Kondisi geografis ekstrem, seperti pegunungan, gurun, atau daerah yang sering terkena bencana alam, membuat pengiriman layanan kesehatan menjadi lebih rumit.

e. Keterbatasan Teknologi dan Komunikasi

Komunitas di daerah terpencil sering kali memiliki akses terbatas ke teknologi komunikasi seperti internet atau telepon. Hal ini menghambat koordinasi antara perawat komunitas dan fasilitas kesehatan lainnya.

f. Biaya Tinggi untuk Transportasi dan Logistik

Transportasi untuk menjangkau komunitas yang jauh sering kali memerlukan biaya yang tinggi, baik untuk perawat maupun pasien. Hal ini menjadi beban tambahan bagi keluarga dan sistem kesehatan.

7. Beban Kerja dan Stres pada Perawat

Perawat yang bekerja di komunitas sering menghadapi beban kerja yang tinggi dan tekanan emosional yang signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh tanggung jawab yang luas, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan untuk merespons berbagai masalah kesehatan di tingkat keluarga dan komunitas. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan kinerja perawat.

a. Keterbatasan Tenaga Perawat

Kekurangan jumlah perawat di tingkat komunitas mengakibatkan beban kerja yang berlebihan bagi perawat yang ada. Mereka sering kali harus menangani populasi besar dengan sumber daya yang terbatas.

b. Tugas yang Beragam dan Kompleks

Perawat komunitas tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga bertanggung jawab atas promosi kesehatan, pencegahan penyakit, edukasi, serta administrasi program. Keragaman tugas ini dapat membebani waktu dan energi mereka.

c. Kurangnya Dukungan Organisasi

Minimnya dukungan dari organisasi, seperti pelatihan yang tidak memadai, supervisi yang jarang, dan kurangnya penghargaan, memperburuk tekanan yang dihadapi perawat komunitas.

d. Tekanan Emosional

Perawat komunitas sering kali menghadapi tekanan emosional ketika merawat pasien dengan kondisi kesehatan yang berat, keterbatasan sosial-ekonomi, atau penyakit terminal.

e. Beban Logistik

Perawat komunitas sering menghadapi kesulitan logistik, seperti perjalanan jarak jauh, kondisi jalan buruk, atau jadwal kerja yang tidak fleksibel.

f. Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya alat, obat-obatan, dan dukungan teknologi dapat memperburuk tekanan kerja perawat komunitas, terutama ketika mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan sumber daya yang sangat terbatas.

8. Masalah Sosial dan Ekonomi

Masalah sosial dan ekonomi merupakan tantangan signifikan dalam keperawatan keluarga berbasis komunitas. Ketimpangan sosial-ekonomi memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan, penerimaan perawatan, dan keberhasilan intervensi keperawatan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, kurangnya akses pendidikan, dan ketidakadilan sosial menciptakan hambatan yang kompleks bagi perawat dalam mendukung kesehatan keluarga.

a. Kemiskinan dan Keterbatasan Finansial

Kemiskinan menghambat keluarga untuk mengakses layanan kesehatan dasar, membeli obat-obatan, atau mendapatkan perawatan lanjutan.

b. Kurangnya Akses ke Pendidikan

Pendidikan yang rendah memengaruhi pemahaman keluarga terhadap pentingnya kesehatan, pengobatan, dan pencegahan penyakit.

c. Ketimpangan Sosial

Ketidakadilan dalam akses ke layanan kesehatan sering terjadi pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan, seperti minoritas atau masyarakat di daerah terpencil.

d. Pengangguran dan Ketidakstabilan Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi, seperti pengangguran, mengurangi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.

e. Lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung

Lingkungan sosial dengan tingkat kekerasan tinggi, penggunaan narkoba, atau kriminalitas menciptakan tantangan tambahan bagi keluarga dan perawat.

f. Ketergantungan pada Bantuan Sosial

Ketergantungan pada bantuan sosial dapat menciptakan kesenjangan dalam layanan kesehatan karena bantuan sering kali terbatas dan tidak merata.

9. Penyakit Menular dan Kronis

Keperawatan keluarga berbasis komunitas menghadapi tantangan signifikan dalam menangani penyakit menular dan kronis. Penyakit menular, seperti tuberkulosis, malaria, atau COVID-19, serta penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi, dan kanker, menuntut perhatian khusus karena pengelolaan dan pencegahannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas.

a. Kurangnya Edukasi tentang Penyakit Kronis dan Menular

Rendahnya literasi kesehatan membuat banyak keluarga tidak memahami penyebab, pencegahan, dan pengelolaan penyakit menular dan kronis.

b. Ketergantungan pada Sistem Perawatan Primer

Keluarga bergantung pada perawatan primer untuk manajemen penyakit kronis dan menular, tetapi fasilitas primer sering kali kekurangan tenaga ahli atau sumber daya.

c. Tantangan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Penyakit menular sering menyebar dengan cepat di komunitas yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur sanitasi dan pendidikan kesehatan.

d. Pengelolaan Penyakit Kronis dalam Konteks Keterbatasan

Penyakit kronis memerlukan perawatan jangka panjang, tetapi keluarga sering tidak memiliki sumber daya atau waktu untuk mematuhi rencana perawatan.

10. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Perubahan iklim dan bencana alam menciptakan tantangan signifikan dalam keperawatan keluarga berbasis komunitas. Fenomena ini tidak hanya meningkatkan risiko kesehatan secara langsung, tetapi juga mengganggu sistem

layanan kesehatan, memperburuk ketimpangan sosial, dan menambah beban kerja perawat komunitas.

a. Dampak Perubahan Iklim pada Kesehatan Komunitas

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian seperti gelombang panas, banjir, badai, dan kekeringan.

b. Gangguan pada Infrastruktur Layanan Kesehatan

Bencana alam sering kali merusak infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan transportasi.

c. Kerentanan Kelompok Tertentu

Anak-anak, lansia, dan individu dengan kondisi kronis menjadi kelompok paling rentan saat terjadi bencana atau perubahan iklim.

d. Penyakit Menular Akibat Bencana

Kondisi pasca-bencana, seperti kurangnya sanitasi, dapat meningkatkan risiko penyakit menular.

e. Stres dan Trauma Psikologis

Perubahan iklim dan bencana menciptakan tekanan emosional yang signifikan bagi keluarga, seperti kehilangan tempat tinggal, anggota keluarga, atau mata pencaharian.

f. Ketahanan Komunitas yang Rendah

Banyak komunitas tidak memiliki rencana kesiapsiagaan yang memadai untuk menghadapi bencana alam atau perubahan iklim.

E. Perkembangan Keperawatan Keluarga dalam Konteks Komunitas di Masa Depan

Masa depan keperawatan keluarga dalam konteks komunitas ditandai oleh pengembangan pendekatan holistik yang berpusat pada keluarga, memanfaatkan teknologi canggih, dan memberdayakan komunitas untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan keluarga. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan potensi pengembangan dalam perawatan keluarga berbasis komunitas (Allender et al., 2014; Friedman et al., 2014; Stanhope & Lancaster, 2020):

1. Digitalisasi dan Teknologi Kesehatan

a. Telehealth dan Telemedicine

Memberikan konsultasi medis jarak jauh untuk keluarga di daerah terpencil atau dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan. Contohnya, aplikasi telemedicine untuk memantau kondisi ibu hamil atau pasien dengan penyakit kronis.

b. Wearable Health Devices

Perangkat seperti smartwatch yang memonitor tanda vital, aktivitas fisik, dan pola tidur, membantu keluarga memantau kesehatan anggota keluarga secara real-time.

c. Mobile Health (mHealth)

Aplikasi seluler yang menyediakan edukasi kesehatan, pengingat obat, jadwal imunisasi, atau panduan perawatan bagi caregiver.

d. Penggunaan Internet of Things (IoT)

IoT memungkinkan perangkat pintar, seperti sensor untuk pasien lansia, sistem alarm untuk jatuh, atau perangkat pemantauan rumah tangga untuk mendeteksi bahaya kesehatan lingkungan.

e. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

AI digunakan untuk membantu diagnosis dan perencanaan Intervensi untuk memberikan rekomendasi perawatan personal bagi keluarga berdasarkan data kesehatan mereka.

f. Robot Caregiver

Robot yang membantu keluarga dalam merawat pasien lansia atau individu dengan disabilitas di rumah.

g. Big Data dan Analisis Prediktif

Menggunakan data besar untuk memetakan kebutuhan kesehatan komunitas, mendeteksi tren penyakit, dan merancang program intervensi berbasis bukti.

h. Electronic Health Records (EHRs)

Meningkatkan koordinasi perawatan keluarga dengan rekam medis elektronik yang dapat diakses lintas fasilitas kesehatan.

2. Edukasi dan Pemberdayaan Keluarga

a. Program Pelatihan Kesehatan Digital

Memberikan pelatihan daring kepada keluarga tentang cara menangani kondisi kesehatan tertentu, seperti perawatan diabetes atau demensia di rumah.

b. Komunitas Virtual

Platform online untuk berbagi pengalaman, sumber daya, dan dukungan emosional antar keluarga yang menghadapi situasi serupa, seperti merawat lansia atau anak dengan kebutuhan khusus.

3. Program Intervensi Berbasis Komunitas

a. Posyandu Digital

Mengintegrasikan teknologi dengan layanan posyandu untuk mendaftarkan status gizi, imunisasi, dan pertumbuhan anak secara lebih efisien.

b. Bank Relawan Kesehatan

Mengorganisasi relawan di komunitas untuk memberikan dukungan kesehatan dasar bagi keluarga yang membutuhkan.

4. Integrasi Layanan Holistik

a. Pendekatan Interdisipliner

Keperawatan keluarga berbasis komunitas di masa depan akan lebih banyak melibatkan kolaborasi dengan ahli gizi, pekerja sosial, dan profesional kesehatan lainnya untuk memastikan asuhan yang komprehensif.

b. Integrasi layanan primer Posyandu

Upaya mengoptimalkan peran Posyandu sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat berbasis komunitas yang mencakup berbagai aspek layanan primer. Layanan primer ini mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, berbagai kelompok usia mulai dari, ibu hamil, bayi, balita, remaja, dewasa dan lansia.

c. Pelayanan Berbasis Budaya

Mengadopsi pendekatan yang menghormati nilai dan tradisi budaya lokal untuk mendukung kepercayaan dan kepatuhan keluarga terhadap intervensi kesehatan.

d. Pelatihan Caregiver

Memberikan pelatihan kepada anggota keluarga untuk menjadi perawat informal bagi anggota yang membutuhkan, seperti lansia atau pasien dengan penyakit kronis.

F. Latihan Soal

Soal Multiple Choice:

1. Komunitas merujuk pada suatu kelompok orang yang tinggal di wilayah atau area tertentu, yang dapat berupa lingkungan perumahan, desa, kota, atau wilayah pedesaan. Hal ini termasuk karakteristik komunitas dalam segi:
 - A. Geografis
 - B. Demografis
 - C. Sosial
 - D. Spitaliaul
 - E. Kultural
2. Komunitas mengacu pada norma, nilai, kepercayaan, bahasa, dan kebiasaan yang dianut oleh kelompok. Hal ini termasuk karakteristik komunitas dalam segi:

- A. Geografis
 - B. Demografis
 - C. Sosial
 - D. Spitaliaul
 - E. Kultural
3. Komunitas memiliki jaringan sosial dalam memberikan dukungan kepada keluarga, sehingga membantu keluarga mengatasi stres dan tantangan kesehatan. Hal tersebut merupakan pengaruh komunitas dalam bentuk?
 - A. Akses terhadap sumber daya kesehatan
 - B. Dukungan sosial dan jaringan
 - C. Pengaruh ekonomi
 - D. Norma sosial dan budaya
 - E. Pengaruh sosial
 4. Perawat membantu keluarga mendapatkan akses ke sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini termasuk peran perawat komunitas dalam hal?
 - A. Penghubung antara keluarga dan sumber daya komunitas
 - B. Pendorong kemandirian keluarga
 - C. Koordinator layanan
 - D. Pemberi informasi
 - E. Fasilitator Akses
 5. Saat ini banyak permintaan robot sebagai care giver dalam merawat pasien lansia atau individu dengan disabilitas di rumah. Hal ini merupakan perkembangan keperawatan keluarga dalam hal?
 - A. Program intervensi berbasis komunitas
 - B. Edukasi dan pemberdayaan keluarga
 - C. Digitalisasi dan teknologi kesehatan
 - D. Pengelolaan interdisipliner
 - E. Integrasi layanan holistik

Soal Essay:

1. Jelaskan bagaimana peran komunitas dalam mendukung kesejahteraan keluarga?
2. Jelaskan bagaimana dinamika interaksi keluarga dalam komunitas?
3. Jelaskan bagaimana komunitas mampu memengaruhi perilaku kesehatan keluarga?
4. Jelaskan apa saja peran perawat dalam komunitas?

5. Jelaskan bagaimanakah perkembangan keperawatan keluarga dalam konteks komunitas di masa depan?

Kunci Jawaban Soal Multiple Choice

1. **A**
2. **E**
3. **B**
4. **A**
5. **C**

G. Rangkuman Materi

Komunitas dalam konteks keperawatan keluarga merujuk pada kelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah geografis atau memiliki karakteristik sosial yang sama, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Komunitas ini berfungsi sebagai lingkungan tempat keluarga berada, dan dapat memengaruhi kesejahteraan serta kesehatan seluruh anggota keluarga. Peran komunitas dalam mendukung kesejahteraan keluarga meliputi: dukungan sosial dan emosional, akses terhadap layanan kesehatan, pemberdayaan dan pendidikan kesehatan, keterlibatan dalam aktivitas sosial ekonomi, pengelolaan krisis, menyediakan sumberdaya dan infrastruktur.

Peran perawat dalam komunitas sebagai agen perubahan yang membantu meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat. Peran perawat dalam komunitas meliputi: sebagai penghubung antara keluarga dan sumber daya komunitas, mengidentifikasi kebutuhan keluarga, pemberi informasi, fasilitator akses, pendorong kemandirian keluarga, advokat keluarga, koordinator layanan dan pemberi informasi.

Tantangan dan isu dalam keperawatan keluarga berbasis komunitas meliputi: keterbatasan sumber daya, kurangnya edukasi dan literasi kesehatan, perbedaan budaya dan keyakinan, stigma terhadap penyakit tertentu, kurangnya dukungan kebijakan, tantangan geografis, beban kerja dan stres perawat, masalah sosial dan ekonomi, penyakit menular dan kronis, serta perubahan iklim dan bencana alam.

Potensi pengembangan keperawatan keluarga berbasis komunitas meliputi: digitalisasi dan teknologi kesehatan, edukasi dan pemberdayaan keluarga, program intervensi berbasis komunitas dan integrasi layanan holistik.

H. Glosarium

Autonomi: Kemampuan individu untuk membuat keputusan dan bertindak berdasarkan pilihan pribadi mereka sendiri, tanpa paksaan dari pihak luar.

Cara giver: Seseorang yang memberikan perawatan langsung kepada individu yang membutuhkan, baik karena alasan kesehatan, usia, maupun kondisi tertentu seperti kecacatan atau penyakit kronis.

Demografis: Karakteristik yang berkaitan dengan populasi suatu kelompok, masyarakat, atau wilayah tertentu.

Digitalisasi: Proses mengubah informasi, data, atau objek fisik menjadi format digital yang dapat disimpan, diproses, dan diakses menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau server digital.

Dinamika: Perubahan, interaksi, atau gerak yang terjadi dalam suatu sistem, proses, atau hubungan.

Diskriminasi: Tindakan, perlakuan, atau kebijakan yang membedakan atau memperlakukan individu atau kelompok secara tidak adil berdasarkan karakteristik tertentu.

Electronic Health Records: Sistem digital yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, mengelola, dan berbagi informasi kesehatan pasien secara elektronik.

Geografis: Ilmu yang mempelajari permukaan bumi, termasuk segala fenomena alam, lingkungan, dan aktivitas manusia yang terjadi di dalamnya.

Internet of Things: Jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet, memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk mengumpulkan, berbagi, dan bertukar data secara otomatis.

Kuratif: Pengobatan atau perawatan yang bertujuan untuk menyembuhkan atau mengatasi suatu penyakit atau kondisi medis.

Mobile Health: Aplikasi, perangkat, dan sistem yang memungkinkan individu dan profesional kesehatan untuk memantau, mengelola, dan meningkatkan kesehatan.

Nilai: Prinsip, keyakinan, atau standar yang dianggap penting atau berharga oleh individu atau kelompok dalam kehidupan mereka.

Norma: Aturan atau standar yang ditetapkan oleh suatu kelompok masyarakat, budaya, atau institusi untuk mengatur perilaku anggotanya.

Persepsi: Proses mental di mana individu mengorganisir, mengidentifikasi, dan menafsirkan rangsangan yang diterima melalui indera.

Preventif: Langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu kejadian atau masalah sebelum hal tersebut terjadi.

Regulasi: Aturan, norma, atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengendalikan atau mengatur perilaku dalam suatu sistem.

Stigma: Penilaian negatif yang diberikan kepada seseorang atau kelompok

berdasarkan atribut tertentu yang dianggap tidak diterima atau berbeda oleh masyarakat.

Telehealth: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, termasuk konsultasi medis, edukasi pasien, pemantauan kondisi kesehatan.

Vaksinasi: Proses pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan respons imun terhadap penyakit tertentu.

Wearable Health Devices: Perangkat elektronik yang dirancang untuk dipakai di tubuh pengguna, seperti jam tangan, gelang, kacamata, atau pakaian, yang berfungsi untuk memantau, merekam, dan menganalisis berbagai parameter kesehatan dan aktivitas fisik secara real-time.

I. Daftar Pustaka

- Allender, J. A., Rector, C., & Warner, K. . (2014). *Community & Public Health Nursing: Promoting the Public's Health*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Anderson, E. T., & McFarlan, J. M. (2015). *Community as Partner: Theory and Practice in Nursing (7th ed.)*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Balestra, M. (2019). *Community Health Nursing: A Canadian Perspective (5th ed.)*. Pearson.
- Berkman, L. ., Glass, T., Brissette, I., & Seeman, T. . (2000). From social integration to health: Durkheim in the new millennium. *Social Science & Medicine*, 51(6), 843–857.
- Friedman, M. M., Bowden, V. ., & Jones, E. . (2014). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga (Riset, Teori & Praktik) (5th ed.)*. EGC.
- Giddens, A. (2006). *Sociology (5th ed.)*. Polity Press.
- Glanz, K., Rimer, B. ., & Viswanath, K. (2008). *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice (4th ed.)*. Jossey-Bass.
- Henslin, J. M. (2014). *Essentials of Sociology: A Down-to-Earth Approach (10th ed.)*. Pearson.
- Lynch, E. ., & Hanson, M. . (2011). *Developing Cross-Cultural Competence: A Guide for Working with Children and Their Families (4th ed.)*. Brookes Publishing.

McGoldrick. (2016). *The Genogram Journey: Reconnect with Your Family*. (W. W. N. & Company. (ed.)).

McMurray, A., & Clendon, J. (2022). *Community Health and Wellness: Primary Health Care in Practice (7th ed.)*. Elsevier.

Nies, M. A., & McEwen, M. (2021). *Community/Public Health Nursing: Promoting the Health of Populations (9th ed.)*. Elsevier.

Schaefer, R. . (2015). *Sociology: A Brief Introduction (10th ed.)*. McGraw-Hill Education.

Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community (10th ed.)*. Elsevier.

BAB 3

KONSEP KELUARGA

Tujuan Intruksional

1. Menjelaskan konsep dasar keluarga dari berbagai perspektif.
2. Menganalisis peran dan fungsi keluarga dalam masyarakat serta perkembangannya dari waktu ke waktu.
3. Mendeskripsikan teori-teori utama dalam studi keluarga, seperti struktural fungsionalisme, konflik, sistem keluarga, dan interaksionisme simbolik.
4. Mengidentifikasi berbagai bentuk dan struktur keluarga serta implikasinya terhadap dinamika sosial.
5. Menjelaskan pola komunikasi, peran gender, serta dinamika dan interaksi dalam keluarga.
6. Menganalisis dampak perubahan sosial, teknologi, dan urbanisasi terhadap kehidupan keluarga.
7. Mengevaluasi nilai, norma, dan budaya dalam keluarga serta peran agama dan tradisi dalam kehidupan keluarga.
8. Mengidentifikasi tantangan dan isu kontemporer dalam keluarga, termasuk perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesehatan mental.
9. Menjelaskan kebijakan dan dukungan sosial yang tersedia untuk keluarga di tingkat nasional maupun global.
10. Memprediksi tren keluarga di masa depan serta dampak teknologi dan perubahan zaman terhadap struktur keluarga.

Capaian Pembelajaran:

1. Mengetahui dan memahami
 - a. Definisi keluarga dari berbagai perspektif serta perkembangan konsep keluarga dari waktu ke waktu.
 - b. Teori-teori utama dalam studi keluarga, termasuk struktural fungsionalisme, konflik, sistem keluarga, dan interaksionisme simbolik.
 - c. Berbagai bentuk dan struktur keluarga serta peran dan fungsinya dalam masyarakat.
 - d. Pengaruh nilai, norma, budaya, dan agama dalam kehidupan keluarga.

2. Menganalisis dan mengevaluasi
 - a. Dinamika dan interaksi dalam keluarga, termasuk pola komunikasi, peran gender, dan gaya pengasuhan.
 - b. Dampak perubahan sosial, globalisasi, teknologi, dan urbanisasi terhadap kehidupan keluarga.
 - c. Tantangan dan isu kontemporer dalam keluarga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan mental.
 - d. Kebijakan dan dukungan sosial bagi keluarga di tingkat nasional dan global.
3. Menerapkan dan mengembangkan
 - a. Konsep dan teori keluarga dalam praktik keperawatan keluarga.
 - b. Strategi intervensi berbasis keluarga yang dapat mendukung kesejahteraan keluarga.
 - c. Pemikiran kritis untuk memprediksi tren keluarga di masa depan serta adaptasi terhadap perubahan zaman.

Pendahuluan

Perawatan keluarga merupakan suatu pendekatan holistik dalam menangani permasalahan kesehatan yang terjadi pada anggota keluarga. Tim kesehatan menyediakan layanan kesehatan dengan membantu anggota keluarga mempertahankan tingkat kesehatan tertinggi (Lukman et al., 2024).

Buku ajar keperawatan keluarga ini menekankan pada keperawatan keluarga: konsep dan praktik dalam asuhan keperawatan, sehingga konsep keluarga merupakan pokok bahasan awal yang penting disampaikan.

Sebagai seorang dosen yang mengajar keperawatan keluarga, penulis memiliki pengalaman dalam mendalami dan mengajarkan berbagai konsep terkait keluarga dalam konteks keperawatan, juga eksis di dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang keperawatan keluarga.

Buku ini tersusun sebagai referensi bagi mahasiswa keperawatan agar dapat memahami konsep keluarga secara komprehensif serta mampu mengaplikasikan teori dalam praktik keperawatan keluarga.

Secara khusus pokok bahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep keluarga, termasuk struktur, fungsi, dinamika, serta peran keluarga dalam kehidupan individu dan masyarakat. Selain itu, pembaca diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip keperawatan keluarga dalam intervensi keperawatan yang berbasis bukti.

Pokok bahasan ini ditujukan bagi mahasiswa keperawatan, tenaga kesehatan, serta praktisi keperawatan yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang

konsep keluarga dalam konteks keperawatan. Buku ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi yang mengajar mata kuliah terkait keperawatan keluarga.

Beberapa sub pokok bahasan yang dibahas meliputi konsep dasar keluarga, teori-teori tentang keluarga, bentuk dan struktur keluarga, dinamika serta interaksi dalam keluarga, pengaruh perubahan sosial terhadap keluarga, tantangan kontemporer dalam keluarga, hingga kebijakan dan dukungan sosial bagi keluarga. Setiap sub pokok bahasan disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami dan menghubungkan setiap konsep yang dibahas.

Pokok bahasan ini dirancang untuk membantu pembaca belajar melalui teks yang sistematis, gambar ilustratif, studi kasus, serta latihan soal untuk mengasah pemahaman pembaca. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan refleksi pembelajaran di akhir setiap bab agar pembaca dapat mengevaluasi pemahaman mereka secara mandiri.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini meliputi pembelajaran aktif dan pembelajaran berbasis kasus. Pembaca didorong untuk berpikir kritis melalui pertanyaan reflektif, analisis studi kasus, serta diskusi kelompok yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas maupun dalam praktik klinis.

Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari buku ini, pembaca disarankan untuk membaca setiap bab secara berurutan, mengerjakan latihan-latihan yang tersedia, serta mendiskusikan konsep-konsep yang dipelajari dengan rekan sejawat atau pengajar. Buku ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian atau tugas akademik terkait keperawatan keluarga.

Dengan membaca buku ini, diharapkan pembaca dapat memiliki wawasan yang lebih luas tentang peran keluarga dalam keperawatan serta mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam praktik profesional mereka.

A. Definisi Keluarga dalam Berbagai Perspektif

1. Perspektif Sosiologi

Dalam sosiologi, keluarga dipandang sebagai unit sosial dasar yang memainkan peran penting dalam sosialisasi individu dan pemeliharaan struktur sosial. Keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi primer, di mana individu pertama kali belajar tentang norma, nilai, dan peran sosial yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, keluarga juga berperan dalam pengaturan perilaku seksual, reproduksi, dan pemberian status sosial kepada anggotanya. Peran dan fungsi keluarga ini sangat penting dalam membentuk individu yang dapat beradaptasi dan berfungsi dengan baik dalam masyarakat (Riyono, 2022).

2. Perspektif Psikologi

Dari sudut pandang psikologi, keluarga dianggap sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan mental dan emosional individu. Interaksi dalam keluarga membentuk dasar bagi pembentukan kepribadian, konsep diri, dan kesehatan mental. Keluarga menyediakan dukungan emosional, rasa aman, dan kasih sayang yang esensial bagi perkembangan individu yang sehat secara psikologis. Selain itu, dinamika keluarga, seperti pola komunikasi dan gaya pengasuhan, memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologis anggota keluarga (Riyono, 2022).

3. Perspektif Antropologi

Dalam antropologi, keluarga dipelajari dalam konteks budaya dan evolusi manusia. Antropolog meneliti berbagai bentuk keluarga yang ada di berbagai masyarakat, seperti keluarga inti, keluarga besar, poligami, dan lain-lain. Mereka juga mempelajari bagaimana praktik perkawinan, sistem kekerabatan, dan struktur keluarga berbeda-beda di berbagai budaya. Pendekatan ini membantu dalam memahami keragaman bentuk keluarga dan peranannya dalam berbagai konteks budaya (Riyono, 2022).

4. Perspektif Keperawatan

Dalam bidang keperawatan, keluarga dianggap sebagai unit perawatan yang penting. Pendekatan keperawatan keluarga menekankan pentingnya memahami dinamika keluarga, struktur, dan fungsi dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif (Riyono, 2022).

B. Peran dan Fungsi Keluarga dalam Masyarakat

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan keseimbangan sistem sosial. Pelaksanaan fungsi keluarga yang optimal dapat mendukung terwujudnya sumber daya manusia dan keluarga yang berkualitas (Herawati et al., 2020).

Fungsi-Fungsi Keluarga:

1. **Fungsi Keagamaan:** Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral kepada anggotanya, membentuk landasan keimanan dan etika yang kuat (Dewi et al., 2024).
2. **Fungsi Sosial Budaya:** Keluarga menjadi media pelestarian budaya, tradisi, dan norma sosial, memastikan kontinuitas identitas budaya dalam masyarakat (Dewi et al., 2024).
3. **Fungsi Cinta Kasih:** Keluarga menyediakan dukungan emosional dan kasih sayang, menciptakan rasa aman dan penerimaan bagi setiap anggotanya (Dewi et al., 2024).
4. **Fungsi Perlindungan:** Keluarga memberikan perlindungan fisik dan psikologis, menjaga anggota keluarga dari ancaman eksternal dan internal (Dewi et al., 2024).
5. **Fungsi Reproduksi:** Keluarga memastikan kelangsungan generasi melalui prokreasi dan pengasuhan anak (Dewi et al., 2024).
6. **Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan:** Keluarga menjadi agen utama dalam proses sosialisasi, mengajarkan norma, nilai, dan peran sosial kepada anak, serta mendukung pendidikan formal dan informal (Dewi et al., 2024).
7. **Fungsi Ekonomi:** Keluarga berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, melalui pengelolaan sumber daya dan distribusi peran kerja (Dewi et al., 2024).
8. **Fungsi Pembinaan Lingkungan:** Keluarga berperan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta menanamkan kesadaran ekologis kepada anggotanya.

Optimalisasi fungsi-fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi, pengetahuan, dan akses informasi yang dimiliki oleh keluarga. Pelaksanaan fungsi keluarga yang optimal dapat mendukung terwujudnya sumber daya manusia dan keluarga yang berkualitas (Herawati et al., 2020).

Dalam konteks masyarakat modern, peran keluarga juga mencakup adaptasi terhadap perubahan sosial, seperti perkembangan teknologi dan dinamika peran gender. Keluarga yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini cenderung lebih berhasil dalam menjalankan fungsinya dan berkontribusi positif terhadap masyarakat (Riyono, 2022).

C. Perkembangan Konsep Keluarga dari Waktu ke Waktu

Konsep keluarga telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. Perubahan ini mencerminkan adaptasi keluarga terhadap dinamika zaman dan kebutuhan anggotanya (Nadirawati, 2018) :

1. Keluarga Tradisional:

Pada masa lalu, keluarga tradisional umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, dengan peran gender yang jelas. Ayah berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara ibu bertanggung jawab atas urusan domestik dan pengasuhan anak. Struktur ini dikenal sebagai keluarga inti atau nuclear family (Khafidhoh, 2021).

2. Diversifikasi Struktur Keluarga:

Seiring waktu, struktur keluarga menjadi lebih beragam. Munculnya keluarga monoparental (orang tua tunggal), keluarga dengan kedua orang tua bekerja, dan keluarga dengan peran gender yang lebih egaliter mencerminkan perubahan dalam dinamika keluarga. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, pendidikan, dan perubahan nilai-nilai sosial. Sebagai contoh, penelitian oleh Khafidhoh (2021) menyoroti pentingnya pemberdayaan keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga melalui konseling keluarga (Khafidhoh, 2021).

3. Pengaruh Globalisasi dan Teknologi:

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah mempengaruhi interaksi dalam keluarga. Komunikasi menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi digital, namun juga menimbulkan tantangan seperti kurangnya interaksi tatap muka dan munculnya masalah terkait penggunaan media sosial. Mardisentosa et al. (2021) membahas dampak teknologi terhadap dinamika keluarga dalam konteks pendidikan kesehatan remaja (Mardisentosa et al., 2021).

4. Keluarga Multikultural dan Internasional:

Perkawinan antarbudaya dan migrasi telah menghasilkan keluarga multikultural dengan dinamika yang kompleks. Anak-anak dalam keluarga ini sering kali tumbuh dengan pengaruh budaya yang beragam, yang dapat memperkaya pengalaman mereka namun juga menimbulkan tantangan dalam hal identitas dan integrasi budaya. Artikel oleh Solahudin et al. (2021) menyoroti pentingnya pendidikan keluarga dalam membangun kesadaran orang tua terhadap keragaman budaya (Solahudin et al., 2023).

5. Perubahan dalam Norma dan Nilai:

Norma dan nilai terkait keluarga telah mengalami perubahan, termasuk penerimaan terhadap berbagai bentuk keluarga seperti pasangan tanpa anak,

pasangan sesama jenis, dan keluarga dengan peran gender yang fleksibel. Perubahan ini mencerminkan pergeseran menuju masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Prayitno et al. (2021) membahas konsep ketahanan keluarga yang ideal untuk menciptakan keluarga yang harmonis dalam konteks perubahan nilai-nilai sosial (Prayitno et al., 2021).

6. Tantangan Kontemporer:

Keluarga modern menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan ekonomi, perubahan demografi, dan isu kesehatan mental. Adaptasi terhadap tantangan ini memerlukan fleksibilitas dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan komunitas. Khafidhoh (2021) menekankan pentingnya pemberdayaan keluarga melalui konseling untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan tersebut (Khafidhoh, 2021).

Perkembangan konsep keluarga ini menunjukkan bahwa keluarga adalah institusi yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Pemahaman terhadap evolusi ini penting untuk mengapresiasi keragaman dan kompleksitas yang ada dalam struktur dan fungsi keluarga masa kini.

D. Perspektif Teoretis tentang Keluarga

Tahap proses keperawatan Studi tentang keluarga telah menghasilkan berbagai perspektif teoretis yang membantu memahami struktur, fungsi, dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Empat teori utama yang sering digunakan dalam analisis keluarga adalah:

1. Teori Struktural Fungsionalisme dalam Keluarga

Teori struktural fungsionalisme memandang keluarga sebagai unit sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada keseimbangan keseluruhan sistem keluarga. Misalnya, orang tua berperan dalam sosialisasi anak, sementara anak-anak diharapkan mematuhi norma dan nilai yang diajarkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran dan fungsi masing-masing anggota dalam mempertahankan harmoni keluarga. Sebagai contoh, penelitian oleh Masithoh et al. (2022) menyoroti hubungan antara interaksi sosial dan fungsi keluarga dengan kualitas hidup pada lansia (Bratanegara, 2022).

2. Teori Konflik dan Dinamika Keluarga

Teori konflik berfokus pada ketegangan dan pertentangan yang muncul dalam keluarga akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau sumber daya. Konflik dianggap sebagai elemen yang tak terhindarkan dan dapat menjadi pendorong

perubahan sosial dalam keluarga. Misalnya, pergeseran peran tradisional antara suami dan istri dapat menimbulkan konflik, namun juga membuka peluang untuk negosiasi peran yang lebih egaliter. Penelitian oleh Rahhma et al. (2021) membahas konflik rumah tangga akibat pergeseran peran suami istri selama pandemi COVID-19 (Marsella & Afrizal, 2022).

3. Teori Sistem Keluarga

Teori sistem keluarga memandang keluarga sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Perubahan pada satu anggota keluarga akan mempengaruhi anggota lainnya dan keseluruhan sistem. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi, aturan, dan peran dalam menjaga keseimbangan dan fungsi keluarga. Sebagai ilustrasi, analisis oleh Prasetyoningsih (2023) menggunakan teori sistem keluarga untuk memahami dinamika keluarga dalam film "Encanto" (Marsella & Afrizal, 2022).

4. Teori Interaksionisme Simbolik dalam Keluarga

Teori interaksionisme simbolik menekankan pentingnya interaksi dan makna simbolik yang dibentuk dan dipertukarkan antara anggota keluarga. Identitas dan peran dalam keluarga dipahami melalui proses interaksi sehari-hari dan interpretasi simbolik. Misalnya, panggilan sayang, ritual keluarga, atau tradisi tertentu memiliki makna khusus yang memperkuat ikatan emosional antar anggota. Nugroho (2021) membahas teori utama sosiologi komunikasi, termasuk interaksionisme simbolik, yang relevan dalam memahami dinamika komunikasi dalam keluarga lansia (Bratanegara, 2022).

Pemahaman terhadap berbagai perspektif teoretis ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengkaji fenomena yang terjadi dalam keluarga. Setiap teori menawarkan lensa berbeda untuk memahami kompleksitas hubungan dan peran dalam institusi keluarga.

E. Bentuk dan Struktur Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial dasar yang memiliki berbagai bentuk dan struktur, dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Pemahaman mengenai variasi ini penting dalam konteks keperawatan untuk memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap keluarga.

1. Keluarga Inti dan Keluarga Besar

Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, sementara keluarga besar mencakup anggota lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu yang mungkin tinggal bersama atau berdekatan. Struktur keluarga ini mempengaruhi dinamika peran, dukungan sosial, dan pengambilan keputusan terkait kesehatan.

Menurut Bakri (2017), struktur dalam keluarga terbagi menjadi empat, yaitu pola komunikasi keluarga, struktur peran, struktur kekuatan, dan nilai-nilai keluarga (Sari, 2022).

2. Keluarga Patriarki vs. Keluarga Egaliter

Dalam keluarga patriarki, keputusan utama biasanya dipegang oleh laki-laki, terutama ayah, sedangkan dalam keluarga egaliter, peran dan tanggung jawab dibagi secara lebih seimbang antara suami dan istri. Perbedaan ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan. Lestari dan Pratiwi (2018) menyatakan bahwa perubahan dalam struktur keluarga dapat mempengaruhi dinamika peran dan fungsi dalam keluarga (Lestari & Pratiwi, 2018).

3. Keluarga Monoparental (Single Parent)

Keluarga monoparental adalah keluarga yang terdiri dari satu orang tua dengan anak-anaknya. Kondisi ini dapat terjadi akibat perceraian, kematian pasangan, atau pilihan pribadi. Tantangan yang dihadapi termasuk beban ekonomi, tekanan psikologis, dan keterbatasan waktu untuk memenuhi kebutuhan anak. Menurut Bakri (2017), struktur peran dalam keluarga monoparental menuntut orang tua untuk menjalankan peran ganda dalam memenuhi kebutuhan keluarga (Sari, 2022).

4. Keluarga Multikultural dan Keluarga Campuran

Keluarga multikultural terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya yang berbeda, sedangkan keluarga campuran dapat merujuk pada pernikahan antar suku, ras, atau agama. Keberagaman ini dapat memperkaya pengalaman keluarga namun juga menimbulkan tantangan dalam hal penyesuaian budaya dan nilai. Gunawan (2019) menyoroti transformasi bentuk dan fungsi keluarga dalam konteks perubahan sosial dan budaya (PATIMAH, 2020).

5. Keluarga Adopsi dan Keluarga Pengasuhan Alternatif

Keluarga adopsi adalah keluarga yang mengadopsi anak yang tidak memiliki hubungan biologis, sementara keluarga pengasuhan alternatif mencakup keluarga asuh atau foster family yang merawat anak untuk sementara waktu. Struktur ini memerlukan adaptasi dalam peran dan hubungan emosional antara anggota keluarga (Yahya, 2021).

Memahami berbagai bentuk dan struktur keluarga ini penting bagi perawat untuk memberikan asuhan yang holistik dan sesuai dengan konteks masing-masing keluarga. Setiap struktur memiliki dinamika dan kebutuhan unik yang perlu diperhatikan dalam praktik keperawatan keluarga.

F. Dinamika dan Interaksi dalam Keluarga

Interaksi dalam keluarga memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antaranggota dan mempengaruhi kesejahteraan keseluruhan keluarga. Dinamika ini mencakup berbagai aspek seperti pola komunikasi, manajemen konflik, peran gender, dan gaya pengasuhan.

1. Pola Komunikasi dalam Keluarga

Komunikasi efektif adalah dasar dari hubungan keluarga yang harmonis. Pola komunikasi yang terbuka dan jujur memungkinkan anggota keluarga untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka, yang pada gilirannya memperkuat ikatan emosional. Penelitian oleh Pratiwi et al. (2023) menyoroti bahwa dalam era digital, interaksi keluarga mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hubungan antara orang tua dan anak. Penggunaan teknologi dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dalam keluarga (Pratiwi et al., 2023).

2. Konflik dalam keluarga dan cara penyelesaiannya

Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarga. Penyebab konflik dapat bervariasi, mulai dari perbedaan pendapat hingga masalah keuangan. Penyelesaian konflik yang efektif melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan kemampuan untuk mencapai kompromi. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* (2022), interaksi keluarga yang positif dan keterbukaan antar pasangan adalah kunci dari kualitas perkawinan yang baik (Rizkillah, 2022).

3. Peran Gender dalam Keluarga

Peran gender dalam keluarga tradisional seringkali ditentukan oleh norma-norma budaya dan sosial. Namun, seiring dengan perubahan zaman, banyak keluarga yang mengadopsi pembagian peran yang lebih egaliter. Penelitian oleh Lestari dan Rizkillah (2022) menunjukkan bahwa interaksi keluarga dan ketahanan sosial berperan penting dalam kualitas perkawinan, terutama pada keluarga dengan ibu yang bekerja di sektor informal baik (Rizkillah, 2022).

4. Parenting: Gaya Pengasuhan dan Dampaknya

Gaya pengasuhan orang tua memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak. Gaya pengasuhan yang suportif dan responsif cenderung menghasilkan anak-anak dengan kesehatan mental yang baik dan kemampuan sosial yang kuat. Laeli et al. (2022) menyoroti pentingnya interaksi yang harmonis antara saudara kandung dalam keluarga, yang dipengaruhi oleh gaya pengasuhan orang tua (Achmadi et al., 2022).

G. Perubahan Sosial dan Implikasinya terhadap Keluarga

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap struktur dan dinamika keluarga. Faktor-faktor seperti globalisasi, perkembangan teknologi, urbanisasi, dan perubahan peran gender berkontribusi pada transformasi dalam kehidupan keluarga.

1. Dampak Globalisasi terhadap Struktur Keluarga

Globalisasi telah membawa perubahan dalam nilai-nilai budaya dan ekonomi yang mempengaruhi struktur keluarga tradisional. Perubahan ini dapat terlihat dalam pergeseran peran dan fungsi keluarga, yang mengakibatkan ancaman terhadap ketahanan keluarga. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Informasi* (2013), perubahan sosial yang terjadi di masyarakat membawa pengaruh yang tidak menguntungkan bagi keluarga, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagian keluarga tidak mampu bertahan dan mengalami perubahan bentuk, struktur, fungsi, dan perannya atau berada dalam situasi disorganisasi sosial (Suradi, 2013).

2. Teknologi dan Perubahan Pola Komunikasi Keluarga

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara anggota keluarga berinteraksi. Meskipun teknologi dapat memfasilitasi komunikasi jarak jauh, ada kekhawatiran bahwa interaksi tatap muka berkurang, yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan keluarga. Sunarti (2013) menyatakan bahwa perubahan pola interaksi dalam komunikasi, cara-cara pemecahan masalah, dan pola penerimaan dan penolakan dalam keluarga dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi (Widyana, 2011).

3. Urbanisasi dan Tantangan Keluarga Modern

Urbanisasi menyebabkan migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, yang berdampak pada struktur dan fungsi keluarga. Keluarga di perkotaan sering menghadapi tantangan seperti tekanan ekonomi, kurangnya waktu bersama, dan perubahan nilai-nilai tradisional. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* (2023) menyoroti bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat akan menghasilkan masalah sosial, termasuk dalam konteks keluarga (Mursid et al., 2023).

4. Perubahan Peran Gender dalam Keluarga

Perubahan sosial telah mempengaruhi peran gender dalam keluarga, dengan semakin banyaknya perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja dan pergeseran menuju pembagian peran yang lebih egaliter. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam penyesuaian peran dan fungsi dalam keluarga. Lestari dan Pratiwi (2018) mengemukakan bahwa keluarga yang tidak siap menghadapi perubahan peran gender dapat mengalami disorganisasi (Lestari &

Pratiwi, 2018).

H. Nilai, Norma, dan Budaya dalam Keluarga

Budaya keluarga mencakup nilai, norma, dan tradisi yang membentuk perilaku dan interaksi antaranggota keluarga. Pemahaman tentang elemen-elemen ini penting untuk memahami dinamika keluarga dalam konteks sosial yang lebih luas.

1. Nilai-nilai dalam Keluarga Tradisional vs. Modern

Keluarga tradisional seringkali menekankan nilai-nilai seperti hierarki, kepatuhan, dan peran gender yang jelas. Sebaliknya, keluarga modern cenderung mengadopsi nilai-nilai egaliter, fleksibilitas peran, dan penekanan pada individualitas. Perubahan ini mencerminkan adaptasi keluarga terhadap dinamika sosial dan budaya yang berkembang. Menurut Leininger (1995), keperawatan transkultural berfokus pada analisis komparatif budaya yang berbeda, termasuk nilai-nilai kesehatan dan perilaku perawatan, yang relevan dalam memahami pergeseran nilai dalam keluarga (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2018).

2. Peran Agama dalam Keluarga

Agama memainkan peran penting dalam membentuk nilai dan norma dalam keluarga. Keyakinan dan praktik keagamaan dapat mempengaruhi keputusan keluarga, pola asuh, dan interaksi antaranggota. Leininger (1985) menekankan pentingnya memahami keyakinan dan nilai-nilai budaya, termasuk aspek spiritual, dalam memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya klien (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2018).

3. Ritual dan Tradisi Keluarga

Ritual dan tradisi keluarga, seperti perayaan hari raya, upacara pernikahan, atau ritual kelahiran, berfungsi untuk memperkuat ikatan keluarga dan mentransmisikan nilai-nilai antar generasi. Budaya menggambarkan pola kehidupan, nilai, keyakinan, norma, simbol, dan kebiasaan individu atau kelompok yang dipelajari, dibagikan, dan biasanya diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya (Iliza, 2022).

I. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Keluarga

Keluarga modern menghadapi berbagai tantangan dan isu kontemporer yang mempengaruhi kesejahteraan dan dinamika internalnya. Isu-isu seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan mental, dan tantangan di era digital menjadi perhatian utama dalam studi keluarga saat ini.

1. Perceraian dan Dampaknya pada Anggota Keluarga

Perceraian merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak signifikan

terhadap anggota keluarga, terutama anak-anak. Menurut Sinaga dan Yasri (2021), perceraian antara suami dan istri dapat berdampak buruk bagi anak, meninggalkan mereka dalam situasi yang mempengaruhi perkembangan psikososial mereka. Dampak tersebut meliputi penurunan prestasi akademik, masalah perilaku, dan gangguan emosional (Sinaga, M. H. P., Yasri, A., Nadila, O. R., Geopani, A., & Thasfa, 2023).

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah serius yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban. Rofiah (2017) menyatakan bahwa anak-anak yang menyaksikan KDRT memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan dan depresi. Selain itu, KDRT dapat menyebabkan ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan luka fisik pada anak (Suri et al., 2023).

3. Kesehatan Mental dalam Keluarga

Kesehatan mental anggota keluarga merupakan komponen penting dalam menjaga keharmonisan dan fungsi keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan tekanan sosial lainnya dapat mempengaruhi kesehatan mental anggota keluarga. Studi oleh Widiastuti dan Sekartini (2016) menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga berisiko lebih tinggi mengalami gangguan stres pascatrauma dan masalah kesehatan mental lainnya (Suri et al., 2023).

4. Tantangan Keluarga dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi keluarga modern. Penggunaan gadget dan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi kualitas interaksi antar anggota keluarga. Selain itu, paparan terhadap konten yang tidak sesuai dan risiko keamanan digital menjadi perhatian bagi orang tua dalam mengasuh anak-anak mereka di era digital. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk menetapkan batasan dan pedoman dalam penggunaan teknologi guna menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan interaksi langsung (Suri et al., 2023).

J. Kebijakan dan Dukungan Sosial untuk Keluarga

Keluarga merupakan unit fundamental dalam masyarakat yang memerlukan perlindungan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan komunitas. Berbagai kebijakan dan program telah dirancang untuk memastikan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kontemporer.

1. Peran Pemerintah dalam Melindungi Keluarga

Pemerintah memiliki peran krusial dalam melindungi dan memperkuat

ketahanan keluarga melalui berbagai kebijakan dan program. Di Indonesia, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk mendukung ketahanan keluarga, terutama selama masa pandemi. Selain itu, pemerintah juga mendorong peran aktif keluarga dalam pengasuhan anak di era digital, dengan menekankan pentingnya orang tua dalam mendidik anak-anak mereka menggunakan internet dengan bijak (Sunarti, 2015).

2. Kebijakan Keluarga di Berbagai Negara

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam merumuskan kebijakan keluarga, disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan demografis masing-masing. Misalnya, India mengadopsi Kebijakan Kependudukan Nasional yang mengintegrasikan program keluarga berencana dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Di sisi lain, Singapura menerapkan kebijakan imigrasi selektif untuk memacu pertumbuhan penduduk akibat rendahnya angka kelahiran. Di Indonesia, kebijakan keluarga telah diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kebijakan-kebijakan ini menekankan pentingnya pembangunan keluarga yang berkualitas dan berketahanan (Sunarti, 2015).

3. Dukungan Komunitas dan Organisasi Sosial bagi Keluarga

Selain peran pemerintah, komunitas dan organisasi sosial juga berkontribusi signifikan dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Mereka menyediakan berbagai layanan, seperti konseling keluarga, program pendidikan parenting, dan bantuan bagi keluarga yang mengalami krisis. Kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan organisasi sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi keluarga (Sunarti, 2015).

K. Masa Depan Keluarga

Perkembangan zaman membawa perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika keluarga. Memahami prediksi tren, peran teknologi, dan adaptasi keluarga terhadap perubahan ini penting untuk mempersiapkan keluarga yang tangguh di masa depan.

1. Prediksi Tren Keluarga di Masa Depan

Di tahun 2025, diprediksi akan muncul beberapa tren dalam pola pengasuhan dan dinamika keluarga. Salah satunya adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya "detoks digital", yaitu upaya keluarga untuk menghabiskan

waktu bersama tanpa intervensi teknologi. Kegiatan seperti berjalan kaki di lingkungan sekitar atau memasak bersama menjadi alternatif untuk memperlambat hubungan keluarga tanpa gangguan perangkat digital. Selain itu, ada tren pengasuhan yang menekankan pada peningkatan kesadaran lingkungan. Orang tua mulai mengajarkan anak-anak mereka cara bercocok tanam, menghemat sumber daya, dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan iklim. Gaya hidup seperti minim limbah (zero waste) dan penggunaan energi terbarukan menjadi semakin populer dalam keluarga (Widyana, 2011).

2. Peran Teknologi dalam Membentuk Keluarga Masa Depan

Teknologi digital memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga modern. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi anak-anak melalui berbagai alat digital. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat mengurangi interaksi antar anggota keluarga. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memberikan contoh penggunaan teknologi yang sehat dan membimbing anak-anak dalam etika digital. Selain itu, teknologi juga mempengaruhi pola komunikasi dalam keluarga. Meskipun memudahkan komunikasi jarak jauh, ada risiko berkurangnya komunikasi tatap muka yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Keluarga perlu menemukan keseimbangan antara manfaat teknologi dan pentingnya interaksi langsung (Widyana, 2011).

3. Adaptasi Keluarga terhadap Perubahan Zaman

Keluarga di era digital menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti kecanduan teknologi dan disinformasi. Untuk mengatasi hal ini, keluarga perlu membentuk budaya belajar yang berkelanjutan, di mana semua anggotanya sadar untuk terus mengembangkan potensi diri dan beradaptasi dengan perubahan. Membangun ketahanan keluarga menjadi kunci dalam menghadapi arus digitalisasi yang semakin masif (Widyana, 2011).

L. Latihan Soal

Pilihan Ganda

(Pilihlah jawaban yang paling tepat!)

1. Konsep keluarga telah mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan struktur keluarga adalah...
 - A. Perubahan cuaca dan iklim
 - B. Teknologi, urbanisasi, dan perubahan nilai sosial
 - C. Tradisi yang tidak berubah sepanjang zaman
 - D. Konservatisme yang tetap mengakar di masyarakat
 - E. Sistem pendidikan yang statis

2. Teori yang menekankan bahwa keluarga adalah suatu sistem yang terdiri dari anggota yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain adalah?
 - A. Teori Struktural Fungsionalisme
 - B. Teori Konflik
 - C. Teori Sistem Keluarga
 - D. Teori Interaksionisme Simbolik
 - E. Teori Evolusi Sosial
3. Salah satu karakteristik utama dari keluarga patriarki adalah?
 - A. Keputusan dalam keluarga dibuat bersama antara ayah dan ibu
 - B. Anak memiliki hak suara yang sama dalam keluarga
 - C. Peran utama dalam keluarga dipegang oleh laki-laki
 - D. Semua anggota keluarga memiliki peran yang setara
 - E. Tidak ada dominasi dalam pembagian tugas keluarga
4. Dampak utama dari urbanisasi terhadap kehidupan keluarga adalah...
 - A. Meningkatnya interaksi antar generasi
 - B. Menurunnya tingkat pendidikan keluarga
 - C. Perubahan pola komunikasi dan struktur keluarga
 - D. Berkurangnya angka migrasi ke perkotaan
 - E. Meningkatnya angka keluarga besar di daerah pedesaan
5. Dalam konteks peran gender dalam keluarga modern, fenomena yang paling umum terjadi adalah...
 - A. Perempuan tetap menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak
 - B. Ayah dan ibu berbagi peran dalam pencarian nafkah dan pengasuhan anak
 - C. Ibu selalu tinggal di rumah sementara ayah bekerja di luar rumah
 - D. Perempuan tidak memiliki hak untuk bekerja di luar rumah
 - E. Peran gender dalam keluarga tidak mengalami perubahan signifikan

Essay

(Jawablah pertanyaan berikut secara jelas dan rinci!)

1. Jelaskan bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi interaksi dalam keluarga dan berikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari!
2. Bandingkan dan bedakan antara teori struktural fungsionalisme dan teori konflik dalam memahami dinamika keluarga!

3. Dalam era globalisasi, bagaimana keluarga dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka tanpa menghambat kemajuan? Berikan pendapat Anda!
4. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk struktur keluarga yang ada di masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya!
5. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan keluarga di era modern? Berikan contoh program atau kebijakan yang sudah diterapkan!

Kunci Jawaban

1. B
2. C
3. C
4. C
5. B

M. Rangkuman Materi

Keluarga merupakan institusi sosial yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Dari keluarga tradisional dengan peran gender yang kaku hingga struktur keluarga yang lebih beragam, perubahan ini dipengaruhi oleh urbanisasi, teknologi, globalisasi, serta nilai-nilai sosial yang semakin inklusif.

Beberapa teori utama dalam memahami keluarga meliputi: teori struktural fungsionalisme, yang melihat keluarga sebagai sistem dengan fungsi masing-masing anggota; teori konflik, yang menyoroti ketimpangan dalam peran keluarga; teori sistem keluarga, yang menganggap keluarga sebagai kesatuan yang saling memengaruhi dan teori interaksionisme simbolik, yang fokus pada makna dalam interaksi antar anggota keluarga.

Bentuk keluarga bervariasi, termasuk keluarga inti dan keluarga besar, keluarga patriarki vs. egaliter, serta keluarga monoparental. Ada pula keluarga multikultural, keluarga adopsi, dan bentuk keluarga pengasuhan alternatif yang semakin berkembang dalam masyarakat modern.

Pola komunikasi dalam keluarga menentukan keharmonisan hubungan antaranggota. Konflik sering muncul dan harus diselesaikan dengan strategi yang efektif. Peran gender juga mengalami pergeseran, dengan lebih banyak kesetaraan antara suami dan istri. Parenting atau pola asuh sangat mempengaruhi perkembangan anak, baik secara emosional maupun sosial.

Globalisasi, teknologi, dan urbanisasi membawa dampak besar bagi keluarga. Teknologi mengubah pola komunikasi, sementara urbanisasi menuntut keluarga untuk beradaptasi dengan lingkungan perkotaan yang dinamis. Selain itu, perubahan peran gender menciptakan tatanan baru dalam pembagian tugas dalam keluarga.

Nilai dan norma dalam keluarga mengalami pergeseran dari yang tradisional menuju yang lebih fleksibel. Agama tetap menjadi faktor penting dalam kehidupan keluarga, begitu juga dengan ritual dan tradisi yang membentuk identitas serta kebersamaan dalam keluarga.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi keluarga modern meliputi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan mental, dan pengaruh era digital. Tantangan ini menuntut strategi adaptasi agar keluarga tetap berfungsi dengan baik.

Pemerintah memiliki peran dalam melindungi keluarga melalui kebijakan sosial dan ekonomi. Berbagai negara memiliki regulasi yang mendukung kesejahteraan keluarga. Selain itu, komunitas dan organisasi sosial juga berkontribusi dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan.

Di masa depan, tren keluarga diprediksi akan semakin fleksibel dengan pengaruh teknologi yang lebih besar. Perubahan zaman mengharuskan keluarga untuk terus beradaptasi dalam mempertahankan kesejahteraan dan keharmonisan mereka.

N. Glosarium

Adaptasi: Proses penyesuaian keluarga terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di sekitarnya.

Dinamika Keluarga: Interaksi, perubahan, dan perkembangan yang terjadi dalam suatu keluarga seiring waktu.

Egaliter: Suatu bentuk hubungan dalam keluarga yang menekankan kesetaraan peran antara anggota keluarga, terutama dalam pembagian tugas dan pengambilan keputusan.

Globalisasi: Proses integrasi sosial, budaya, dan ekonomi antarnegara yang mempengaruhi struktur dan nilai dalam keluarga.

Interaksionisme Simbolik: Teori yang menjelaskan bagaimana interaksi dalam keluarga dipengaruhi oleh makna dan simbol yang diciptakan oleh anggota keluarga.

Kebijakan Keluarga: Peraturan dan program yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi untuk mendukung kesejahteraan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan.

Keluarga Besar (Extended Family): Keluarga yang mencakup lebih dari satu generasi, seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu yang tinggal bersama atau memiliki hubungan erat.

Keluarga Inti (Nuclear Family): Bentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang tinggal dalam satu rumah tangga.

Keluarga Monoparental: Struktur keluarga yang hanya memiliki satu orang tua yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.

Keluarga Multikultural: Keluarga yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, biasanya akibat perkawinan antarbudaya atau migrasi.

Konflik Keluarga: Perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi di dalam keluarga yang dapat mempengaruhi hubungan antaranggota keluarga.

Norma Keluarga: Aturan atau kebiasaan yang dianut dalam suatu keluarga yang mengatur perilaku anggota keluarga.

Parenting (Pengasuhan Anak): Pola atau gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak-anak mereka.

Patriarki: Sistem sosial di mana laki-laki, terutama ayah atau suami, memiliki otoritas dominan dalam keluarga dan masyarakat.

Peran Gender: Harapan sosial terhadap bagaimana laki-laki dan perempuan harus bertindak dalam keluarga dan masyarakat.

Perceraian: Pemutusan hubungan pernikahan secara hukum yang mengakhiri status pernikahan pasangan suami-istri.

Ritual Keluarga: Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga secara turun-temurun untuk memperkuat hubungan antaranggota keluarga.

Sistem Keluarga: Teori yang melihat keluarga sebagai suatu sistem yang terdiri dari individu yang saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain.

Struktural Fungsionalisme: Teori yang menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Teknologi dalam Keluarga: Pengaruh teknologi terhadap komunikasi, hubungan, dan dinamika dalam keluarga, termasuk dampak positif dan negatifnya.

O. Daftar Pustaka

- Achmadi, A. N. L., Hidayah, N., & Safaria, T. (2022). Pola Asuh Orangtua, Keharmonisan Keluarga Dan Jenis Kelamin, Pengaruhnya Terhadap Sibling Rivalry Pada Anak. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 13(1), 318–326. <https://doi.org/10.26751/jikk.v13i1.1293>
- Bratanegara, A. S. (2022). Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi Struktural Fungsional dalam Melihat Dukungan Keluarga. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi Journal*, 12(2), 169–176. <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/58686>
- Dewi, S. A. T., Herawati, T., & Muflikhati, I. (2024). Pengaruh Fungsi Keluarga, Dukungan Sosial, dan Beban Perawatan terhadap Ketahanan Keluarga yang tinggal bersama Lansia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 17(1), 30. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v17i1.19922>
- Herawati, T., Pranaji, D. K., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13(3), 213–227. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>
- Iliza, N. E. (2022). Hubungan Cultural Care (Cultural Value) Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Pakong. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1–23.
- Khafidhoh, I. (2021). Pemberdayaan Keluarga Dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Structural Family Counseling. *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.21043/cdjpmi.v5i1.9554>

- Lestari, P., & Pratiwi, P. H. (2018). Perubahan Dalam Struktur Keluarga. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/dimensia.v7i1.21053>
- Lukman, S., Muhammadong, M., & Ilmayanti, N. (2024). Asuhan Keperawatan Keluarga pada Keluarga Tn. I dengan Anggota Keluarga Defisit Pengetahuan mengenai Penyakit ISPA. *Jurnal Keperawatan Profesional (KEPO)*, 5(1), 102–114. <https://doi.org/10.36590/kepo.v5i1.990>
- Mardisentosa, B., Afgani Dahlan, J., Dharmayanti, N., Afriadi, B., Ayuningtyas Kusumastut, N., Ayu Pratiwi, N., & Khaeriyah, S. (2021). Pengembangan Model Pendidikan Kesehatan Remaja Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 8(02), 120–130. <https://doi.org/10.21009/jkkp.082.01>
- Marsella, W., & Afrizal, S. (2022). Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.26418/skjpi.v2i2.54785>
- Mursid, A., Erviana, Irwan, M., Indrawati, & Evidamayanti. (2023). Kebutuhan Praktik Keperawatan Keluarga: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 8(3), 89–94.
- Nadirawati. (2018). *Buku Ajar Asuhan Keerawatan Keluarga Teori dan Aplikasi Praktik* (Anna (ed.); 1st ed.). Refika Aditama.
- PATIMAH, I. S. F. (2020). Transformasi Bentuk dan Fungsi Keluarga di Desa Mekarwangi. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4(1), 12. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.23405>
- Pratiwi, N., Arif Maulana, N., Ismail, A. Z., Uin, S., Gunung, D., & Bandung, I. ; (2023). Dinamika Interaksi Keluarga dalam Era Digital: Implikasi terhadap Hubungan Orang Tua-Anak. *P O l i t i c A*, 13(2), 77–86. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/socio-politica>
- Prayitno, I. H., Sofwan, E., & Ibrohim, I. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan. *Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 70–85. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/grd/article/view/12828>

- Riyono, B. (2022). Keluarga sebagai Fondasi Peradaban Bangsa: Sebuah Strategi Memanfaatkan Bonus Demografi secara Optimal. *Buletin Psikologi*, 30(1), 59. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.68234>
- Rizkillah, R. (2022). Interaksi Keluarga, Ketahanan Sosial Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Ibu Bekerja Informal Selama Pandemi Covid-19. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 9(01), 102–114. <https://doi.org/10.21009/jkkp.091.09>
- Sari, K. D. N. T. (2022). Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. NL Dengan Pemberian Terapi Komplementer Seduhan Bubuk Kayu Manis Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Di Wilayah Puskesmas Kuta Selatan. *Repository Poltekkes Denpasar*.
- Sinaga, M. H. P., Yasri, A., Nadila, O. R., Geopani, A., & Thasfa, S. A. (2023). Faktor Penyebab Perceraian dan Dampaknya Terhadap Psikis Anak. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2(3), 415–421. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/NJPC/article/view/334>
- Solahudin, M. N., Putra, Y. P., & Fauzi, R. A. (2023). Pendidikan Keluarga: Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Orangtua dalam Mendidik Anak Dewasa Ini. *Jurnal Paud Agapedia*, 7(2), 222–233. <https://doi.org/10.17509/jpa.v7i2.63989>
- Sunarti, E. (2015). Ketahanan keluarga Indonesia: dari kebijakan dan penelitian menuju tindakan. *IPB Press*, 1–67.
- Suradi, S. (2013). Perubahan Sosial Dan Ketahanan Keluarga: Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Lokal. *Sosio Informa*, 18(2), 83–94. <https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.74>
- Suri, G. D., Afdal, A., Afnida, M., Sari, A. K., Hariko, R., Fikri, M., Fadli, R. P., & Cusinia, A. H. (2023). Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak? : analisis pendahuluan intervensi pendidikan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 1072. <https://doi.org/10.29210/1202323434>
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, R. S. (2018). Transkultural Nursing. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, April, 5–24.

- Widyana, A. (2011). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Pendidikan. 1–19.
<https://www.amiwidya.com/2011/07/pendidikan-dan-perubahan-sosial.html?m=1>
- Yahya, S. (2021). Buku ajar keperawatan keluarga. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIKES Panrita Husada Bulukumba I.
https://www.researchgate.net/publication/357339311_BUKU_AJAR_KEPERAWATAN_KELUARGA

BAB 4

MODEL KONSEPTUAL KEPERAWATAN KELUARGA

Tujuan Intruksional:

Mahasiswa mampu memahami berbagai model konseptual dalam keperawatan keluarga sebagai dasar dalam praktik keperawatan komunitas.

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan pengertian model konseptual keperawatan keluarga.
2. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis model konseptual keperawatan keluarga.
3. Mampu menganalisis penggunaan model dalam intervensi keperawatan keluarga.
4. Mampu membandingkan kekuatan dan keterbatasan tiap model.

Pendahuluan:

Keperawatan keluarga merupakan salah satu cabang dari keperawatan komunitas yang memiliki peran penting dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap keluarga sebagai unit pelayanan kesehatan. Keluarga dianggap sebagai unit dasar dalam masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap status kesehatan individu, sehingga pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci dalam pemberian asuhan keperawatan yang efektif. Dalam kerangka ini, diperlukan pemahaman mendalam mengenai berbagai model konseptual yang dapat dijadikan landasan dalam pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan intervensi, serta evaluasi hasil tindakan keperawatan kepada keluarga.

Model konseptual keperawatan keluarga merupakan alat bantu berpikir sistematis yang memungkinkan perawat mengidentifikasi berbagai aspek dalam dinamika keluarga, baik dari sisi struktur, fungsi, hubungan antaranggota, hingga faktor-faktor eksternal yang memengaruhi perilaku kesehatan keluarga. Penggunaan model yang tepat memungkinkan perawat untuk memahami kompleksitas masalah kesehatan keluarga dan menyusun intervensi yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi keluarga itu sendiri.

Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat saat ini turut memberikan pengaruh besar terhadap pola interaksi dalam keluarga. Oleh karena itu, pemilihan model konseptual keperawatan yang relevan menjadi semakin penting agar intervensi keperawatan dapat dilakukan secara kontekstual dan komprehensif.

Misalnya, perawat yang menangani keluarga urban dengan tingkat mobilitas tinggi akan membutuhkan pendekatan berbeda dengan keluarga di daerah rural yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional.

Model-model seperti Friedman, Calgary Family Assessment Model (CFAM), dan McGill telah banyak digunakan oleh praktisi keperawatan keluarga di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Masing-masing model memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, seperti struktur dan fungsi keluarga, kekuatan dan potensi keluarga, hingga aspek perkembangan dan konteks sosial budaya. Perawat perlu memahami kelebihan dan keterbatasan setiap model untuk dapat menyesuaikan pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga yang dilayani.

Selain itu, model bio-psiko-sosial-spiritual yang mengintegrasikan berbagai dimensi dalam kehidupan manusia memberikan pendekatan holistik dalam memahami masalah kesehatan keluarga. Model ini menekankan bahwa kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, namun juga kondisi psikologis, hubungan sosial, dan spiritualitas yang dianut oleh individu dan keluarganya. Dengan memahami keempat dimensi tersebut, perawat dapat memberikan intervensi yang lebih bermakna dan berdampak jangka panjang.

Dengan memahami berbagai model konseptual dalam keperawatan keluarga, diharapkan mahasiswa keperawatan memiliki bekal teoritis yang kuat serta keterampilan praktis dalam melakukan pendekatan kepada keluarga sebagai klien. Pengetahuan ini akan sangat berguna dalam praktik klinik, praktik komunitas, maupun dalam pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan keluarga berbasis bukti.

A. Pengantar Model Konseptual Keperawatan Keluarga

Model konseptual merupakan representasi teoretis yang memberikan kerangka kerja dalam memahami dan merancang praktik keperawatan. Dalam konteks keperawatan keluarga, model ini berfungsi sebagai panduan untuk menilai kondisi keluarga, menyusun intervensi yang tepat, serta mengevaluasi hasil intervensi secara sistematis. Model konseptual juga membantu perawat dalam melihat keluarga sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi, memiliki peran dan fungsi, serta dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Model konseptual dalam keperawatan keluarga adalah kerangka berpikir yang membantu perawat memahami, menilai, dan merancang intervensi keperawatan berdasarkan dinamika, struktur, dan fungsi keluarga. Model ini tidak hanya memberikan landasan teori yang kuat dalam praktik keperawatan keluarga, tetapi juga mengarahkan perawat untuk mengambil keputusan klinis yang lebih tepat dan sistematis.

Keperawatan keluarga merupakan bagian dari keperawatan komunitas yang menitikberatkan pada keluarga sebagai unit pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, keluarga dipandang sebagai sistem terbuka yang dinamis dan kompleks. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada satu anggota keluarga akan memengaruhi seluruh sistem keluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap model konseptual menjadi sangat penting agar intervensi yang diberikan tidak hanya berfokus pada individu tetapi juga pada aspek-aspek sistemik keluarga.

Tujuan utama dari penggunaan model konseptual adalah untuk:

1. Menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memahami masalah kesehatan dalam konteks keluarga
2. Menyusun pendekatan intervensi yang tepat berdasarkan analisis struktur dan fungsi keluarga
2. Meningkatkan akurasi pengkajian dan efisiensi dalam pemberian asuhan keperawatan
3. Mendorong keterlibatan keluarga dalam proses perawatan
4. Meningkatkan kualitas layanan keperawatan berbasis keluarga

Penggunaan model konseptual memungkinkan perawat untuk melakukan pendekatan holistik dan terstruktur dalam menghadapi berbagai kondisi keluarga, baik dalam situasi akut maupun kronik. Beberapa model konseptual yang umum digunakan antara lain adalah Model Friedman, Calgary Family Assessment Model (CFAM), Model McGill, Model Bio-Psiko-Sosial-Spiritual, dan Family Systems Theory.

Masing-masing model memiliki ciri khas dan fokus yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan konteks praktik keperawatan

Dalam uraian berikut akan dijelaskan lebih detail mengenai dua model konseptual utama, yaitu Model Friedman dan CFAM, yang paling banyak digunakan dalam praktik keperawatan keluarga di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

B. Model Friedman

Model Friedman dikembangkan oleh Marilyn M. Friedman dan berfokus pada keluarga sebagai institusi sosial yang menjalankan berbagai fungsi penting. Model ini menilai keluarga dari lima dimensi utama: struktur keluarga, fungsi keluarga, tahap perkembangan keluarga, mekanisme koping, dan interaksi keluarga dengan lingkungan. Model Friedman menempatkan keluarga sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Model Friedman merupakan salah satu model konseptual paling awal dan paling banyak digunakan dalam praktik keperawatan keluarga. Model ini dikembangkan oleh Marilyn M. Friedman yang menempatkan keluarga sebagai institusi sosial yang kompleks dan dinamis. Dalam pandangan Friedman, keluarga bukan hanya sekumpulan individu yang tinggal bersama, tetapi merupakan sistem yang memiliki struktur, fungsi, dan hubungan internal serta eksternal yang memengaruhi kondisi kesehatan anggotanya

Friedman memandang keluarga sebagai unit pelayanan kesehatan yang penting. Dalam sistem kesehatan masyarakat, keluarga memiliki peran sebagai pelaku utama dalam pengambilan keputusan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, serta rehabilitasi anggota keluarga yang sakit. Oleh karena itu, pendekatan keperawatan terhadap keluarga harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai struktur dan fungsi keluarga.

Fungsi keluarga menurut Friedman meliputi:

1. Fungsi afektif (kasih sayang dan dukungan emosional)
2. Fungsi sosialisasi (pembelajaran nilai dan norma)
3. Fungsi reproduksi (melanjutkan keturunan)
4. Fungsi ekonomi (pemenuhan kebutuhan material)
5. Fungsi perawatan kesehatan (peran dalam pemeliharaan dan pengobatan)

Kelebihan model ini adalah pendekatannya yang holistik dan komprehensif, namun memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan pengkajian secara menyeluruh.

Komponen Utama Model Friedman

1. Struktur Keluarga

Struktur keluarga mencakup komposisi, jenis keluarga (nuklir, besar, campuran), jumlah anggota, relasi antaranggota, serta peran yang dijalankan dalam keluarga. Struktur ini memengaruhi cara keluarga mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan mendukung kesehatan

2. Fungsi Keluarga

Model Friedman mengidentifikasi lima fungsi utama keluarga

- a. Fungsi afektif: mencakup perasaan kasih sayang, cinta, dan keamanan emosional antaranggota keluarga.
- b. Fungsi sosialisasi: pengenalan nilai, norma, dan budaya kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak.
- c. Fungsi reproduksi: berkaitan dengan proses melahirkan dan membesarkan keturunan.
- d. Fungsi ekonomi: upaya keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dasar.
- e. Fungsi perawatan kesehatan: peran keluarga dalam menjaga kesehatan, memberikan perawatan dasar, dan pengambilan keputusan terhadap akses pelayanan kesehatan.

3. Tahap Perkembangan Keluarga

Friedman menggunakan tahapan perkembangan keluarga berdasarkan daur hidup, seperti keluarga baru menikah, keluarga dengan anak kecil, keluarga dengan anak remaja, hingga keluarga dengan lansia. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang perlu diselesaikan agar keluarga tetap sehat secara fungsional.

4. Koping dan Sumber Daya

Kemampuan keluarga dalam mengatasi stres dan krisis juga menjadi perhatian dalam model ini. Strategi koping meliputi penggunaan sumber daya internal (dukungan emosional, kepercayaan, komunikasi) dan sumber daya eksternal (dukungan dari komunitas, institusi kesehatan, bantuan profesional).

5. Interaksi dengan Lingkungan

Keluarga berinteraksi dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan fisik. Lingkungan ini dapat menjadi pendukung atau hambatan dalam menjalankan fungsi keluarga. Perawat perlu menilai sejauh mana keluarga memanfaatkan sumber daya lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Aplikasi Praktik Model Friedman

Dalam praktik keperawatan, model Friedman digunakan untuk melakukan pengkajian keluarga secara menyeluruh. Pengkajian ini dilakukan dengan

wawancara, observasi, serta penggunaan instrumen atau kuesioner untuk mengidentifikasi kondisi struktur, fungsi, dan dinamika keluarga.

Contoh:

Seorang perawat melakukan kunjungan ke rumah keluarga dengan anak penyandang disabilitas. Dengan menggunakan Model Friedman, perawat menilai:

1. Struktur keluarga: siapa saja yang tinggal serumah, siapa yang menjadi caregiver utama.
2. Fungsi keluarga: apakah ada dukungan emosional antara orang tua dan anak, bagaimana peran saudara kandung.
3. Tahap perkembangan: apakah keluarga berada di fase perkembangan yang selaras atau mengalami hambatan.
4. Koping: bagaimana keluarga mengatasi stres akibat beban merawat.
5. Lingkungan: apakah keluarga mendapatkan bantuan dari komunitas atau layanan sosial.

Kelebihan dan Kelemahan Model Friedman

Kelebihan:

1. Komprehensif dan sistematis.
2. Mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga.
3. Dapat diaplikasikan pada berbagai tipe keluarga dan konteks budaya.

Kelemahan:

1. Memerlukan waktu dan keterampilan wawancara yang baik.
2. Kurang fleksibel dalam kondisi krisis akut yang membutuhkan tindakan cepat.
3. Belum secara eksplisit mengintegrasikan aspek spiritualitas yang penting dalam beberapa budaya.

Model Friedman sangat bermanfaat untuk memahami konteks keluarga secara utuh, dan memberikan arah dalam menyusun rencana keperawatan keluarga yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien. Model ini juga mendorong kolaborasi aktif antara perawat dan keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

C. Calgary Family Assessment Model (CFAM)

CFAM adalah model yang dikembangkan oleh Wright dan Leahey, digunakan untuk melakukan pengkajian sistemik terhadap keluarga. Model ini dibagi dalam tiga domain utama, yaitu struktur, perkembangan, dan fungsi keluarga.

1. Struktur keluarga: mencakup struktur internal (komposisi, gender, peran), eksternal (keluarga besar, jaringan sosial), dan konteks (budaya, status sosial ekonomi).
2. Perkembangan keluarga: berkaitan dengan tahap kehidupan keluarga dan tugas perkembangan.
3. Fungsi keluarga: mencakup fungsi instrumental (aktivitas harian) dan fungsi ekspresif (komunikasi, kepercayaan, hubungan afektif).

CFAM mempermudah perawat untuk melihat secara menyeluruh kondisi keluarga dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan intervensi.

Calgary Family Assessment Model (CFAM) adalah model pengkajian keluarga yang dikembangkan oleh Lorraine M. Wright dan Maureen Leahey di University of Calgary, Kanada. Model ini dikembangkan berdasarkan pendekatan sistemik, perkembangan, dan fungsional terhadap keluarga. CFAM telah menjadi salah satu model paling terkenal dan banyak digunakan dalam praktik keperawatan keluarga, karena menyajikan kerangka kerja yang komprehensif, praktis, dan fleksibel untuk memahami dinamika keluarga.

CFAM bertujuan untuk memberikan panduan bagi perawat dalam menilai berbagai dimensi penting dalam kehidupan keluarga. Pengkajian ini mencakup struktur keluarga, perkembangan keluarga, dan fungsi keluarga yang masing-masing memiliki subkomponen rinci. CFAM juga menggunakan alat bantu visual seperti genogram dan ecomap untuk membantu menggambarkan sistem keluarga dan hubungannya dengan lingkungan eksternal.

Komponen Utama CFAM

CFAM terdiri dari tiga domain utama, yaitu:

1. Struktur Keluarga

Struktur keluarga dalam CFAM terdiri dari tiga subkategori:

- a. Struktur Internal: mencakup komposisi keluarga, jenis kelamin, orientasi seksual, peran, dan batasan antaranggota.
- b. Struktur Eksternal: mencakup keluarga besar dan hubungan dengan sistem sosial di luar keluarga inti, seperti teman, institusi, dan masyarakat.
- c. Struktur Konteks: mencakup aspek etnis, ras, status sosial ekonomi, budaya, keyakinan agama, dan lingkungan fisik tempat tinggal keluarga.

2. Perkembangan Keluarga

Perkembangan keluarga berfokus pada tahap kehidupan keluarga berdasarkan siklus hidup dan tugas perkembangan yang relevan. Misalnya, keluarga dengan anak usia dini memiliki tantangan berbeda dibandingkan dengan keluarga lanjut usia. CFAM menilai sejauh mana keluarga menyelesaikan

tugas-tugas perkembangan dan bagaimana perawat dapat membantu mendukung adaptasi yang sehat.

3. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga dikaji dalam dua kategori:

- a. Fungsi Instrumental: mencakup aktivitas kehidupan sehari-hari seperti makan, tidur, mandi, dan merawat anggota yang sakit.
- b. Fungsi Ekspresif: mencakup komunikasi, peran, afeksi, pola interaksi, dukungan emosional, pemecahan masalah, keyakinan, dan nilai keluarga

Langkah-Langkah Penggunaan CFAM

1. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.
2. Pembuatan genogram dan ecomap.
2. Penilaian struktur, perkembangan, dan fungsi.
3. Analisis kekuatan dan kelemahan keluarga.
4. Perumusan masalah keperawatan.
5. Perencanaan intervensi berbasis keluarga.
6. Evaluasi respons keluarga terhadap intervensi.

Kelebihan CFAM

1. Komprehensif dan sistematis.
2. Menyediakan alat bantu visual (genogram dan ecomap) untuk pemahaman cepat.
3. Fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai konteks budaya dan situasi klinis.
4. Fokus pada kekuatan keluarga dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan.
5. Mengakomodasi dimensi psikososial dan spiritual.

Keterbatasan CFAM

1. Membutuhkan pelatihan dan pengalaman agar dapat digunakan secara efektif.
2. Proses pengkajian yang mendalam memerlukan waktu yang relatif lama.
3. Penggunaan genogram dan ecomap bisa membingungkan jika tidak terbiasa.

Aplikasi Praktik CFAM

CFAM banyak digunakan dalam kunjungan rumah, layanan keperawatan komunitas, perawatan paliatif, dan pengelolaan penyakit kronis. Misalnya, dalam kunjungan ke keluarga dengan anak penderita epilepsi, perawat menggunakan genogram untuk mengidentifikasi pola penyakit dalam keluarga dan ecomap untuk mengidentifikasi sumber dukungan sosial.

Contoh Studi Kasus:

Keluarga S terdiri dari pasangan suami istri dan tiga anak. Anak kedua mengalami autisme. Perawat menggunakan CFAM untuk:

1. Menilai komposisi keluarga, peran masing-masing anggota, dan nilai budaya mereka.

2. Menggambarkan hubungan mereka dengan sekolah khusus dan organisasi pendukung autisme melalui ecomap.
3. Menilai bagaimana keluarga berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan berbagi tanggung jawab.

Berdasarkan hasil pengkajian, intervensi difokuskan pada peningkatan komunikasi keluarga dan pelatihan coping bagi orang tua, serta memperkuat hubungan dengan sumber dukungan eksternal.

Kesimpulan

CFAM merupakan model pengkajian keluarga yang sangat kaya dan terstruktur. Dengan menggunakan CFAM, perawat dapat memahami keluarga secara menyeluruh, mengidentifikasi kekuatan dan masalah yang ada, serta merancang intervensi yang tepat dan berpusat pada keluarga. Penggunaan model ini mendukung tercapainya asuhan keperawatan yang komprehensif, kolaboratif, dan sensitif terhadap konteks budaya dan sosial keluarga.

D. Model McGill

Model McGill merupakan pendekatan keperawatan keluarga yang dikembangkan dengan fokus pada promosi kesehatan dan kekuatan keluarga. Model ini lebih menekankan pada kemampuan keluarga dalam menghadapi masalah kesehatan dan peran aktif keluarga dalam proses penyembuhan. Komponen utama dalam model ini adalah:

1. Kekuatan dan sumber daya keluarga
2. Kemitraan antara perawat dan keluarga
3. Tujuan bersama dalam peningkatan kesehatan

Model McGill menghindari fokus pada defisit dan lebih melihat apa yang dimiliki oleh keluarga, bukan apa yang kurang. Pendekatan ini sangat sesuai untuk intervensi promosi kesehatan berbasis komunitas dan pemberdayaan keluarga.

E. Model Bio-Psiko-Sosial-Spiritual

Model ini menggabungkan empat dimensi utama yang saling memengaruhi dalam kehidupan manusia: biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam konteks keperawatan keluarga, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap kondisi pasien dan keluarganya.

Dimensi yang terlibat:

1. Biologis: kondisi fisik dan medis anggota keluarga
2. Psikologis: keadaan emosional, stres, mekanisme coping
3. Sosial: hubungan interpersonal, dukungan sosial, peran dalam keluarga

4. Spiritual: nilai, kepercayaan, makna hidup

Model ini sangat bermanfaat dalam situasi kompleks seperti penyakit kronis, terminal, atau trauma psikososial dalam keluarga.

F. Teori Sistem Keluarga dan Model Struktural-Fungsional

Teori Sistem Keluarga menyatakan bahwa keluarga adalah sistem yang terdiri atas individu yang saling berinteraksi. Perubahan dalam satu anggota akan memengaruhi seluruh sistem. Intervensi keperawatan perlu mempertimbangkan dampak tersebut secara menyeluruh.

Model Struktural-Fungsional menekankan pada peran dan fungsi sosial keluarga. Fungsi utama seperti sosialisasi, dukungan emosional, ekonomi, dan perawatan menjadi dasar dalam pengkajian keluarga.

Kedua pendekatan ini memperkaya perspektif perawat dalam memahami dinamika keluarga dan menetapkan prioritas intervensi.

G. Latihan Soal

Pilihan Ganda:

1. Model Friedman menekankan pada fungsi keluarga berikut, kecuali...
 - A. Afektif
 - B. Sosialisasi
 - C. Reproduksi
 - D. Pendidikan
 - E. Perawatan kesehatan
2. Model CFAM terdiri dari domain utama berikut, kecuali...
 - A. Struktur
 - B. Perkembangan
 - C. Fungsi
 - D. Patologi
 - E. Konteks
3. Model McGill berfokus pada pendekatan...
 - A. Defisit keluarga
 - B. Kekuatan keluarga
 - C. Medis kuratif
 - D. Komunikasi negatif
 - E. Penekanan pada kelemahan

4. Dalam model bio-psiko-sosial-spiritual, aspek spiritual mencakup...
 - A. Penyakit keturunan
 - B. Praktik medis tradisional
 - C. Makna hidup dan kepercayaan
 - D. Sistem dukungan ekonomi
 - E. Interaksi antar keluarga
5. Family Systems Theory menekankan bahwa...
 - A. Setiap anggota berdiri sendiri
 - B. Perubahan satu anggota mempengaruhi seluruh sistem
 - C. Peran tidak saling memengaruhi
 - D. Struktur keluarga tetap
 - E. Fokus hanya pada individu sakit

Esai:

1. Jelaskan secara singkat perbedaan mendasar antara model Friedman dan CFAM.
2. Mengapa penting bagi perawat memahami berbagai model konseptual keperawatan keluarga?
3. Berikan contoh penerapan model McGill dalam situasi keperawatan komunitas.
4. Bagaimana pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual digunakan dalam menghadapi kasus penyakit kronis dalam keluarga?
5. Apa saja kelebihan Family Systems Theory dalam memahami dinamika keluarga?

Kunci Jawaban

1. D
2. D
3. B
4. C
5. B

H. Rangkuman Materi

Model konseptual keperawatan keluarga merupakan kerangka kerja penting dalam memahami struktur, fungsi, dan dinamika keluarga sebagai subjek pelayanan keperawatan. Model Friedman, CFAM, McGill, bio-psiko-sosial-spiritual, Family Systems, dan Structural-Functional memberikan pendekatan yang bervariasi namun saling melengkapi. Pemahaman terhadap model-model ini membantu perawat

dalam memilih pendekatan yang tepat, menyusun intervensi yang sesuai, dan memberikan pelayanan yang berfokus pada keluarga secara holistik.

I. Glosarium

Model Friedman: Model keperawatan keluarga yang menekankan pada lima fungsi utama keluarga.

CFAM: Calgary Family Assessment Model yang digunakan untuk mengkaji struktur, perkembangan, dan fungsi keluarga.

Model McGill: Model yang menekankan kekuatan keluarga dan partisipasi aktif dalam promosi kesehatan.

Bio-Psiko-Sosial-Spiritual: Model holistik yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Family Systems Theory: Teori yang memandang keluarga sebagai sistem dinamis dengan interaksi antaranggota yang saling memengaruhi.

J. Daftar Pustaka

Bomar, P. J. (2004). *Promoting Health in Families: Applying Family Research and Theory to Nursing Practice* (3rd ed.). Saunders.

Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). *Family Nursing: Research, Theory, and Practice* (5th ed.). Pearson Education.

Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. M. H. (2018). *Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research* (6th ed.). F.A. Davis Company.

Purnell, L. D. (2013). *Transcultural Health Care: A Culturally Competent Approach*. F.A. Davis.

Wright, L. M., & Leahey, M. (2013). *Nurses and Families: A Guide to Family Assessment and Intervention* (6th ed.). F.A. Davis Company.

BAB 5

MANAJEMEN SUMBER DAYA KELUARGA

Tujuan Intruksional Umum:

Setelah Proses Pembelajaran, Mahasiswa Mampu Memahami Konsep Manajemen Sumber Daya Keluarga

Tujuan Intruksional Khusus;

Setelah proses pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan kembali konsep manajemen sumber daya keluarga, dengan indikator;

1. Menjelaskan Konsep Dasar Sumber Daya Keluarga
2. Menjelaskan Klasifikasi Sumber Daya Keluarga
3. Menjelaskan Penggunaan Sumber Daya Keluarga
4. Menjelaskan Cara Mengukur Sumber Daya Keluarga
5. Menjelaskan Pengertian Manajemen Sumber Daya Keluarga
6. Menjelaskan Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Sumber Daya Keluarga
7. Sistem/ Proses Manajemen Sumber Daya Keluarga
8. Sifat Manajemen Sumber Daya Keluarga

Capaian Pembelajaran:

1. Kognitif

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen sumber daya keluarga dalam konteks keperawatan keluarga.
- b. Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi manajemen sumber daya dalam keluarga.
- c. Mahasiswa mampu mengidentifikasi strategi optimalisasi sumber daya keluarga untuk meningkatkan kesehatan keluarga.

2. Afektif

- a. Mahasiswa menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sumber daya keluarga dalam memberikan asuhan keperawatan.
- b. Mahasiswa menghargai keberagaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi manajemen sumber daya keluarga.
- c. Mahasiswa memiliki sikap empati dan responsif dalam mendampingi keluarga dalam pengelolaan sumber daya kesehatan.

3. Psikomotor

- a. Mahasiswa mampu melakukan asesmen terhadap sumber daya keluarga dalam konteks keperawatan.
- b. Mahasiswa mampu menyusun rencana intervensi keperawatan berbasis manajemen sumber daya keluarga.
- c. Mahasiswa mampu memberikan edukasi kepada keluarga mengenai strategi optimalisasi sumber daya untuk mendukung kesehatan.

Pendahuluan:

Manajemen sumber daya keluarga (MSDK) merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup anggota keluarga. Buku ini hadir sebagai panduan yang komprehensif bagi pembaca dalam memahami konsep, prinsip, dan praktik terbaik dalam mengelola sumber daya keluarga secara efektif dan efisien. Dengan penyajian yang sistematis dan berbasis pada penelitian serta pengalaman praktis, buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembaca dalam berbagai konteks kehidupan keluarga.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai manajemen sumber daya keluarga, termasuk strategi dalam mengelola keuangan, waktu, energi, serta aspek psikologis dan sosial dalam kehidupan berkeluarga. Dengan memahami konsep-konsep ini, pembaca diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai keseimbangan dan kesejahteraan keluarga.

Buku ini dirancang untuk mahasiswa, akademisi, praktisi, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang manajemen sumber daya keluarga. Khususnya, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi di bidang ilmu keperawatan keluarga dan disiplin ilmu lain yang berkaitan. Buku ini terdiri dari beberapa pokok bahasan yang mencakup berbagai aspek manajemen sumber daya keluarga, antara lain: Konsep Dasar Sumber Daya Keluarga, Klasifikasi Sumber Daya Keluarga, Penggunaan Sumber Daya Keluarga, Cara Mengukur Sumber Daya Keluarga, Pengertian Manajemen Sumber Daya Keluarga, Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Sumber Daya Keluarga, Sistem /Proses Manajemen Sumber Daya Keluarga, dan Sifat Manajemen Sumber Daya Keluarga.

Buku ini menggunakan pendekatan interaktif dalam pembelajaran, termasuk studi kasus, latihan reflektif, dan diskusi kelompok. Dengan metode ini, pembaca tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dapat digunakan baik secara mandiri maupun dalam konteks pembelajaran formal di institusi pendidikan. Setiap pokok bahasan disusun secara sistematis dengan tujuan pembelajaran yang jelas, dan disertai dengan

ringkasan dan pertanyaan reflektif untuk membantu pemahaman dan penerapan konsep yang telah dipelajari.

Dengan membaca dan memanfaatkan buku ini secara optimal, diharapkan pembaca dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya keluarga dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Sumber Daya Keluarga

Sumber daya adalah segala sesuatu (bisa dalam bentuk material atau non-material) yang dimiliki dan tersedia serta diketahui potensi manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis individu, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Dalam konteks kehidupan keluarga, tentu dalam setiap proses penyelenggaraan aktivitas sehari-hari tidak akan mungkin bisa lepas dari kebutuhan akan sumber daya. Sekecil apapun tujuan dan harapan sebuah keluarga, sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki.

Sumber daya ini dapat berupa; uang, barang, jasa, cinta dan mencintai, informasi, hubungan sosial, dll. Sumber daya dalam bentuk materi adalah sumber daya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan fisik (uang dan aset/barang), sementara, sumber daya non-materi adalah sumber daya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan psikologis (misal; cinta, informasi, identitas, jasa, dll). Oleh karena itu penting bagi seorang perawat untuk dapat mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki keluarga untuk membantu keluarga dalam manajemen masalah Kesehatan yang dialami.

Terdapat empat asumsi dasar yang penting diketahui sehubungan dengan Sumber Daya Keluarga (SDK), yaitu; 1) SDK tidak hanya terdapat di dalam keluarga tetapi juga dapat ditemukan diberbagai lingkungan sekitar keluarga; 2) SDK merupakan bagian dari sistem yang dapat menjadi sumber pendukung, atau justru dapat menjadi sumber penghambat dalam mencapai tujuan; 3) SDK tidak selalu dalam bentuk material (yang dapat dilihat oleh kasat mata), tetapi dapat juga dalam bentuk non material (misal waktu, kesehatan, kebahagiaan, dll); 4) Perubahan terhadap salah satu sumber daya di keluarga, akan memengaruhi sumber daya lainnya dalam sistem keluarga (Juniarti, 2015)

B. Klasifikasi Sumber Daya Keluarga

Sumber daya keluarga adalah alat atau bahan yang tersedia dan diketahui potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan keluarga. Menurut Guharja (1993), sumber daya keluarga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu;

1. Sumber daya manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks keluarga merujuk pada potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam keluarga, dalam hal ini termasuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan

kesejahteraan keluarga. Secara sederhana sumber daya ini erat kaitannya dengan kualitas individu dalam keluarga, dan memiliki dua ciri utama, yaitu Personal dan Interpersonal

a. Ciri Personal

Ciri personal dapat dinilai dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

1) Kognitif;

Terdiri dari tahapan mengetahui, memahami, menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi. Kegunaan sumber daya ini antara lain untuk: a) Mengidentifikasi hal-hal yang menyangkut sumber daya; b) Menganalisis alternatif-alternatif dalam pengambilan keputusan; dan c) Mengevaluasi kemungkinan yang realistis untuk mencapai tujuan.

2) Afektif;

Afektif atau sikap merupakan jenis perilaku yang tidak tampak oleh mata, hanya dapat dipersepsikan. Beberapa kegunaan dari sumber daya ini adalah untuk menumbuhkan rasa percaya, empati, meningkatkan kerjasama & gotong royong serta menciptakan rasa berguna dan peduli kepada orang lain.

3) Psikomotor;

Ciri psikomotor individu dapat dilihat dari status kesehatan, bakat, tingkat intelegensia, minat, sensitivitas, kemampuan dalam melakukan suatu tindakan, dll

b. Ciri Interpersonal

Interpersonal adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan orang lain. Beberapa ciri utama keterampilan interpersonal sebagai berikut; 1) Komunikasi Efektif: Kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif; 2) Empati: Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain; 3) Kerja Sama: Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan orang lain; 4) Manajemen Konflik: Kemampuan untuk menangani dan menyelesaikan konflik secara konstruktif; dan 5) Keterampilan Sosial: Kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan orang lain (Suwatno & Arviana N, 2023)

2. Sumber daya Non Manusia/Materi

Sumber daya non-manusia atau materi dalam konteks sumber daya keluarga adalah segala bentuk aset fisik dan non-fisik yang dimiliki oleh keluarga untuk mencapai tujuan hidup mereka. Menurut Fitriana et al. dalam buku "Pengelolaan Sumber Daya Keluarga" (2017), sumber daya ini meliputi: a) Barang Tahan Lama: Peralatan rumah tangga seperti lemari es, mesin cuci, dan kendaraan

yang memiliki masa pakai panjang dan mendukung aktivitas keluarga sehari-hari; b) Barang Habis Pakai: Barang yang digunakan dan habis dalam waktu singkat, seperti makanan, produk kebersihan, dan bahan bakar; c) Aset Keuangan: Uang tunai, tabungan, investasi, dan sumber pendapatan lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan merencanakan masa depan keluarga; dan d) Properti: Kepemilikan atas tanah, rumah, atau properti lain yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau sumber pendapatan tambahan. Pengelolaan yang efektif dari sumber daya materi ini memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka, merencanakan masa depan, dan mencapai tujuan yang diinginkan (Fitriana dkk, 2017)

3. Sumber Daya Waktu

Waktu adalah sumber daya unik, dikatakan unik karena waktu tidak dapat ditambah, dikurangi, diakumulasi, atau disimpan. Setiap individu memiliki jumlah waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari, namun demikian penggunaan waktu tiap – tiap individu berbeda antara satu dengan yang lain, meskipun terkadang mempunyai tujuan dan atau masalah yang sama, sehingga ketepatan dalam manajemen waktu menjadi krusial dalam mencapai tujuan keluarga.

Ketiga jenis sumber daya ini merupakan satu kesatuan sumber daya total yang dimiliki oleh suatu keluarga dan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan keluarga yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan tujuan keluarga, maka sumber daya tidak berdiri sendiri. Masing-masing jenis sumber daya saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya, dimana secara keseluruhan digunakan dalam perencanaan keluarga yang kemudian diterapkan dalam pelaksanaan dalam mencapai suatu tujuan (Guharja. 1993).

Sumber daya keluarga dapat diidentifikasi berdasarkan nilai ekonomi (Juniarti, 2015), yaitu:

1. Sumber daya ekonomi (*Home economics*)

Sumber daya yang dapat dipertukarkan dan diukur bukan hanya untuk tujuan konsumsi tetapi untuk proses produksi dan distribusi seperti lahan, tenaga kerja, modal, keterampilan dan segala sesuatu yang ada di dalam dan diluar keluarga yang bermanfaat.

2. Sumber daya non ekonomi

Sumber daya non-ekonomi dalam konteks keluarga adalah aset yang tidak memiliki nilai moneter langsung tetapi sangat penting untuk kesejahteraan dan fungsi keluarga. Menurut Juniarti (2008), sumber daya non-ekonomi memiliki ciri-ciri seperti jumlah yang relatif tidak terbatas, tidak dapat dipertahankan, dan sulit diukur. Contohnya meliputi kasih sayang, perhatian, minat, dan motivasi individu.

Selain itu, sumber daya non-ekonomi juga mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, bakat, tingkat intelegensia, minat, dan sensitivitas. Ciri interpersonal seperti hak asasi manusia, kerjasama, gotong royong, dan keterbukaan antar personal juga termasuk dalam kategori ini. Sumber daya non-ekonomi, seperti air, udara, dan angin, tersedia di alam bebas dan tidak memerlukan biaya untuk memperolehnya (Hasanah, U., & Martiastuti, K., 2020). Namun, dalam kondisi tertentu, sumber daya ini dapat berubah menjadi sumber daya ekonomi jika memerlukan pengorbanan atau biaya untuk mendapatkannya. Pemahaman tentang sumber daya non-ekonomi penting bagi keluarga untuk mengelola dan memanfaatkan aset-aset ini secara optimal guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

C. Penggunaan Sumber Daya Keluarga

Setiap sumber daya yang masuk dalam sistem keluarga akan digunakan dalam beberapa alternatif tindakan oleh keluarga (Guhardja, 1993). Berbagai bentuk penggunaan sumber daya tersebut meliputi:

1. Pertukaran

Pertukaran sumber daya keluarga, dapat terjadi baik di dalam keluarga atau di luar dengan orang lain, sebagai contoh antara kakak dengan adik, antara keluarga dengan tetangga. Dan sumber daya yang dipertukarkan dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari pertukaran ini dapat menyebabkan berkurangnya atau bertambahnya suatu sumber daya yang lain. Dapat pula diperoleh sumber daya yang lebih besar dari yang diberikan atau lebih kecil atau tetap nilainya.

Jika nilai tukar ini menjadi kecil maka diperlukan usaha untuk mengembangkan sumber daya yang ditukarkan itu menjadi lebih berkualitas agar mempunyai nilai tukar yang lebih tinggi. Adapun pertukaran antara waktu dan jasa sukar untuk diukur karena keduanya tidak berwujud. Sebagai contoh, penggunaan waktu untuk bekerja, kemudian dari penggunaan itu diperoleh imbalan. Imbalan itu bukan semata-mata merupakan nilai dari waktu yang dipertahankan, tetapi sumber daya lain pun ikut berperan (Guhardja, 1993)

2. Konsumsi

Konsumsi merupakan salah satu cara penggunaan sumber daya melalui fungsi utilitas. Dengan kegiatan konsumsi tentu akan mengurangi jumlah sumber daya bahkan dapat habis apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya. Salah satu tujuan kegiatan konsumsi ini adalah untuk peningkatan kualitas kehidupan keluarga (Guhardja, 1993). Misal; konsumsi makanan gizi

seimbang, tentu bertujuan memenuhi aspek gizi pada seluruh anggota keluarga. Penggunaan uang untuk membayar jasa yang telah digunakan, dll

3. Proteksi

Proteksi adalah suatu cara pengurangan sumber daya untuk mencegah sebuah risiko yang tidak diinginkan/tidak diharapkan. Proteksi ini dapat bersifat formal yaitu melalui suatu perusahaan jasa asuransi, misalnya, untuk asuransi jiwa, kesehatan dan asuransi tenaga kerja. Selain itu, proteksi juga dapat dilakukan secara tidak formal yaitu dilakukan sendiri tanpa melalui perusahaan jasa asuransi, misalnya dengan cara: menukar uang rupiah dengan dolar, memberi barang-barang setelah mendengar isu bahwa akan ada devaluasi. Melalui proteksi ini pada suatu saat sumber daya yang terkena resiko akan dimiliki kembali (Guhardja, 1993).

4. Transfer

Transfer adalah kegiatan yang dapat mengurangi sumber daya keluarga. Transfer satu arah yang terjadi dalam keluarga tidak akan mengurangi sumber daya keluarga secara keseluruhan. Misalnya, seorang kakak memberi sesuatu kepada adiknya, maka dilihat dari segi keluarga sumber daya itu tidak akan berkurang. Transfer satu arah yang terjadi antar keluarga dapat mengurangi sumber daya keluarga yang satu namun akan menambah sumber daya keluarga yang lain (Guhardja, 1993).

5. Produksi

Produksi merujuk pada kemampuan keluarga untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal. Kegiatan produksi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan keterampilan anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sebagai contoh, usaha tani merupakan usaha produksi yang menghasilkan bahan makanan dan bahan industri untuk kepentingan kehidupan manusia. Sedangkan sumber daya yang digunakan dalam usaha tani disebut faktor produksi (Guhardja, 1993). Dengan demikian, produksi dalam konsep sumber daya keluarga adalah upaya terstruktur yang melibatkan pengelolaan berbagai sumber daya internal untuk menghasilkan output yang bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga (Eriawati dkk, 2024).

6. Tabungan

Tabungan merupakan penyimpanan dana yang mudah diakses dan likuid, biasanya ditempatkan di rekening bank atau instrumen keuangan lainnya yang menawarkan tingkat risiko rendah. Tujuannya adalah menyediakan dana yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk kebutuhan mendesak atau tujuan jangka

pendek (El Mujtaba, 2022). Menabung berarti menangguhkan penggunaan sumber daya yang dikonsumsi saat ini. Tabungan yang dilakukan oleh keluarga biasanya dalam bentuk uang, tanah, perhiasan dan ternak (Guhardja, 1993).

7. Investasi

Investasi merupakan penggunaan sumber daya untuk diproses lebih lanjut agar memperoleh nilai tambah. Sebagai contoh, adalah penanam modal dalam suatu usaha. Dalam menginvestasikan modalnya, keluarga akan memperoleh hasil setelah melewati periode tertentu. Pada umumnya perusahaan membagikan hasil keuntungan setahun sekali (Guhardja,).

Investasi melibatkan penempatan dana pada instrumen keuangan atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Instrumen investasi dapat berupa saham, obligasi, reksa dana, atau properti, yang memiliki potensi pertumbuhan nilai namun juga disertai dengan risiko (El Mujtaba, 2022). Dalam konteks keluarga, pengelolaan tabungan dan investasi yang efektif memerlukan perencanaan keuangan yang matang. Penting bagi keluarga untuk memahami tujuan keuangan jangka pendek dan panjang, serta memilih instrumen keuangan yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan mereka.

Penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga harus efektif dan efisien. Secara efektif dalam arti bahwa sumber daya yang digunakan benar-benar diarahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Sedangkan secara efisien dalam arti bahwa, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki diusahakan untuk mencapai kepuasan yang setinggi-tingginya (Guhardja, 1993).

D. Cara Mengukur Sumber Daya Keluarga

Untuk mengukur sumber daya keluarga, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yang mencakup aspek fisik, finansial, sosial, dan manusiawi (Smith J.R & Taylor M.T, 2023). Berikut adalah beberapa metode umum yang dapat digunakan untuk mengukur sumber daya keluarga:

1. Aspek Finansial:

Mengukur sumber daya finansial keluarga dapat dilakukan dengan mengevaluasi jumlah pendapatan rumah tangga, pengeluaran, aset, dan kewajiban keuangan. Data ini dapat diperoleh melalui survei pengeluaran rumah tangga atau catatan keuangan keluarga.

2. Aspek Fisik:

Menilai ketersediaan sarana dan prasarana serta kualitas rumah yang dimiliki (seperti ukuran, kondisi, fasilitas yang ada, dan kenyamanan) serta kemudahan dalam mengakses layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Termasuk

layanan sosial (taman hiburan, tempat ibadah, dll) dan layanan kesehatan, bagaimana ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas Kesehatan (misal akses RS, puskesmas, klinik, dll)

3. Aspek Manusiawi:

Mengukur sumber daya manusiawi mencakup tingkat Pendidikan, yang biasanya dapat menggambarkan Tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan anggota keluarga, serta kesehatan mereka. Informasi ini dapat diperoleh melalui survei keluarga atau wawancara individu.

4. Aspek Sosial:

Sumber daya sosial mencakup jaringan dukungan keluarga dan teman, akses ke komunitas, dan keterlibatan dalam organisasi sosial. Ini juga dapat diukur dengan kuesioner atau wawancara yang mengidentifikasi kualitas hubungan sosial dan tingkat partisipasi.

E. Pengertian Manajemen Sumber Daya Keluarga

Manajemen merupakan serangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan sumber daya, bertujuan untuk mencapai keinginan atau tujuan (Siregar, 2020). Dalam proses manajemen selalu mengedepankan adanya interaksi secara bersama-sama dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas (Fitriana, 2017). Manajemen dalam konteks keluarga dapat diartikan sebagai serangkaian perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi dalam keluarga yang tergambar dalam proses interaksi anggota keluarga satu dengan yang lain, interaksi dengan keluarga besar maupun interaksi dengan lingkungan sosialnya.

Manajemen dalam keluarga harus selalu mengoptimalkan kemampuan kerjasama antar anggota keluarga dalam mengelola sumber daya yang tersedia di keluarga, sehingga dapat meminimalkan keterbatasan anggota – anggota keluarga. Kerjasama yang dibangun dengan baik dapat mengarahkan pada kepuasan dan kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan dengan usaha – usaha yang dilakukan secara individual. Manajemen dalam keluarga akan menggambarkan kemampuan keluarga dalam mengoptimalkan pelaksanaan peran setiap anggota keluarga.

Manajemen dalam keluarga memiliki ciri-ciri penting, yaitu; a). Keluarga mengetahui potensi dari segala sesuatu yang dimiliki sehingga seluruhnya dapat dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga karena kualitas dan kuantitas menejerial setiap keluarga memiliki perbedaan; b) Kecerdasan dan keterampilan keluarga menentukan kualitas manajemen; c) Manajemen keluarga melibatkan pelaksanaan peran, pengoptimalan fungsi keluarga, kemampuan stress dan coping,

lingkungan rumah serta lingkungan sosial; d) Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mentransfer pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan kepada anggota keluarga yang lebih muda supaya dapat menjalankan hal yang sama; dan e) Manajemen di rumah adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan anggota keluarga (Siregar, 2020).

F. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Sumber Daya Keluarga

Manajemen sumber daya keluarga melibatkan pengelolaan berbagai sumber daya, seperti waktu, keuangan, tenaga, dan informasi, untuk mencapai tujuan keluarga secara efektif dan efisien. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya keluarga (Hasan, 2020), yaitu:

1. Kompleksitas kehidupan keluarga.

Keluarga dengan dinamika kehidupan yang kompleks memerlukan pendekatan manajerial yang berbeda dibandingkan keluarga dengan masalah yang lebih sederhana. Manajemen yang dimaksudkan adalah usaha, cara atau strategi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Semakin kompleks masalah maka cara memanajemennya pun dapat semakin bervariasi, artinya keluarga dapat melakukan pemecahan masalah dengan berbagai cara dengan pilihan beberapa alternatif.

2. Stabilitas/ketidakstabilan keluarga.

Keluarga yang kondisi yang stabil (baik secara ekonomi, sosial, spiritual dan psikologis) cenderung dapat melakukan manajemen sumber daya keluarga dengan lebih baik dan rasional, karena seluruh anggota keluarga dapat berpartisipasi dan fokus dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dan sebaliknya pada kondisi dimana keluarga dalam kondisi labil, maka kecenderungan yang terjadi adalah kelemahan dan ketidakberdayaan keluarga dalam manajemen.

3. Peran dan Perubahan Keluarga.

Manajemen sumber daya keluarga juga dipengaruhi oleh peran masing-masing anggota keluarga di masyarakat dan juga oleh perubahan dalam keluarga. Perubahan dalam keluarga, seperti kelahiran anggota baru atau kehilangan anggota keluarga, dapat memengaruhi peran dan dinamika dalam manajemen sumber daya.

4. Teknologi.

Kemajuan teknologi secara positif dapat membantu mempermudah keluarga dalam pengelolaan sumber daya keluarga, seperti melalui penggunaan

berbagai aplikasi keuangan atau alat bantu manajemen waktu, atau pilihan aplikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

G. Sistem/Proses Manajemen Sumber Daya Keluarga

Sistem/proses Manajemen Sumber Daya Keluarga (MSDK) adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengelola berbagai sumber daya dalam keluarga secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup yang optimal melalui pengelolaan waktu, keuangan, komunikasi, organisasi, dan pengembangan keterampilan dalam rumah tangga (Fitriana dkk, 2017). Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, yaitu;

1. Perencanaan:

Tahap perencanaan dalam MSDK merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk memastikan bahwa keluarga dapat mengelola sumber daya mereka secara efektif. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang tahap perencanaan dalam manajemen sumber daya keluarga:

a. Identifikasi Tujuan Keluarga

Perencanaan dimulai dengan menetapkan tujuan keluarga yang jelas. Tujuan ini dapat berkaitan dengan aspek keuangan, pendidikan anak, kesehatan, atau kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Tanpa tujuan yang jelas, perencanaan tidak akan efektif. Contoh: tujuan jangka pendek mungkin adalah menabung untuk pendidikan anak, sementara tujuan jangka panjang bisa berupa membeli rumah atau mempersiapkan pensiun.

b. Identifikasi Sumber Daya Keluarga

Pada tahap ini, keluarga perlu mengevaluasi sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya tersebut dapat dibagi dalam beberapa kategori:

- 1) **Sumber daya manusia:** Anggota keluarga, keahlian, waktu, tenaga, dan kesehatan.
- 2) **Sumber daya keuangan:** Penghasilan, tabungan, investasi, atau utang.
- 3) **Sumber daya fisik:** Rumah, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang lainnya.
- 4) **Sumber daya informasi:** Pengetahuan tentang kesehatan, pendidikan, perencanaan keuangan, atau hukum.

c. Analisis Kebutuhan dan Masalah

Setelah mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, langkah berikutnya adalah menganalisis kebutuhan dan masalah yang ada dalam keluarga. Misalnya, apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan anak,

memperbaiki kondisi rumah, atau menambah penghasilan keluarga. Di sini, prioritas juga sangat penting untuk menentukan mana yang harus didahulukan.

d. Penentuan Alternatif

Setelah mengetahui kebutuhan dan masalah, tahap berikutnya adalah mencari alternatif atau solusi yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, jika tujuan keluarga adalah menabung untuk pendidikan anak, alternatif yang dapat dipilih adalah membuka tabungan pendidikan, berinvestasi di reksa dana, atau mencari tambahan pendapatan melalui pekerjaan sampingan.

e. Pengembangan Rencana Tindakan

Setelah alternatif ditentukan, langkah selanjutnya adalah merancang rencana tindakan yang lebih spesifik. Rencana ini harus mencakup siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tindakan, kapan tindakan tersebut harus dilakukan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Misalnya, jika keluarga ingin mengurangi pengeluaran, maka mereka dapat membuat anggaran bulanan yang lebih ketat dan menentukan batas pengeluaran untuk setiap kategori.

f. Penyusunan Anggaran dan Sumber Daya

Anggaran adalah alat utama dalam perencanaan sumber daya keluarga. Penyusunan anggaran yang realistis dan terperinci akan membantu keluarga untuk memprioritaskan pengeluaran dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Misalnya, alokasi anggaran untuk makanan, transportasi, dan tabungan bisa menjadi komponen penting dalam anggaran rumah tangga.

g. Evaluasi dan Penyesuaian

Perencanaan harus selalu disertai dengan evaluasi berkala. Keluarga perlu memantau apakah rencana yang telah disusun berjalan sesuai harapan atau ada kendala yang perlu disesuaikan. Hal ini penting agar keluarga dapat tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan mereka.

2. Pengorganisasian:

Tahap pengorganisasian dalam MSDK melibatkan penataan dan pembagian tugas serta tanggung jawab di antara anggota keluarga agar setiap individu mengetahui perannya dalam mencapai tujuan keluarga. Proses Pengorganisasian dalam Manajemen Sumber Daya Keluarga:

- a. **Penentuan Struktur Keluarga:** Menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota keluarga sesuai dengan kemampuan, usia, dan kondisi masing-masing. Misalnya, suami sebagai pencari nafkah utama, istri sebagai pengelola rumah tangga, dan anak-anak sebagai pelajar yang membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan mereka.

- b. **Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab:** Membagi pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak-anak secara adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota keluarga. Hal ini memastikan efisiensi dan keseimbangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
- c. **Penetapan Wewenang dan Hak:** Menentukan siapa yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan tertentu dan hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Misalnya, orang tua memiliki wewenang dalam menentukan pendidikan anak, sementara anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- d. **Penyusunan Jadwal dan Rutinitas:** Membuat jadwal harian atau mingguan yang mencakup waktu untuk bekerja, belajar, beristirahat, dan berinteraksi sebagai keluarga. Rutinitas yang terstruktur membantu dalam pengelolaan waktu yang efektif dan mengurangi konflik dalam keluarga.

3. Pengendalian:

Pengendalian dalam manajemen sumber daya keluarga adalah salah satu tahapan penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dalam keluarga dikelola secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, pengendalian berfokus pada memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan berbagai kegiatan serta penggunaan sumber daya yang ada, baik itu berupa waktu, tenaga, finansial, maupun informasi. Langkah-Langkah dalam Pengendalian Manajemen Sumber Daya Keluarga:

- a. Penetapan Standar

Pada tahap ini, keluarga harus menetapkan standar atau target yang jelas terkait dengan penggunaan sumber daya. Misalnya, menetapkan anggaran keluarga untuk pengeluaran bulanan, atau waktu yang digunakan untuk kegiatan belajar anak. Standar ini menjadi tolok ukur yang digunakan untuk menilai apakah sumber daya digunakan dengan baik atau tidak.

- b. Pengukuran Kinerja

Setelah standar ditetapkan, tahap selanjutnya adalah mengukur kinerja terhadap standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengukuran kinerja berarti menilai apakah pengeluaran keluarga sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, atau apakah waktu yang dialokasikan untuk kegiatan tertentu (seperti waktu belajar anak atau waktu keluarga bersama) sudah sesuai dengan rencana.

- c. Perbandingan dengan Standar

Setelah pengukuran dilakukan, hasil kinerja keluarga dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan, misalnya

pengeluaran melebihi anggaran atau waktu yang dihabiskan untuk suatu kegiatan tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu dilakukan evaluasi.

d. Tindakan Korektif

Pada tahap ini, jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, maka keluarga perlu melakukan tindakan korektif. Misalnya, jika pengeluaran melebihi anggaran, keluarga dapat memutuskan untuk mengurangi pengeluaran pada bulan berikutnya atau mencari sumber pendapatan tambahan. Tindakan korektif ini sangat penting untuk menjaga agar keluarga tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya.

e. Evaluasi dan Umpan Balik

Setelah tindakan korektif diambil, keluarga harus mengevaluasi hasilnya dan memberikan umpan balik untuk memastikan apakah langkah-langkah yang diambil sudah efektif atau perlu ada perbaikan lebih lanjut. Evaluasi yang baik akan membantu keluarga untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah berjalan dengan baik.

4. Pengembangan:

Tahap pengembangan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan diri. Investasi dalam pengembangan anggota keluarga berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang. Adapun Proses Manajemen Sumber Daya Keluarga pada Tahap Pengembangan (Fitriana, 2017) sebagai berikut;

a. Identifikasi Kebutuhan dan Potensi:

Dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kebutuhan keluarga dalam bidang pendidikan, keterampilan, dan Kesehatan, dan mengidentifikasi potensi anggota keluarga yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

b. Perencanaan Pengembangan:

Menyusun rencana pengembangan yang mencakup tujuan, strategi, dan sumber daya yang dibutuhkan, dan menetapkan prioritas pengembangan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga.

c. Implementasi Program Pengembangan:

Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan mendorong partisipasi aktif anggota keluarga dalam kegiatan pengembangan.

d. Evaluasi dan Penyesuaian:

Melakukan evaluasi terhadap hasil program pengembangan untuk menilai efektivitasnya, dan Menyesuaikan program berdasarkan umpan balik dan perubahan kebutuhan keluarga.

H. Sifat Manajemen Sumber Daya Keluarga

Manajemen sumber daya keluarga merujuk pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh keluarga untuk mengalokasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan keluarga. Sumber daya keluarga meliputi waktu, uang, tenaga, keterampilan, pengetahuan, dan dukungan sosial yang dimiliki keluarga. Secara umum, ada beberapa sifat utama dalam manajemen sumber daya keluarga (Elizabeth B. Goldsmith, Jean R. Yarbrough, 2021), yaitu;

1. Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Salah satu sifat penting dalam manajemen sumber daya keluarga adalah pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Setiap keluarga dihadapkan pada pilihan yang beragam mengenai cara terbaik untuk menggunakan sumber daya mereka. Ketepatan dalam mengambil keputusan tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada kesejahteraan seluruh keluarga. Contoh konkret adalah bagaimana keluarga memutuskan antara menginvestasikan uang untuk pendidikan anak atau membeli tanah sebagai investasi jangka Panjang, atau memilih antara melakukan pengobatan di fasilitas Kesehatan atau memilih berobat ke pengobatan alternatif.

2. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen sumber daya keluarga. Keluarga yang berhasil dalam pengelolaan sumber daya, mereka adalah keluarga yang sering kali memiliki perencanaan yang baik untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, perencanaan anggaran bulanan untuk pengeluaran keluarga, serta perencanaan untuk tabungan pensiun atau pendidikan anak.

3. Pengalokasian Sumber Daya (Resource Allocation)

Pengalokasian sumber daya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen sumber daya keluarga. Ini mengacu pada bagaimana keluarga memutuskan untuk membagi sumber daya yang tersedia, seperti uang, waktu, atau tenaga, untuk berbagai keperluan. Misalnya, seorang ibu yang membagi waktunya antara pekerjaan dan perawatan anak-anak. Pengalokasian yang efektif memungkinkan keluarga untuk memaksimalkan hasil dari sumber daya yang terbatas. Pengalokasian ini erat kaitannya dengan kemampuan keluarga dalam memprioritaskan atau memilih masalah mana yang paling penting diselesaikan terlebih dahulu.

4. Koordinasi (Coordination)

Koordinasi antar anggota keluarga sangat penting dalam manajemen sumber daya. Setiap anggota keluarga memiliki peran yang berbeda dalam

pengelolaan sumber daya, dan koordinasi antar anggota tersebut sangat diperlukan agar tujuan keluarga tercapai secara harmonis. Koordinasi artinya membangun komunikasi dua arah, dimana seluruh anggota keluarga saling terbuka dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga semua kendala dapat diatasi dengan baik

Contoh, koordinasi antara suami dan istri dalam mengelola pekerjaan rumah dan keuangan keluarga.

5. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Efisien (Efficiency)

Sifat manajemen sumber daya keluarga juga mencakup efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya yang ada secara maksimal dengan pemborosan yang minimal. Keluarga yang mengelola sumber daya secara efisien dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Contohnya adalah perencanaan belanja yang cermat agar tidak ada pemborosan dalam membeli barang-barang yang tidak diperlukan.

6. Fleksibilitas (Flexibility)

Sumber daya keluarga tidak selalu tetap, sangat dinamis dan fleksibel, dan bisa berubah tergantung pada berbagai situasi. Oleh karena itu, keluarga perlu memiliki fleksibilitas dalam mengelola sumber daya. Misalnya, jika seseorang kehilangan pekerjaan, keluarga perlu beradaptasi dengan berbagai konsekuensi (kehilangan pendapatan) sehingga keluarga perlu memikirkan perubahan anggaran dan kebutuhan, dengan cara mengurangi jumlah pengeluaran.

7. Pengelolaan Krisis (Crisis Management)

Manajemen sumber daya keluarga juga mencakup kemampuan untuk mengelola krisis. Dalam siklus kehidupan, situasi apapun sangat mungkin terjadi, ketika keluarga dihadapkan pada situasi darurat atau tak terduga, seperti kecelakaan atau masalah kesehatan, keluarga perlu mengatur ulang prioritas dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah tersebut. Contoh, ketika ayah diberhentikan dalam pekerjaannya, secara otomatis pendapatanpun akan berkurang, sementara ada banyak pengeluaran yang harus dibayarkan (biaya sekolah, biaya Listrik, biaya perawatan mobil dll). Dalam situasi ini pengelolaan sumber daya keluarga harus mampu mengelola situasi krisis dengan memilih masalah yang lebih urgen, misal biaya Listrik atau sekolah)

I. Latihan Soal

SOAL MULTIPLE CHOIS

1. Sebuah keluarga dengan penghasilan bulanan yang terbatas berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menyusun anggaran yang ketat. Apakah strategi yang diterapkan oleh keluarga?
 - A. Pemanfaatan sumber daya alam
 - B. Manajemen keuangan keluarga
 - C. Pengabaian kebutuhan sekunder
 - D. Penundaan semua pengeluaran
 - E. Penghapusan kebutuhan primer
2. Dalam sebuah keluarga, terdapat berbagai jenis sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apakah sumber daya non-materi yang dimiliki oleh keluarga?
 - A. Uang tabungan di bank
 - B. Rumah yang dimiliki
 - C. Keahlian memasak ibu
 - D. Investasi properti
 - E. Kendaraan pribadi
3. Keluarga Pak Andi memiliki pendapatan bulanan yang tetap. Istri Pak Andi bekerja sebagai ibu rumah tangga yang mengelola keuangan dan kebutuhan rumah tangga. Mereka juga memiliki kendaraan, rumah sendiri, serta jaringan sosial yang luas. Apakah sumber daya keluarga yang dimiliki Pak Andi?
 - A. Sumber daya finansial dan fisik
 - B. Sumber daya finansial, fisik, manusia, dan sosial
 - C. Hanya sumber daya manusia dan sosial
 - D. Hanya sumber daya alam dan manusia
 - E. Hanya sumber daya material dan finansial
4. Keluarga Pak Budi selalu mencatat pengeluaran mereka setiap bulan dan menetapkan anggaran untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan tabungan. Apakah strategi yang dilakukan keluarga Pak Budi?
 - A. Pemborosan sumber daya keluarga
 - B. Manajemen keuangan yang tidak efektif
 - C. Penggunaan sumber daya yang efisien

- D. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien
 - E. Pengabaian terhadap sumber daya keluarga
5. Keluarga Ibu Sari ingin mengetahui apakah mereka memiliki cukup dana untuk membeli rumah dalam 5 tahun ke depan. Mereka melakukan pencatatan aset, penghasilan, dan pengeluaran bulanan untuk mengevaluasi kondisi keuangan mereka.
- Apakah aspek yang sedang dinilai oleh keluarga inu sari?
- A. Sosial
 - B. Material
 - C. Finansial
 - D. Alam
 - E. Manusia
6. Keluarga Pak Hasan memiliki banyak anggota dengan berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka membuat perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dalam pemakaian pendapatan, waktu, serta tenaga.
- Apakah proses yang dilakukan oleh keluarga Pak Hasan?
- A. Konsumsi sumber daya keluarga
 - B. Manajemen sumber daya keluarga
 - C. Pengeluaran sumber daya keluarga
 - D. Pembuangan sumber daya keluarga
 - E. Pengurangan sumber daya keluarga
7. Ibu Lestari selalu menetapkan tujuan pengelolaan keuangan keluarga dengan membuat anggaran dan strategi pengeluaran. Selain itu, ia juga mengevaluasi efektivitas anggaran setiap akhir bulan.
- Apakah tahap proses manajemen sumber daya keluarga yang dilakukan Ibu Lestari?
- A. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
 - B. Penggunaan, pencatatan, dan evaluasi
 - C. Pengeluaran, pemasukan, dan penghematan
 - D. Perencanaan, penyimpanan, dan pelaporan
 - E. Pembelian, konsumsi, dan evaluasi
8. Keluarga Pak Dani selalu menyesuaikan penggunaan sumber daya berdasarkan kebutuhan yang berubah-ubah, seperti biaya sekolah anak yang meningkat.
- Apakah sifat manajemen sumber daya keluarga berdasarkan kasus di atas?

- A. Statis
 - B. Fleksibel
 - C. Kaku
 - D. Terbatas
 - E. Tidak terencana
9. Ibu Anita memiliki anggaran bulanan yang terbatas. Agar dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga, ia membandingkan harga barang di berbagai toko dan memanfaatkan diskon saat berbelanja.
Apakah prinsip yang diterapkan Ibu Ani?
- A. Efisiensi
 - B. Pemborosan
 - C. Kemewahan
 - D. Konsumtif
 - E. Ketergantungan
10. Pak Rudi dan istrinya berusaha mengelola pendapatan mereka dengan baik agar dapat membiayai pendidikan anak-anak hingga jenjang tertinggi dan memiliki tabungan untuk masa depan.
Apakah tujuan utama dari manajemen sumber daya keluarga yang diterapkan Pak Rudi?
- A. Meningkatkan kemewahan hidup
 - B. Menghindari penggunaan sumber daya
 - C. Mencapai kesejahteraan keluarga
 - D. Memperbanyak hutang untuk memenuhi kebutuhan
 - E. Mengabaikan anggaran rumah tangga

Soal Esay

1. Jelaskan pengertian manajemen sumber daya keluarga dan mengapa hal tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari?
2. Sebutkan dan jelaskan tahapan dalam proses manajemen sumber daya keluarga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
3. Bagaimana cara mengukur efektivitas pemanfaatan sumber daya keluarga, dan berikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari!
4. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat manajemen sumber daya keluarga serta bagaimana sifat tersebut mempengaruhi pengelolaan keuangan keluarga?

5. Sebuah keluarga memiliki sumber daya terbatas, tetapi tetap ingin memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan anak-anaknya. Strategi apa yang dapat mereka lakukan untuk mengelola sumber daya dengan baik? Berikan penjelasan!

Kunci Jawaban

1. B
2. C
3. B
4. C
5. C
6. B
7. A
8. B
9. A
10. C

J. Rangkuman Materi

Manajemen sumber daya keluarga merupakan aspek krusial dalam keperawatan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga melalui pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. **Konsep dasar sumber daya keluarga** mencakup segala potensi yang dimiliki keluarga untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Sumber daya ini tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup keterampilan, waktu, jaringan sosial, serta akses terhadap layanan kesehatan.

Klasifikasi sumber daya keluarga meliputi sumber daya manusia (pengetahuan, keterampilan, tenaga), sumber daya fisik (pendapatan, rumah, fasilitas kesehatan), sumber daya sosial (dukungan keluarga dan komunitas), serta sumber daya psikologis (motivasi, kepercayaan diri, dan nilai-nilai keluarga). Pemahaman mengenai klasifikasi ini penting dalam merancang intervensi keperawatan keluarga yang tepat sasaran.

Dalam **penggunaan sumber daya keluarga**, prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi kunci utama. Penggunaan yang optimal melibatkan perencanaan yang matang, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa sumber daya dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan tujuan keluarga. Keperawatan keluarga berperan dalam membimbing keluarga dalam membuat keputusan yang bijak terkait alokasi sumber daya, terutama dalam situasi keterbatasan.

Untuk memastikan optimalisasi sumber daya, diperlukan **cara mengukur sumber daya keluarga**, yang dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif (seperti analisis pendapatan dan pengeluaran) maupun kualitatif (seperti kepuasan keluarga terhadap akses layanan kesehatan). Alat ukur ini membantu perawat keluarga dalam menilai kondisi aktual dan merancang strategi intervensi yang lebih akurat.

Manajemen sumber daya keluarga dapat diartikan sebagai proses sistematis dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi penggunaan sumber daya guna mencapai kesejahteraan keluarga. Dalam konteks keperawatan keluarga, manajemen ini membantu keluarga dalam mengembangkan strategi adaptasi terhadap berbagai tantangan kesehatan dan sosial. Berbagai **faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya keluarga** meliputi faktor internal (pendidikan, jumlah anggota keluarga, budaya, dan nilai-nilai keluarga) serta faktor eksternal (lingkungan sosial, kebijakan kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan). Pemahaman terhadap faktor-faktor ini memungkinkan intervensi yang lebih personal dan efektif dalam praktik keperawatan keluarga.

Proses manajemen sumber daya keluarga terdiri dari identifikasi kebutuhan, perencanaan strategi pemanfaatan sumber daya, implementasi, serta evaluasi hasil. Dalam konteks keperawatan keluarga, perawat berperan sebagai fasilitator dalam membantu keluarga menjalankan proses ini dengan pendekatan yang berbasis bukti dan mempertimbangkan aspek sosial serta budaya keluarga.

Adapun **sifat manajemen sumber daya keluarga** bersifat dinamis, adaptif, dan multidimensional, mencerminkan kompleksitas kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga. Oleh karena itu, pendekatan dalam keperawatan keluarga harus fleksibel, berbasis partisipasi aktif anggota keluarga, serta mempertimbangkan perubahan lingkungan sosial dan ekonomi.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip manajemen sumber daya keluarga, diharapkan keluarga mampu meningkatkan kapasitasnya dalam mengatasi masalah kesehatan, mengelola sumber daya secara lebih efektif, serta mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam konteks keperawatan keluarga, peran perawat menjadi kunci dalam memberikan edukasi, bimbingan, dan dukungan untuk memperkuat kapasitas keluarga dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki.

K. Glosarium

Afektif	: Sikap
Coordination	: proses mengorganisir dan mengatur berbagai aktivitas atau bagian dari suatu sistem agar berjalan dengan efisien dan harmonis untuk mencapai tujuan yang sama.
Crisis Management	: proses yang digunakan oleh individu, tim, atau organisasi untuk mengidentifikasi, merespons, dan mengatasi krisis atau situasi darurat yang dapat mengancam kelangsungan operasi, reputasi, atau keselamatan
Decision Making	: Pengambilan Keputusan
Efektif	: Berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, tanpa memperhitungkan sumber daya yang digunakan.
Efisien	: Mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, tanpa pemborosan.
Flexibility	: kemampuan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan situasi, kondisi, atau tuntutan baru dengan mudah.
Home Economics	: Sumber daya ekonomi
Interpersonal	: Berkaitan dengan hubungan antara dua orang atau lebih., dan mengacu pada interaksi sosial dan komunikasi antarindividu.
Kognitif	: Pengetahuan
MSDK	: Manajemen Sumber Daya Keluarga
Planning	: Perencanaan
Psikomotor	: Ketrampilan
Personal	: Berkaitan dengan individu atau diri sendiri, atau mengacu pada sesuatu yang bersifat pribadi atau internal.
Resource Allocation	: Pengalokasian Sumber Daya
Resource Allocation	: Pengalokasian Sumber Daya
Resource Allocation	: Pengalokasian Sumber Daya
SDM	: Sumber Daya Manusia

L. Daftar Pustaka

- EL Mujtaba (2022) Menabung Harian: Investasi Sederhana untuk Masa Depan Elementa Media. bintangpusnas.perpusnas.go.id
- Elizabeth B. Goldsmith, Jean R. Yarbrough (2021) *Family Resource Management* McGraw-Hill Education; New York
- Eriawaty, dkk (2024) Pendidikan ekonomi keluarga pengrajin getah nyatu. Deepublish; Yogyakarta
- Fitriana, F., Faudiah, N., Dewi, R., & Hamid, Y. H. (2017). *Pengelolaan Sumber Daya Keluarga*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Guharja, S. (1993). *Manajemen Sumber Daya Keluarga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasan H (2020) onsep Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Kualitas Keluarga. STIT Pematang. Pematang.
- Hasanah, U., & Martiastuti, K. (2020). Ekologi Keluarga: Sinergisme Keluarga dan Lingkungan. KARIMA; Jakarta
- Juniarti, N. &. (2015). Manajemen Sumber Daya Keluarga. Jakarta: Publisher.
- Siregar, D. M. (2020). Keperawatan Keluarga. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Smith J.R and Taylor M.T (2023). Social and Economic Aspects of Family Resources Oxford University Press; Oxford
- Suwatno & Arviana N, (2023) Komunikasi Interpersonal; Panduan Membangun Keterampilan. Bumi Aksara; Bandung
- Suwatno dan Nerissa Arviana (2023) Komunikasi Interpersonal: Panduan Membangun Keterampilan Relasional Kontemporer. Bumi Aksara; Jakarta

BAB 6

PENGKAJIAN KEPERAWATAN KELUARGA

Tujuan Intruksional Umum :

Mahasiswa mampu menjelaskan, memahami dan menerapkan pengkajian keperawatan keluarga yang komprehensif.

Tujuan Intruksional Khusus :

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses pengkajian keperawatan keluarga
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang instrument pengkajian kesehatan keluarga
- c. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian keluarga secara komprehensif

Capaian Pembelajaran:

Kognitif

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang proses pengkajian keperawatan keluarga
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang instrument pengkajian kesehatan keluarga berdasarkan evidence based practice

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu melakukan wawancara pada pengkajian keperawatan keluarga yang komprehensif pada keluarga

Afektif:

1. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi dengan jelas dan efektif dalam proses wawancara untuk mengkaji keluarga
2. Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati dan etika professional dalam berinteraksi dengan keluarga dan anggota keluarga, serta dalam tim perawatan kesehatan

Pendahuluan

Perawat memiliki peran penting dan signifikan dalam proses pengkajian keperawatan yang merupakan bagian pertama dari proses asuhan keperawatan keluarga. Keperawatan keluarga merupakan bagian terkecil dari keperawatan di komunitas. Panduan pengkajian diperlukan untuk mendapatkan informasi-informasi

yang berhubungan dengan keadaan keluarga yang selanjutnya akan membantu perawat untuk bekerja dengan keluarga.

Bab ini akan membahas tentang proses pengkajian keperawatan keluarga. Pengkajian anggota keluarga meliputi pengkajian karakteristik keluarga termasuk struktur, proses, dan lingkungan keluarga (tempat tinggal, tetangga, komunitas). Tidak semua bagian pengkajian kesehatan keluarga sesuai untuk setiap keluarga, oleh karena itu perawat harus melakukan modifikasi konten panduan pengkajian dan melakukan adaptasi jika diperlukan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu dalam keluarga. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu melakukan pengkajian keperawatan keluarga. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi sarjana keperawatan.

Gambaran pembahasan dalam bab ini meliputi pengkajian keluarga yang terdiri dari data social budaya, data lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga, tugas keluarga dan stres dan strategi coping keluarga. Pengkajian individu dalam keluarga meliputi pengkajian mental, fisik, emosi, social dan spiritual. Struktur bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab dan latihan studi kasus.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini terdiri dari proses pengkajian keperawatan keluarga dan instrument pengkajian kesehatan keluarga.

A. Pengkajian Keperawatan Keluarga

Pengkajian kesehatan keluarga adalah bagian dari proses pengumpulan dan pengorganisasian data yang tersistem. Perawat melakukan pengkajian ini untuk menentukan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah keluarga dan area/wilayah yang membutuhkan perhatian. Perawat mengumpulkan informasi melalui tehnik wawancara dengan semua anggota keluarga dan melakukan observasi lingkungan sekitar tempat tinggal keluarga serta dengan mengumpulkan data komunitas. Perawat juga dapat menggunakan alat bantu genogram dan ecomap sebagai bagian dari pengkajian keperawatan keluarga. – buku kuning

Melakukan wawancara pada keluarga merupakan bagian terpenting dalam proses mengumpulkan data. Selama proses wawancara, anggota keluarga dapat menyampaikan dan mendiskusikan tentang semua informasi mengenai hal-hal yang bersifat pribadi bagi keluarga, seperti dimana anggota keluarga bekerja ataupun bersekolah, status kesehatan masing-masing anggota keluarga baik kesehatan secara fisik maupun mental.

Pengkajian anggota keluarga meliputi pengkajian data social budaya, data lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga, tugas keluarga dan stres dan strategi koping keluarga. Perawat sebaiknya mengumpulkan informasi terkait pengkajian melalui beberapa pertemuan dengan keluarga dan anggota keluarga lain serta pasangan dalam keluarga. Pengkajian keluarga juga memasukkan penggalan informasi dari komunitas, tetangga dan perumahan tempat keluarga tinggal. Pertemuan dengan keluarga diperlukan beberapa kali agar dapat melengkapi pengkajian kesehatan keluarga (Sahar, Setiawan, & Riasmini, 2019)

B. Sumber Data Pengkajian Keluarga

Proses pengumpulan data keluarga berasal dari berbagai sumber antara lain (M. M. Friedman, Bowden, & Jones, 2010):

1. Wawancara klien tentang peristiwa masa lalu dan saat ini
 - a. Mengajukan pertanyaan dan mendengarkan
 - b. Genogram
 - c. Ecomap
2. Data objektif
 - a. Melakukan observasi kondisi rumah

- b. Melakukan observasi interaksi keluarga
3. Data subjektif
 - a. Keluhan lisan keluarga tentang pengalaman anggota keluarga
 - b. Keluhan lisan pengamatan orang yang berarti di keluarga
 - c. Instrumen pengkajian yang diisi oleh anggota keluarga
4. Informasi tertulis dan wawancara dari fasilitas kesehatan
5. Laporan dari tim kesehatan / non kesehatan yang menangani keluarga
6. Laporan dari anggota tim kesehatan lain

Wawancara merupakan pertemuan tatap muka dengan satu anggota keluarga atau lebih. Jika memungkinkan, wawancara dengan seluruh anggota keluarga selama proses pengkajian awal sangat diperlukan dan tidak boleh ditunda sampai menjelang akhir pengkajian. Wawancara ini akan memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk berbagi persepsi dan memberikan kesempatan bagi perawat untuk melihat interaksi antar anggota keluarga. (Holman, 1983). Wawancara akan lebih baik untuk terfokus tetapi tetap harus bervariasi dalam tingkat strukturnya.

C. Alat Pengkajian Keluarga

Pada sub bab ini akan dikemukakan beberapa alat pengkajian keluarga terstruktur yang paling sering dipakai. Terdapat lebih dari 100 instrumen pengkajian yang sudah dikembangkan untuk tujuan klinik dan penelitian.

Tabel 6.1 Alat Pengkajian Keluarga (M. M. Friedman et al., 2010)

Alat	Teori atau Model Pendukung	Konsep yang Diukur	Penggunaan & Penilaian	Keuntungan	Keterbatasan
FACES III/ FACES IV Family Adaptati on and Cohesion Scale (Olson et,al., 1982; Olson, 1994)	Model Sirkumpleks	1. Kohesi 2. Kemampu an berdaptas i / fleksibilita s 3. Komunika si	1. 20 item dalam skala 4 2. Skala tipe- Likert 3. Mudah digunakan	1. Mengukur factor yang relevan dengan keperawatan 2. Mengukur persepsi nyata dan ideal dari keluarga	1. Anggota keluarga mungkin tidak bersedia untuk mengkaji diri mereka sendiri 2. Mengasums ikan bahwa keluarga mempunyai anak

FAD McMaster Family Assessment Device (Epstein, Baldwin, & Bishop, 1983)	Model Fungsi Keluarga McMaster	1. Penyelesaian masalah 2. Komunikasi 3. Peran 4. Ketangguhan afektif 5. Kontrol perilaku 6. Keterlibatan afektif 7. Fungsi umum	1. 60 item 2. Skala Likert 3. Mudah digunakan	1. Mengukur area yang dapat diubah perawat melalui rencana perawatan	1. Memerlukan anggota keluarga berbicara atas nama keluarga 2. Tidak jelas apakah bermanfaat bagi klien dengan perbedaan latar belakang social dan budaya, atau dalam tiap tahap kehidupan yang berbeda
Family APGAR Family Adaptability, Partners hip, Growth, Affection, and Resolve Test (Smilkstein, 1978)	Struktur, fungsi, dan dukungan sodial keluarga	1. Kemampuan beradaptasi 2. Kemitraan 3. Pertumbuhan 4. Afeksi 5. Penyelesaian	1. 5 item 2. Cepat digunakan	1. Mengukur factor yang relevan 2. Dapat diselesaikan oleh orang dewasa dan anak usia 10 tahun dan lebih tua	1. Tidak untuk digunakan mengevaluasi masalah keluarga secara mendalam 2. Mempunyai fungsi skrining
Kepuasan Keluarga (Olson & Wilson, 1982)	Model Sirkumpleks	1. Kepuasan keluarga 2. Kohesi	1. 14 item skala Likert 2. Mudah digunakan 3. Memperoleh norma	1. Secara langsung mengukur kepuasan keluarga	1. Tidak ada yang teridentifikasi

FES Family Environment Scale (Fuhr, Moos, & Dishotsky, 1981; Moos & Moos, 1976, 1984)	Perspektif Interaksional	1. Hubungan 2. Pertumbuhan personal 3. Pemeliharaan sistem	1. 90 item benar / salah 2. Penilaian rumit 3. Nilai terstandar; dua kategori	1. Tersedia dalam bentuk ringkas 2. Bermanfaat untuk mengukur perubahan setelah intervensi 3. Mengukur kenyataan dan ideal	1. Alat yang berorientasi pada riset yang tidak mempunyai model klinik terkait, sehingga penggunaan di klinik tidak jelas
FFI Family Functioning Index (Pless & Satterwhite, 1975)	Fungsi Keluarga	1. Komunikasi 2. Kebersamaan 3. Pengambilan keputusan 4. Orientasi anak 5. Kepuasan pernikahan	1. 19 item 2. Skala Likert 3. Cepat digunakan 4. Penilaian rumit	1. Mengidentifikasi keluargabe resiko, membedakan antara keluarga berfungsi baik dan bermasalah	1. Tidak dapat digunakan untuk keluarga tanpa anak, atau tanpa anak yang sudah dewasa 2. Tidak peka untuk perubahan jangka pendek atau Panjang, sehingga tidak akan mengukur perubahan setelah intervensi keperawatan
FFFS Feetham Family Functioning	Pendekatan Sistem Ekologis	Tiga area utama hubungan keluarga :	1. Agak rumit penilaiannya	Perbedaan antara apa yang sebenarnya	1. Agak sukar untuk memahami

ng Survey (Roberts & Feetham, 1982)		1. Antara keluarga dan unit social yang lebih luas seperti sekolah dan tempat kerja 2. Antara keluarga dan subsiste m di dalam keluarga 3. Antara keluarga dan individu di dalam keluarga		dana pa yang seharusnya diukur 1. Mengidenti fikasi factor yang dapat menjadi fokus perawat 2. Bukti dari bias-kelas		2.Dikembangk an bersama keluarga yang memiliki anak cacat	
FILE Family Inventory of Life events and Changes (McCubb in, Patterso n, & Wilson, 1981)	Model Ganda ABCX	1. Penump ukan stressor atau peristiwa kehidupa n 1. 85 item 2. Dapat dinilai secara manual 3. Mengevalu asi peristiwa kehidupan dengan 9 subskala yang berbeda		1. Mengkaji stres di dalam suatu keluarga saat ini dan selama tahun- tahun terakhir 2. Memeriksa stressor multiple yang sedang dialami keluarga		1.Mungkin sukar untuk anggota keluarga mengingat peristiwa yang terjadi pada tahun terakhir	

IFF Inventory of Family Feelings (Lowman, 1980)	1. Struktur Afektif Keluarga 2. Pola persetujuan dan konflik hubungan dua arah dan aliansi	1. Perasaan positif / negative terhadap tiap anggota	1. 38 item 2. Jenis skala Likert dalam skala 3 3. Mudah dinilai	1. Memfokuskan pada dimensi tunggal dari hubungan interpersonal dan keluarga	1. Keterbatasan pemanfaatan klinik karena fokus yang sempit
SFIS Structural Family Interaction Scale (Perosa, Hansen & Perosa, 1981)	Teori Fungsi Keluarga Minuchin	1. Kebersatuan dan keterpisahan 2. Mengabaikan / terlalu protektif 3. Kaku / fleksibel 4. Konflik / menghindari 5. Penatalaksanaan pasien 6. Triangulasi koalisi orang tua-anak 7. Penyimpangan	1. 85 item dalam skala 4 skala setuju 2. Mudah digunakan	1. Bermanfaat untuk konseling dan pengkajian keluarga	1. Alat yang membutuhkan waktu penyelesaian yang lama dan rumit sehingga sukar digunakan di klinik

Sumber: Bowden, Dickey & Greenberg (1998); Tauliatas, permimutter, & Strauss (1990); Filsinger (1983); Jacob & Tennebaum (1998)

D. Model Pengkajian Keluarga Friedman

Model Pengkajian Keluarga menurut Friedman terdiri dari 6 (enam) kategori yaitu :

- Melakukan identifikasi data
- Melakukan identifikasi tahap dan riwayat perkembangan
- Data lingkungan
- Struktur Keluarga
- Fungsi Keluarga
- Stres, coping dan adaptasi keluarga

1. Mengidentifikasi Data

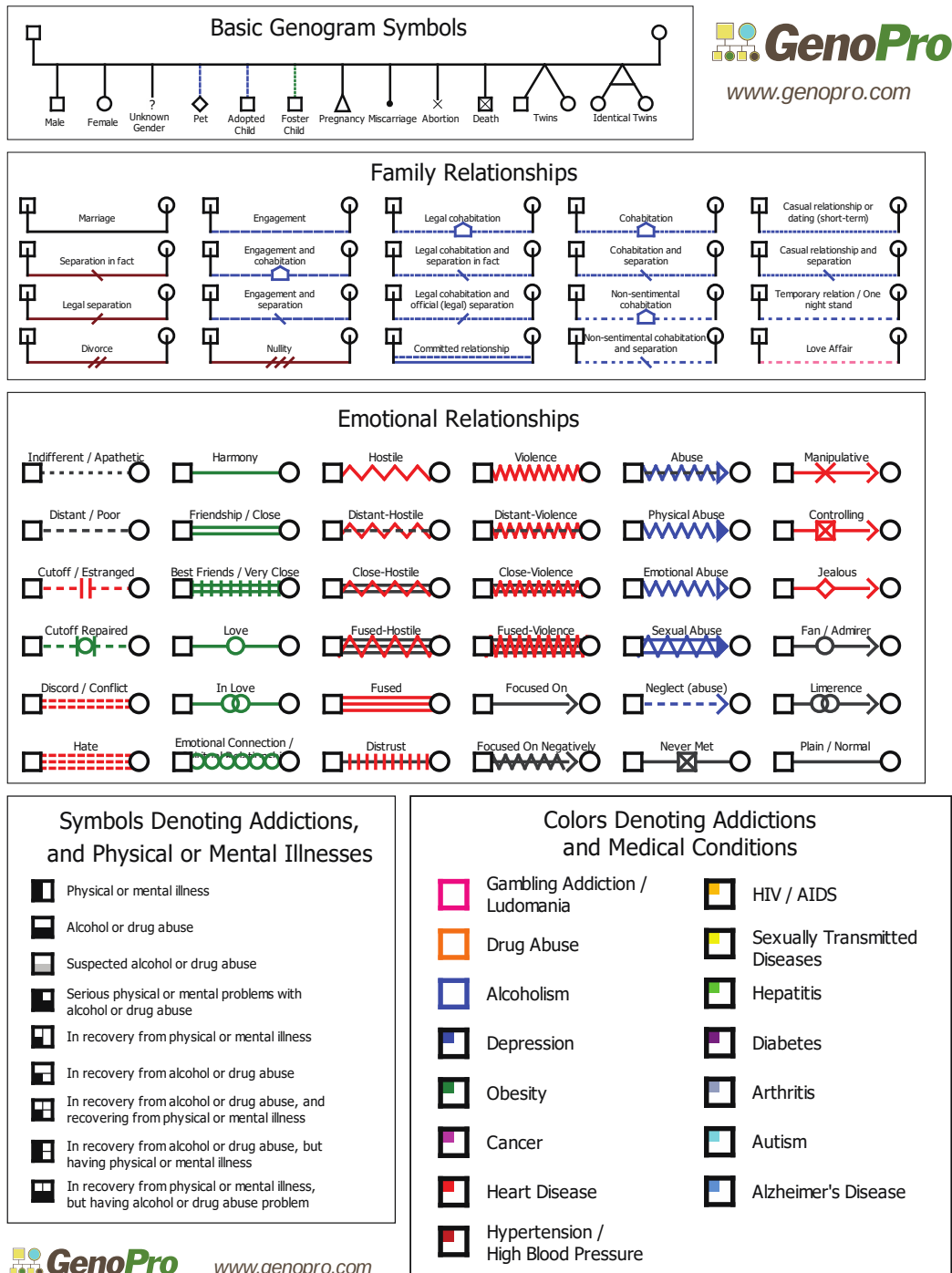
Data yang perlu dikumpulkan pada bagian ini antara lain:

- a. Nama Kepala Keluarga (disesuaikan dengan Kartu Keluarga)
- b. Alamat lengkap dan Nomer Telepon
- c. Komposisi Keluarga

Instrumen yang bisa dipergunakan adalah genogram, pohon silsilah kesehatan keluarga dan ecomap.

1) Genogram

Merupakan alat untuk membantu perawat membuat garis besar struktur keluarga dan untuk menggambarkan keluarga dalam bentuk bagan. Bagan ini melibatkan tiga generasi anggota keluarga dan dengan symbol yang menunjukkan silsilah keluarga. Anak digambarkan dari urutan kiri ke kanan dalam bagan yang dimulai dari anak yang paling tua. Genogram bisa Digambar menggunakan aplikasi bantuan genopro software dari website <https://genopro.com/>.



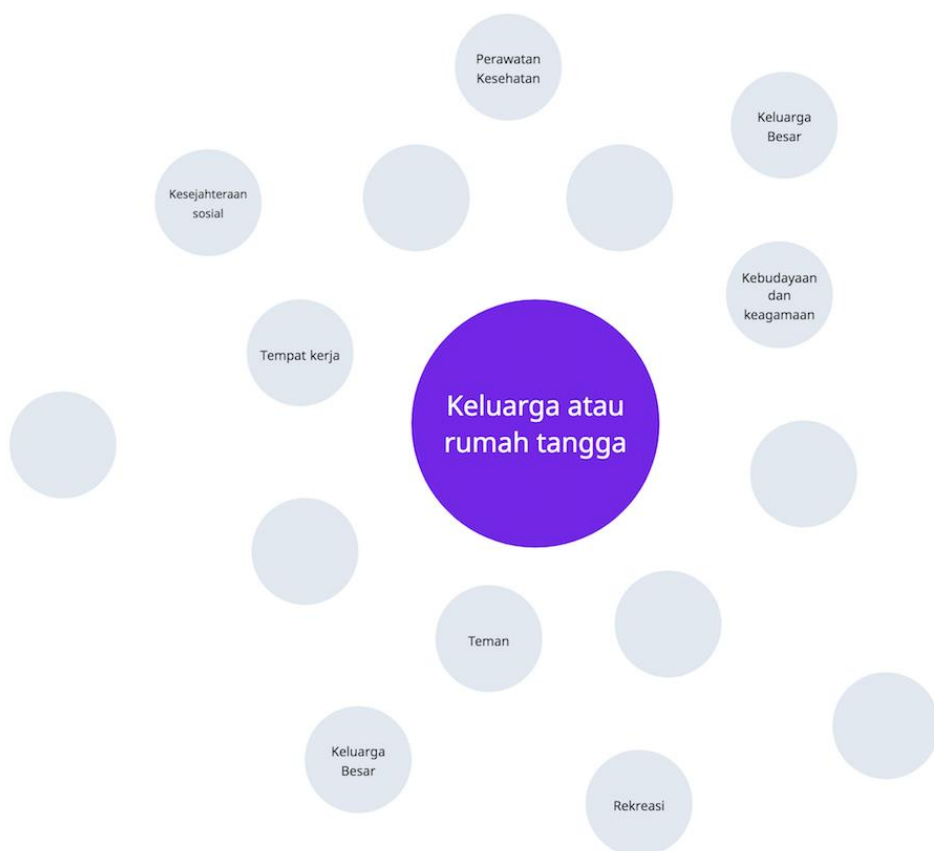
Gambar 6.1 Simbol genogram dari website <https://genopro.com/>.

2) Pohon silsilah keluarga

Merupakan alat pengkajian yang dapat memberikan mekanisme pencatatan dan mengetahui riwayat kesehatan keluarga. Pencatatan yang harus dilakukan antara lain:

- a) Penyebab kematian jika ada anggota keluarga yang telah meninggal.
- b) Penyakit keturunan, termasuk diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, kanker, asma, anemia serta penyakit kesehatan mental.

- c) Penyakit yang disebabkan akibat lingkungan dan pekerjaan
 - d) Masalah psikososial, seperti penyakit penyakit mental dan obesitas
 - e) Penyakit infeksi
 - f) Faktor risiko keluarga dari masalah kesehatan
 - g) Faktor risiko yang berhubungan dengan metode yang dipergunakan oleh keluarga dalam mencegah penyakit, seperti pemeriksaan kesehatan secara berkala, pap smear dan imunisasi.
 - h) Faktor risiko yang berhubungan dengan gaya hidup (pertanyaan yang diajukan berupa "penanganan stress" dan "menjaga kebugaran serta kesehatan tubuh")
- 3) Ecomap
- Merupakan alat klasik lain yang dipergunakan untuk menggambarkan hubungan keluarga ke suprasistem yang menggambarkan tinjauan tentang situasi keluarga, pentingnya pengasuhan atau hubungan konflik antara keluarga dan dunia. Ecomap dibuat pada pertemuan awal wawancara penggalan data dengan keluarga, orang-orang terkait dan institusi, yang berkaitan dengan keluarga yang sedang dikaji



Gambar 6.2 Ecomap yang bisa dibuat melalui website
<https://creately.com/id/usage/contoh-template-ecomap/>

d. Tipe Bentuk Keluarga (Kholifah & Widagdo, 2016)

1) Tipe keluarga tradisional

- a) The Nuclear Family (keluarga inti), yaitu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak, baik kandung maupun anak angkat.
- b) The Dyad Family (keluarga dyad), suatu rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri tanpa anak. Jika keluarga saat ini mungkin belum mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, jadi ketika nanti melakukan pengkajian data dan ditemukan perubahan maka perlu klarifikasi kembali.
- c) Single parent merupakan keluarga yang terdiri atas satu orang tua dengan anak (kandung atau angkat) dan hal tersebut dapat disebabkan oleh perceraian atau kematian
- d) Single adult merupakan suatu rumah tangga yang terdiri atas satu orang dewasa. Tipe ini bisa terjadi pada seorang dewasa yang tidak menikah atau tidak mempunyai suami.
- e) Extended Family merupakan keluarga yang terdiri atas keluarga inti ditambah keluarga lain, seperti paman, bibi, kakek, nenek dan sebagainya. Tipe keluarga ini banyak dianut oleh keluarga Indonesia terutama di daerah pedesaan.
- f) Middle-aged or elderly couple merupakan keluarga dimana orang tua yang tinggal sendiri di rumah (baik suami/ istri atau keduanya), karena anak-anaknya sudah membangun karir sendiri atau sudah menikah
- g) Kin-network family merupakan bentuk keluarga dimana beberapa keluarga yang tinggal bersama atau saling berdekatan dan menggunakan barang-barang pelayanan, seperti dapur dan kamar mandi yang sama.

2) Tipe keluarga non tradisional

Tipe keluarga yang tidak lazim / jarang di Indonesia.

- a) Unmarried parent and child family merupakan keluarga yang terdiri atas orang tua dan anak dari hubungan tanpa menikah.
- b) Cohabiting couple merupakan orang dewasa yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan karena beberapa alasan tertentu.
- c) Gay and lesbian family merupakan seorang yang mempunyai persamaan jenis kelamin tinggal dalam satu rumah sebagaimana pasangan suami istri.
- d) The nonmarital heterosexual cohabiting family merupakan keluarga yang hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan.

- e) Foster family merupakan keluarga yang menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga / saudara dalam waktu sementara, pada saat orang tua anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga yang aslinya.
- e. Latar belakang Kebudayaan (Etnik) (M. Friedman, 2010)
- Untuk menentukan kebudayaan dan orientasi keagamaan keluarga serta luasnya akulturasi menggunakan pendekatan berikut:
- 1) Mengidentifikasi pernyataan dari keluarga dan anggota keluarga tentang latar belakang budaya/etnis yang dianut.
 - 2) Bahasa yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari
 - 3) Negara atau daerah asal serta lama tinggal (jika keluarga bukan penduduk asli, maka generasi ke berapa yang pindah beserta alasan kepindahan)
 - 4) Jaringan pergaulan social keluarga dan apakah berasal dari kelompok suku yang sama.
 - 5) Tempat tinggal keluarga saat ini (apakah berada dalam lingkungan yang secara umum homogen untuk kebudayaan)
 - 6) Aktivitas keagamaan, social, kebudayaan, rekreasi, Pendidikan (aktivitas yang dilakukan apakah masih berada dalam kelompok budaya yang homogen)
 - 7) Kebiasaan dalam makan dan berpakaian (tradisional atau sudah dipengaruhi kebudayaan asing)
 - 8) Penataan rumah dan dekorasi (pengaruh budaya)
 - 9) Keberadaan peran dan struktur kekuasaan keluarga menganut yang tradisional atau modern
 - 10) Penggunaan praktik kesehatan keluarga tradisional misalnya ke dukun, tabib dan bukan ke tenaga kesehatan professional.
- f. Identifikasi Keagamaan
- 1) Agama yang dianut masing-masing anggota keluarga.
 - 2) Perbedaan dalam beragama dan praktik menjalankan kegiatan keagamaan.
 - 3) Keaktifan keluarga dan anggota keluarga dalam kegiatan di rumah ibadah sesuai dengan agama yang dianut.
 - 4) Praktik keagamaan yang diikuti oleh keluarga
 - 5) Nilai keagamaan yang menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari keluarga
- g. Status Kelas Sosial (berdasarkan pekerjaan, Pendidikan dan pendapatan)
- 1) Mengidentifikasi status kelas social.
 - 2) Status ekonomi.
 - 3) Pencari nafkah dalam keluarga.

- 4) Keluarga apakah menerima dana bantuan dan dijelaskan dari mana serta besarnya
- 5) Pendapat keluarga mengenai kecukupan pendapatan dan cara pengelolaan keuangan / pendapatan.

2. Mengidentifikasi Tahap Perkembangan dan Riwayat Keluarga

Tahap perkembangan dalam keluarga ada 8 (delapan) antara lain : (Kholifah & Widagdo, 2016), (Marilyn M. Friedman, Vicky R. Bowden, & Elaine G. Jones. PhD, 2010)

a. Tahap I: Keluarga baru menikah atau pemula atau pasangan baru

Tahap ini merupakan tahap dimana pasangan tanpa anak atau belum memiliki anak.

Tugas Perkembangan:

- 1) Membangun pernikahan yang saling memuaskan.
- 2) Membina hubungan persaudaraan, teman dan kelompok social
- 3) Perencanaan keluarga (keputusan tentang menjadi orang tua)

Perhatian pelayanan kesehatan:

- 1) Pendidikan dan konseling keluarga berencana
- 2) Pendidikan dan konseling menjadi orang tua

b. Tahap II: Childbearing Family

Tahap ini dimulai pada saat melahirkan anak pertama hingga anak tertua berusia 30 bulan.

Tugas perkembangan:

- 1) Membentuk keluarga muda sebagai suatu unit yang stabil (menggabungkan bayi yang baru ke dalam keluarga)
- 2) Memperbaiki hubungan setelah terjadinya konflik mengenai tugas perkembangan dan kebutuhan berbagai anggota keluarga.
- 3) Mempertahankan hubungan pernikahan yang memuaskan
- 4) Memperluas hubungan dengan keluarga besar dengan menambah peran menjadi orang tua dan menjadi kakek/nenek

Perhatian pelayanan kesehatan:

- 1) Persiapan untuk pengalaman melahirkan
- 2) Transisi menjadi orang tua
- 3) Perawatan bayi
- 4) Perawatan bayi yang sehat
- 5) Mengenali secara dini dan menangani masalah-masalah kesehatan fisik anak dengan tepat
- 6) Imunisasi
- 7) Pertumbuhan dan perkembangan yang normal

- 8) Tindakan untuk keamanan
 - 9) Keluarga berencana
 - 10) Interaksi keluarga
 - 11) Praktik kesehatan yang baik (misalkan tentang kebutuhan tidur dan istirahat, nutrisi dan olahraga)
- c. Tahap III: Keluarga dengan anak prasekolah
- Tahap ini dimulai pada saat anak tertua berusia 30 bulan hingga 5 sampai 6 tahun.
- Tugas perkembangan:
- 1) Memenuhi kebutuhan anggota keluarga akan rumah, ruang, privasi dan keamanan yang memadai
 - 2) Mensosialisasikan anak
 - 3) Mengintegrasikan anak kecil sebagai anggota keluarga baru sementara tetap memenuhi kebutuhan anak lain
 - 4) Mempertahankan hubungan yang sehat di dalam keluarga (hubungan pernikahan dan hubungan orang tua-anak) dan di luar keluarga (hubungan dengan keluarga besar dan komunitas)
- Perhatian pelayanan kesehatan:
- 1) Penyakit menular pada anak-anak
 - 2) Pencegahan kecelakaan dan keamanan rumah (misalnya terjatuh, luka bakar, keracunan, gigitan binatang)
 - 3) Hubungan pernikahan
 - 4) Hubungan sibling
 - 5) Keluarga berencana
 - 6) Kebutuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan
 - 7) Isu-isu tentang hal menjadi orang tua
 - 8) Penganiayaan dan pengabaian anak
 - 9) Praktik kesehatan yang baik (misalnya kebutuhan tidur dan istirahat, nutrisi dan olahraga)
- d. Tahap IV: Keluarga dengan anak usia sekolah
- Tahap ini dimulai saat anak tertua berusia 6 sampai 13 tahun
- Tugas perkembangan:
- 1) Mensosialisasikan anak-anak, termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan membantu hubungan anak-anak yang sehat dengan teman sebaya
 - 2) Mempertahankan hubungan pernikahan yang memuaskan
 - 3) Memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga

Perhatian pelayanan kesehatan:

- 1) Tantangan kesehatan pada anak (misalnya tentang penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara)
- 2) Kesehatan gigi
- 3) Penganiayaan dan pengabaian anak
- 4) Penyalahgunaan zat
- 5) Penyakit menular
- 6) Penyakit kronik
- 7) Masalah perilaku
- 8) Praktik kesehatan yang baik (misalnya kebutuhan tidur dan istirahat, nutrisi dan olahraga)

e. Tahap V: Keluarga dengan Anak Remaja

Tahap ini dimulai saat anak tertua berusia 13 tahun sampai 20 tahun.

Tugas perkembangan:

- 1) Menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab pada saat anak remaja telah dewasa dan semakin otonomi
- 2) Memfokuskan kembali hubungan pernikahan
- 3) Berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak

Perhatian pelayanan kesehatan:

- 1) Kecelakaan
- 2) Cedera akibat olahraga
- 3) Penyalahgunaan alkohol dan obat
- 4) Kontrasepsi
- 5) Kehamilan yang tidak diinginkan
- 6) Pendidikan seks
- 7) Hubungan pernikahan
- 8) Hubungan orang tua-remaja
- 9) Praktik kesehatan yang baik (misalnya kebutuhan tidur dan istirahat, nutrisi dan olahraga)

f. Tahap VI: Keluarga melepaskan anak dewasa muda

Tahap ini dimulai saat anak pertama pergi sampai anak terakhir meninggalkan rumah.

Tugas perkembangan:

- 1) Memperluas lingkaran keluarga terhadap anak dewasa muda, termasuk memasukkan anggota keluarga baru yang berasal dari pernikahan anak-anaknya
- 2) Melanjutkan untuk memperbarui dan menyesuaikan kembali hubungan pernikahan

3) Membantu orang tua suami dan istri yang sudah menua dan sakit

Perhatian pelayanan kesehatan:

- 1) Komunikasikan isu antara orang tua dan anak dewasa muda
- 2) Masalah transisi peran bagi suami dan istri
- 3) Kedaruratan masalah kesehatan kronik
- 4) Perencanaan keluarga bagi anak dewasa muda
- 5) Perhatian terhadap menopause
- 6) Efek yang berkaitan dengan meminum alkohol, merokok, dan praktik diet yang buruk yang telah berlangsung dalam jangka Panjang
- 7) Gaya hidup sehat

g. Tahap VII: keluarga orang tua paruh baya

Tahap ini dimulai saat semua anak meninggalkan rumah sampai masa pensiun.

Tugas perkembangan:

- 1) Menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan
- 2) Mempertahankan kepuasan dan hubungan yang bermakna antara orang tua yang telah menua dan anak mereka
- 3) Memperkuat hubungan pernikahan

Perhatian pelayanan kesehatan

- 1) Praktik kesehatan yang baik (misalnya kebutuhan tidur dan istirahat, nutrisi dan olahraga)
- 2) Hubungan pernikahan
- 3) Komunikasi dan hubungan dengan anak-anak, keluarga dari pasangannya, cucu dan orang tua yang telah menua
- 4) Perhatian pemberi asuhan
- 5) Penyesuaian terhadap perubahan fisiologis pada penuaan

h. Tahap VIII: keluarga dalam tahun terakhir

Tahap ini dimulai saat pensiun sampai kematian seorang atau kedua pasangan.

Tugas perkembangan:

- 1) Mempertahankan penataan kehidupan yang memuaskan
- 2) Menyesuaikan terhadap penghasilan yang berkurang
- 3) Mempertahankan hubungan pernikahan
- 4) Menyesuaikan terhadap kehilangan pasangan
- 5) Mempertahankan ikatan keluarga antargenerasi
- 6) Melanjutkan untuk merasionalisasi kehilangan keberadaan anggota keluarga (peninjauan dan integrasi kehidupan)

Perhatian pelayanan kesehatan:

- 1) Disabilitas fungsional meningkat
- 2) Gangguan mobilitas

- 3) Penyakit kronik
- 4) Kekuatan dan fungsi fisik menghilang
- 5) Layanan perawatan dalam jangka Panjang
- 6) Memberikan asuhan
- 7) Isolasi social
- 8) Berduka / depresi
- 9) Gangguan kognitif

3. Data Lingkungan (Marilyn M. Friedman et al., 2010)

Data lingkungan keluarga antara lain meliputi seluruh alam kehidupan keluarga mulai dari pertimbangan area terkecil seperti aspek dalam rumah tangga sampai komunitas yang lebih besar tempat keluarga tinggal.

a. Karakteristik Rumah

- 1) Menguraikan tipe tempat tinggal keluarga (rumah, apartemen, sewa, kos, dll).
- 2) Menguraikan kondisi rumah (interior dan eksterior). Interior meliputi jumlah ruangan, jenis ruangan (ruang tamu, dapur, ruang tidur, dll), pengaturan penggunaan ruangan di rumah, kecukupan perabot rumah, penerangan rumah, ventilasi, jenis lantai, ada tangga atau tidak (aman atau tidak), pagar rumah, dll.
- 3) Menguraikan suplai air untuk minum, sanitasi, memasak dan ketersediaan almari es di dapur.
- 4) Menguraikan sanitasi air, fasilitas di kamar mandi, sabun, handuk (sama atau berbeda).
- 5) Menguraikan pengaturan tempat tidur di rumah berdasarkan usia, hubungan dan kebutuhan khusus lainnya.
- 6) Menguraikan keadaan umum kebersihan dan sanitasi di rumah dan hewan peliharaan yang ada.
- 7) Menguraikan keadaan tembok dan lantai. Kondisi yang mengelupas mungkin akan mempengaruhi kesehatan terutama anak kecil.
- 8) Menguraikan kenyamanan setiap anggota keluarga dalam menggunakan sumber/fasilitas di lingkungan rumah.
- 9) Menguraikan pengaturan privacy yang dialami atau diinginkan oleh setiap anggota keluarga.
- 10) Menguraikan bahaya keamanan yang dialami di rumah.
- 11) Menguraikan ketersediaan pembuangan sampah.
- 12) Menguraikan perasaan setiap anggota keluarga tentang kepuasan terhadap pengaturan, penggunaan rumah.

b. Karakteristik lingkungan sekitar dan komunitas yang lebih besar

- 1) Menguraikan karakteristik lingkungan di sekitar rumah (desa, kota, subkota, dll), tipe tempat tinggal (perumahan, daerah kawasan industri, daerah persawahan, daerah perkantoran, dll), kondisi rumah dan jalan di sekitar rumah (terpelihara, rusak, sedang dalam perbaikan, belum beraspal), sanitasi jalan raya dan di rumah (kebersihan dan pengumpulan sampah, dll), kemacetan lalu lintas (jika ada), adanya industri skala kecil dan besar, adanya masalah polusi udara, air, suara dll.
- 2) Menguraikan karakteristik demografi dari lingkungan dan komunitas tentang etnik yang tinggal, pekerjaan dan hobi keluarga, kepadatan populasi di sekitar rumah.
- 3) Menguraikan pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar yang ada di sekitar rumah seperti fasilitas pemasaran (makanan, pakaian, apotek, dll), institusi kesehatan (klinik, rumah sakit dan fasilitas IGD), Lembaga pelayanan social (kesejahteraan, konseling, pekerjaan, dll), pelayanan tempat cuci otomatis untuk kebutuhan keluarga dan tempat beribadah sesuai keyakinan keluarga.
- 4) Menguraikan kemudahan akses sekolah di lingkungan dan komunitas dan kondisi sekolah.
- 5) Menguraian fasilitas rekreasi yang ada di sekitar rumah.
- 6) Menguraikan ketersediaan transportasi umum dan bagaimana keluarga dapat mengakses pelayanan dan fasilitas tersebut (jarak, kesesuaian, waktu tempuh)
- 7) Menguraikan tentang insiden kejahatan di lingkungan sekitar dan keseriusan kejadian kejahatan.

c. Mobilitas Geografis keluarga

- 1) Menguraikan lama keluarga tinggal di wilayah tersebut.
- 2) Menguraikan riwayat mobilitas geografis keluarga (jika pernah/ada)
- 3) Menguraikan tempat keluarga bermigrasi dan berpindah.

d. Asosiasi transaksi keluarga dengan komunitas

- 1) Menguraikan tentang siapa anggota keluarga yang menggunakan pelayanan komunitas atau Lembaga pelayanan yang terkenal di komunitas.
- 2) Menguraikan seberapa sering dan sejauh mana keluarga menggunakan pelayanan atau fasilitas.
- 3) Menguraikan tentang wilayah yang sering dikunjungi oleh keluarga.
- 4) Menguraikan tentang kebutuhan dan kesadaran keluarga tentang pelayanan komunitas yang relevan dengan kebutuhannya contohnya transportasi.

- 5) Menguraikan tentang perasaan keluarga tentang organisasi atau kelompok yang memberi bantuan kepada keluarga yang berkaitan dengan keluarga.
- 6) Menguraikan pendapat keluarga memandang komunitas.

4. Struktur Keluarga (Kholifah & Widagdo, 2016)

a. Struktur keluarga

Data yang perlu dikaji antara lain data struktur keluarga yaitu pola komunikasi, meliputi penggunaan komunikasi antar anggota keluarga, bagaimana anggota keluarga menjadi pendengar, jelas dalam menyampaikan pendapat dan perasaannya selama berkomunikasi dan berinteraksi.

b. Struktur kekuatan keluarga

Data berikutnya yang dikaji adalah struktur kekuatan keluarga, yang terdiri atas data siapa yang membuat keputusan dalam keluarga, seberapa penting keputusan yang diambil.

c. Struktur peran

Data meliputi data peran formal dan peran informal dalam keluarga yang meliputi peran dan posisi setiap anggota keluarga, tidak ada konflik dalam peran, bagaimana perasaan dalam menjalankan perannya, apakah peran dapat berlaku fleksibel.

d. Nilai-nilai keluarga

Data yang dikaji adalah nilai kebudayaan yang dianut keluarga, nilai inti keluarga seperti siapa yang berperan dalam mencari nafkah, kemajuan dan penguasaan lingkungan, orientasi masa depan, kegemaran keluarga, keluarga sebagai pelindung dan kesehatan bagi keluarga, apakah ada kesesuaian antara nilai-nilai keluarga dan nilai subsistem keluarga, bagaimana pentingnya nilai-nilai keluarga secara sadar atau tidak, apakah ada konflik, nilai yang menonjol dalam keluarga itu sendiri, bagaimana nilai-nilai mempengaruhi kesehatan keluarga.

5. Fungsi Keluarga (Kholifah & Widagdo, 2016) dan (M. M. Friedman et al., 2010)

Komponen data yang dikumpulkan pada fungsi keluarga antara lain:

a. Fungsi Afektif

Pada fungsi ini dilakukan pengkajian pada pola kebutuhan keluarga dan bagaimana responnya. Menguraikan tentang perasaan anggota keluarga mengenai kebutuhannya terhadap keluarga, saling memberikan perhatian, saling menyayangi dan saling memberikan dukungan positif antar anggota keluarganya.

b. Fungsi Sosialisasi

Pada fungsi ini data yang dikumpulkan adalah bagaimana cara keluarga mengajarkan kedisiplinan, cara pemberian reward/penghargaan atau hukuman jika salah bagi anggota keluarga, bagaimana keluarga melatih anggota keluarga dalam melatih otonomi dan ketergantungan, saling memberikan dan menerima rasa cinta kasih sayang sesama keluarga dan juga penanaman perilaku sesuai perkembangan usia.

c. Fungsi Ekonomi

Pada fungsi ini menguraikan tentang bagaimana keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi yang terdiri atas jenis pekerjaan, jumlah penghasilan keluarga, jumlah pengeluaran keluarga, cara pemenuhan semua kebutuhan anggota keluarga dan pengaturan keuangan dalam keluarga.

d. Fungsi Reproduksi

Pada fungsi menguraikan tentang berapa jumlah anak, rencana dalam program keluarga berencana, permasalahan dalam hal fungsi reproduksi.

e. Fungsi Perawatan Kesehatan

Pengkajian data pada fungsi perawatan kesehatan difokuskan pada tugas keluarga di bidang kesehatan. Tugas kesehatan keluarga menurut Friedman (1988) ada 5 (lima) antara lain:

1) Kemampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan keluarga.

Pada bagian ini data yang dikaji antara lain apakah keluarga mengetahui tentang masalah kesehatan yang sedang dialami oleh anggota keluarga, apakah keluarga sudah mengerti dan memahami pengetahuan tentang penyakit yang dialami keluarga yang meliputi definisi, tanda dan gejala, etiologi dan penatalaksanaan saat di rumah, bagaimana pendapat keluarga tentang penyakit yang dialami oleh anggota keluarga, dan bagaimana cara keluarga untuk menjaga kesehatan, mencegah dan menghindari penularan atau keparahan penyakit yang dialami oleh keluarga.

2) Kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan yang tepat.

Pada bagian ini data yang dikaji adalah bagaimana kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan apabila ada anggota keluarga yang sakit, apakah diberikan tindakan mandiri di rumah atau langsung dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Siapa anggota keluarga yang mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan apabila ada anggota keluarga yang sakit, bagaimana proses pengambilan keputusan dalam keluarga apabila ada anggota keluarga ada yang mengalami masalah kesehatan.

3) Kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan anggota keluarga yang sakit.

Pada bagian ini data yang dikaji adalah bagaimana keluarga mampu melakukan perawatan untuk anggota keluarganya yang mengalami masalah kesehatan. Apakah keluarga mengetahui dan memahami mengenai sumber-sumber makanan yang bergizi, diet yang sedang dijalani oleh anggota keluarga, anggota keluarga yang bertanggung jawab terhadap persiapan dan pengelolaan makanan untuk anggota keluarga baik yang sehat maupun sakit, takaran konsumsi makanan untuk anggota keluarga yang sakit dan respon keluarga terhadap jenis makanan dan jadwal makan yang sudah ditetapkan. Apakah jumlah waktu istirahat setiap anggota keluarga sudah sesuai dengan tahap perkembangannya, ketersediaan jadwal istirahat yang harus ditaati oleh setiap anggota keluarga, fasilitas untuk istirahat tidur setiap anggota keluarga. Menguraikan tentang pola olahraga yang dilakukan oleh keluarga, pendapat keluarga tentang kebiasaan olahraga, bagaimana latihan olahraga untuk anggota keluarga yang sakit. Mengkaji apakah ada anggota keluarga yang memiliki kebiasaan minum kopi, merokok dan minum alkohol, bagaimana kebiasaan minum obat untuk anggota keluarga yang sakit, apakah keluarga terbiasa membeli obat tanpa resep dokter, apakah penempatan obat=obatan sudah dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Mengkaji cara keluarga untuk meningkatkan kesehatannya, mencegah terjadinya sakit, mencegah terjadinya penularan sakit, cara keluarga dalam merawat anggota keluarganya yang sakit, dan identifikasi jika ada keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh keluarga yang berhubungan dengan perawatan kesehatan di rumah.

Contoh: ketika ada anggota keluarga yang sakit diabetes mellitus, apakah keluarga sudah menerapkan diet 3J (tepat jenis, tepat jumlah dan tepat jadwal), selalu mengingatkan untuk jadwal minum obat secara teratur, mengingatkan dan memfasilitasi untuk kontrol ke pelayanan kesehatan dan selalu mengingatkan untuk selalu melakukan olahraga dan pola hidup sehat.

4) Kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan yang sehat.

Pada bagian ini dikaji bagaimana keluarga mengatur, memelihara lingkungan baik fisik maupun psikologis bagi semua anggota keluarganya. Dalam hal ini lingkungan fisik termasuk pengaturan ruangan dan perabot rumah, menjaga kebersihan, pengelolaan sampah, pengaturan ventilasi, pengaturan pencahayaan rumah. Sedangkan lingkungan psikologis meliputi bagaimana cara keluarga untuk menjaga keharmonisan antara anggota

keluarga dan mengatur serta memenuhi privasi masing-masing anggota keluarga.

5) Kemampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada bagian ini dikaji apakah keluarga sudah memanfaatkan fasilitas pelayanan yang mudah dijangkau dari tempat tinggal, seperti posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik dan rumah sakit. Menguraikan sumber pembiayaan kesehatan yang dipergunakan oleh keluarga, bagaimana pembayaran keluarga terhadap fasilitas kesehatan yang diterima apakah menggunakan asuransi pemerintah atau swasta atau dana tabungan, apakah keluarga memperoleh bantuan kesehatan gratis. Bagaimana keluarga memfasilitasi transportasi untuk mencapai pelayanan kesehatan dan adakah transportasi umum untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan serta permasalahan dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan.

6. Stres, Koping dan Adaptasi Keluarga

Pada bagian ini mengkaji tentang stressor baik jangka Panjang maupun pendek yang pernah dialami oleh keluarga bisa merujuk pada kuesioner FEEL Family Inventory of Live events and Changes Scale yang diadaptasi dari Hamilton tahun 1983. Dikaji juga bagaimana keluarga dalam penanganan stres dan sumber apa saja untuk mengatasi stressor tersebut.

Dalam pengkajian koping diuraikan reaksi keluarga saat mengalami stres, apakah mengandalkan keluarga sendiri atau meminta bantuan kelompok, bagaimana dampak dari stressor pada fungsi keluarga.

E. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

1. Pada saat kita melakukan pengkajian tentang tugas keluarga, pengkajian tersebut berada di dalam komponen pengkajian?
 - A. Sumber data keluarga
 - B. Tahap dan tugas perkembangan keluarga
 - C. Struktur keluarga
 - D. Fungsi keluarga
 - E. Stres, koping dan adaptasi keluarga
2. Seorang perawat melaksanakan perawatan pada keluarga yang beranggotakan ayah berusia 38 tahun, ibu berusia 35 tahun, dan mempunyai anak berusia 13 tahun dan 8 tahun. Ayah saat ini bekerja di luar kota dan seminggu sekali pulang

sedangkan ibu bekerja di pasar. Hal apakah yang harus dikaji berkenaan dengan tugas perkembangan keluarga tersebut?

- A. Bagaimana keluarga membina hubungan dan kepuasan bersama?
 - B. Bagaimana keluarga membagi peran dan tanggung jawab?
 - C. Bagaimana keluarga melakukan adaptasi pola hubungan seksual?
 - D. Bagaimana keluarga menetapkan tujuan keluarga?
 - E. Bagaimana keluarga berperan sebagai bagian dari kelompok social?
3. Pada saat tahap pengkajian perawat menanyakan kepada keluarga mengenai bagaimana masalah dirasakan keluarga, keluarga menyerah atau tidak terhadap masalah kesehatan yang dihadapi saat ini dan pengetahuan keluarga mengenai sakit yang dialami oleh keluarga, maka dalam hal ini kita mengkaji tentang tugas keluarga?
- A. Kemampuan keluarga mengenal masalah kesehatan keluarga
 - B. Kemampuan keluarga mengambil keputusan dalam keluarga
 - C. Kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit
 - D. Kemampuan keluarga melakukan modifikasi lingkungan
 - E. Kemampuan keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan
4. Pada saat pengkajian didapatkan hasil bahwa dalam suatu keluarga terdapat suami berusia 55 tahun, istri berusia 55 tahun dan mereka tidak mempunyai anak. Saat ini suami masih bekerja akan tetapi jabatannya tidak sama dengan saat bekerja dlu dikarenakan akan pensiun. Jika dalam pengkajian, maka keluarga tersebut masuk dalam tahap perkembangan keluarga mana?
- A. Tahap I pasangan baru menikah
 - B. Tahap V keluarga dengan anak remaja
 - C. Tahap VI keluarga yang melepas anak usia dewasa muda
 - D. Tahap VII orang tua pertengahan
 - E. Tahap VIII keluarga masa pensiun dan lansia
5. Pada saat pengkajian perawat ingin menanyakan tentang bagaimana kepercayaan keluarga terhadap petugas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini komponen pengkajian termasuk dalam pengkajian ...
- A. Sumber data keluarga
 - B. Tahap dan tugas perkembangan keluarga
 - C. Struktur keluarga
 - D. Fungsi keluarga
 - E. Stres, coping dan adaptasi keluarga

Soal Essay

1. Jelaskan kembali apa yang harus dikaji pada saat melakukan pengkajian tentang fungsi keluarga!
2. Buatlah pertanyaan untuk mengkaji stres, coping dan adaptasi keluarga!
3. Buatlah pertanyaan untuk mengkaji tahap dan tugas perkembangan keluarga pada keluarga tahap II!
4. Sebutkan dan jelaskan tentang sumber data pada pengkajian keluarga!
5. Seorang bayi laki-laki usia 11 bulan dengan berat badan 5 kg tinggal bersama ibu dan neneknya. Hasil pengkajian didapatkan anak susah makan, Ibu memberikan menu anak sama dengan menu orang dewasa di rumah. Hasil KMS terakhir di Posyandu balita didapatkan hasil berat badan di bawah garis merah. Ibu bekerja sebagai buruh cuci, neneknya tidak bekerja. Ibu menganggap yang terjadi pada anaknya biasa saja. Uraikan apa saja yang dikaji terkait tugas keluarga pada kasus di atas!

Kunci Jawaban

1. d. Fungsi keluarga
2. a. Bagaimana keluarga membina hubungan dan kepuasan bersama?
3. a. Kemampuan keluarga mengenal masalah kesehatan keluarga
4. d. Tahap VII orang tua pertengahan
5. d. Fungsi keluarga

F. Rangkuman Materi

Pengkajian keperawatan keluarga merupakan pengkajian yang meliputi individu dan kesatuan keluarga. Pada saat melakukan pengkajian harus memperhatikan hal-hal berikut antara lain sumber data pengkajian dalam keluarga, teknik dalam melakukan pengkajian mulai dari wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi, pengkajian dalam struktur keluarga yang bisa digambarkan dalam bentuk genogram, ecomap dan pohon silsilah keluarga. Selanjutnya dikaji juga tentang tahap perkembangan keluarga yang terdiri dari 8 tahap perkembangan yang harus dipahami tentang tugas perkembangan dan fokus masalah kesehatan yang harus ditangani. Menjadi ciri khas dalam pengkajian keperawatan keluarga adalah pengkajian tentang fungsi keluarga yang terdiri dari 5 fungsi keluarga yang di dalamnya ada 5 tahapan tugas keluarga dan terakhir dikaji tentang stres, coping dan adaptasi keluarga.

G. Glosarium

Anuria: berkenaan dengan perasaan seperti takut, cinta yang mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi.

Depresi : gangguan suasana hati (mood) yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai

Disabilitas: keterbatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas secara benar-benar normal.

Gangguan mobilitas adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan (aktivitas).

H. Daftar Pustaka

Friedman, M. (2010). Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik. Jakarta: EGC.

Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). BUKU AJAR KEPERAWATAN KELUARGA : Riset, Teori & Praktik (5th ed.; A. Y. S. Hamid, A. Sutarna, N. B. Subekti, D. Yulianti, & N. Herdina, eds.). Jakarta: EGC.

Kholifah, S. N., & Widagdo, W. (2016). Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan Keluarga dan Komunitas. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Marilyn M. Friedman, P. M. M. R., Vicky R. Bowden, Dns. R., & Elaine G. Jones. PhD, M. R. (2010). Buku Ajar Keperawatan Keluarga Riset, Teori, & Praktik (5th ed.). Jakarta: Penerbin Buku Kedokteran EGC.

Sahar, J., Setiawan, A., & Riasmini, N. M. (2019). Keperawatan Kesehatan Komunitas dan Keluarga (1st Edisi). Elsevier Singapore Pte Ltd.

BAB 7

TINDAKAN KEPERAWATAN KELUARGA

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan definisi dari Intervensi dan tindakan keperawatan
- Memaparkan tipe tindakan keperawatan
- Memaparkan tindakan keperawatan dalam mencapai 5 tugas kesehatan keluarga.

Capaian Pembelajaran

- Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan (CPL.02)
- Mampu melakukan komunikasi terapeutik, bertanggungjawab dan berperan secara aktif dalam interprofesional kolaborasi dengan tim kesehatan, klien, keluarga dan masyarakat (CPL.03)
- Mampu menjalankan pekerjaan profesinya dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasar evidence base practice, perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan bertanggungjawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi (CPL.04)

Pendahuluan

Judul buku di bab 7 ini adalah tindakan keperawatan keluarga, dipilih untuk menggambarkan inti dari perjalanan pemikiran dan eksplorasi mendalam yang akan kita temui di setiap halamannya. Dengan latar belakang sebagai dosen keperawatan keluarga dan komunitas, penulis percaya bahwa perspektif penulis yang dihadirkan dalam buku ini dapat membantu pembaca untuk memahami tindakan keperawatan keluarga dengan cara yang lebih mendalam dan aplikatif. Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam pada pembaca tentang tindakan keperawatan keluarga, sehingga pembaca dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pelayanan keperawatan di komunitas/Puskesmas. Buku ini ditujukan untuk dosen, perawat puskesmas, dan mahasiswa keperawatan, terutama yang sedang mempelajari asuhan keperawatan keluarga, agar dapat memahami konsep-konsep dasar hingga lanjut dengan lebih mudah. Isi buku ini menguraikan tentang tipe

tindakan keperawatan keluarga; observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Selain itu dipaparkan juga mengenai tindakan keperawatan dalam mencapai 5 tugas kesehatan keluarga. Buku ini dirancang menggunakan pendekatan pembelajaran yang terintegrasi, dengan teks tulisan yang jelas dan sistematis, disertai contoh tindakan keperawatan untuk membantu pembaca memahami konsep secara mendalam. Buku ini menggunakan pendekatan *pembelajaran aktif*, yang mendorong pembaca untuk secara langsung terlibat melalui latihan, refleksi, dan contoh-contoh di lapangan.

A. Intervensi dan Tindakan Keperawatan

1. Definisi

Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran (outcome) yang diharapkan (PPNI, 2018).

Tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Tindakan-tindakan pada intervensi keperawatan terdiri atas observasi, therapeutic, edukasi dan kolaborasi (PPNI, 2018).

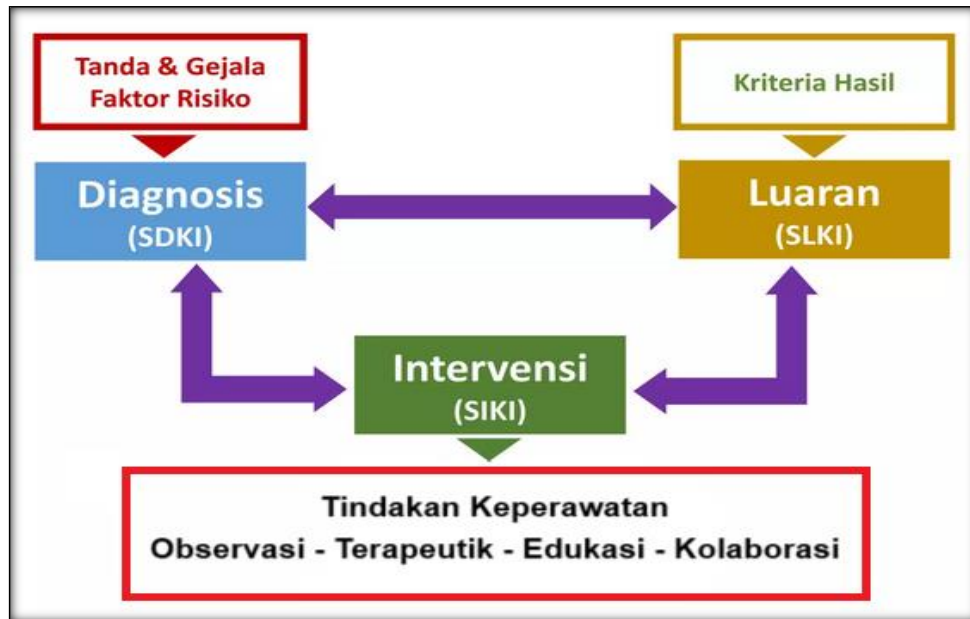
2. Tipe Tindakan Keperawatan

a. Observasi

Tindakan observasi adalah tindakan yang ditujukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data status kesehatan pasien. Tindakan ini umumnya menggunakan kata-kata 'periksa', 'identifikasi', atau 'monitor'. Dianjurkan menghindari penggunaan kata 'kaji' karena serupa dengan tahap awal pada proses perawatan dan agar tidak rancu dengan tindakan keperawatan yang merupakan tahap pascadiagnosis, sementara pengkajian merupakan tahap prediagnosis.

Tindakan observasi dalam keperawatan keluarga merupakan salah satu tindakan penting. Konsep observasi dalam konteks ini mencakup pengumpulan data dan informasi secara sistematis untuk memahami kondisi kesehatan keluarga.

Bagan 7.1. Faktor yang berkaitan dengan Intervensi dan Tindakan Keperawatan



1) Definisi Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan keluarga secara langsung atau tidak langsung. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, kebutuhan, serta potensi keluarga untuk mendukung proses perawatan.

2) Tujuan Observasi

- a) Mengidentifikasi masalah kesehatan keluarga: melihat secara langsung gejala, penyakit/kondisi yang memengaruhi kesehatan.
- b) Menilai lingkungan keluarga, meliputi: kebersihan, sanitasi, ventilasi, dan sumber daya yang tersedia.
- c) Memantau respons keluarga terhadap intervensi: mengamati sejauh mana keluarga memahami dan melaksanakan intervensi keperawatan yang telah diberikan.
- d) Menilai faktor risiko: menentukan adanya faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi kesehatan keluarga.

3) Metode Observasi

- a) Langsung: Mengamati secara langsung situasi atau kondisi di lapangan (contoh: observasi ketika kunjungan rumah pada klien keluarga yang mengalami masalah kesehatan).
- b) Tidak langsung: Melalui wawancara, kuesioner, atau laporan pihak ketiga (misalnya laporan puskesmas atau kader kesehatan).

4) Langkah-Langkah Observasi dalam Keperawatan Keluarga

- a) Persiapan: Menentukan tujuan observasi (contoh: memantau perkembangan penyakit atau mengevaluasi kebersihan rumah). Menyiapkan alat atau instrumen yang dibutuhkan.
- b) Pelaksanaan: Mengamati aspek-aspek yang relevan dengan masalah kesehatan keluarga. Mendokumentasikan hasil pengamatan secara sistematis.
- c) Evaluasi: Meninjau hasil observasi untuk menentukan diagnosis keperawatan. Menggunakan hasil observasi untuk menyusun rencana intervensi.

5) Penerapan Observasi dalam SIKI

Tindakan observasi dalam SIKI memiliki kode dan panduan tertentu berdasarkan diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan, seperti:

- a) Observasi status kesehatan keluarga: Melihat kondisi umum dan pola kesehatan keluarga.
- b) Observasi lingkungan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di lingkungan tempat tinggal.

Dengan melakukan observasi yang sistematis, perawat dapat memberikan intervensi yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan keluarga.

b. Tindakan Terapeutik

Tindakan yang secara langsung dapat berefek memulihkan status kesehatan pasien atau dapat mencegah perburukan masalah kesehatan pasien. Pada umumnya menggunakan kata-kata 'berikan', 'lakukan', 'gunakan', 'motivasi', ciptakan, dan kata-kata lainnya.

1) Definisi.

Tindakan terapeutik adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk membantu keluarga mencapai kesejahteraan kesehatan melalui pendekatan yang terarah, empati, dan berbasis bukti. Tindakan ini bertujuan untuk mendukung keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan, meningkatkan kemampuan mereka dalam merawat anggota keluarga, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan.

2) Tujuan Tindakan Terapeutik

- a) Memperbaiki fungsi keluarga: Membantu keluarga mengenali perannya dalam proses perawatan kesehatan.
- b) Memberikan dukungan psikososial: Membantu keluarga mengatasi stres, konflik, atau tantangan yang muncul akibat masalah kesehatan.
- c) Meningkatkan kemandirian: Mengajarkan keterampilan perawatan sehingga keluarga mampu merawat anggota dengan baik.

- d) Memperkuat kapasitas adaptasi: Membantu keluarga mengelola perubahan atau kondisi kronis yang memengaruhi dinamika keluarga.
- 3) Komponen Tindakan Terapeutik
- Tindakan terapeutik melibatkan beberapa pendekatan, yaitu:
- a) Edukasi.
- Memberikan informasi terkait penyakit, perawatan, atau tindakan yang perlu dilakukan.
 - Mengajarkan keterampilan dasar, seperti pemberian obat atau teknik perawatan luka.
- b) Psikologis
- Meningkatkan dukungan emosional keluarga.
 - Mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi stres.
 - Membantu keluarga mengelola konflik yang muncul akibat masalah kesehatan.
 - Memotivasi keluarga dalam memberikan dukungan perawatan pada anggota keluarga yang sakit.
- c) Sosial
- Memperkuat hubungan keluarga melalui peningkatan komunikasi yang efektif.
 - Membantu keluarga memanfaatkan sumber daya komunitas atau layanan kesehatan.
- d) Lingkungan Rumah
- Membantu keluarga memodifikasi lingkungan rumah yang aman dan mendukung kesehatan, seperti perbaikan sanitasi, ventilasi, atau pengaturan ruang bagi anggota yang sakit.
 - Membantu keluarga dalam menilai resiko kesehatan terkait mobilitas anggota keluarga.
- 4) Prinsip Dasar Tindakan Terapeutik
- a) **Holistik, yaitu** mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual keluarga.
- b) **Berpusat pada keluarga, yaitu** mengakui bahwa keluarga adalah unit perawatan utama.
- c) **Kolaboratif yaitu** melibatkan keluarga dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi.
- d) **Empati dan dukungan yaitu** menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan keluarga secara menyeluruh.
- 5) Langkah-Langkah Pelaksanaan Tindakan Terapeutik
- a) Pengkajian:

- Mengidentifikasi masalah kesehatan keluarga.
- Menilai kemampuan keluarga dalam menghadapi masalah.

Perencanaan:

- Menyusun intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas keluarga.

b) **Pelaksanaan:**

- Memberikan tindakan sesuai dengan rencana, seperti edukasi kesehatan, konseling, atau motivasi

c) **Evaluasi:**

- Menilai efektivitas tindakan yang telah dilakukan.
- Menyesuaikan rencana berdasarkan respons keluarga.

6) Contoh Tindakan Terapeutik Berdasarkan SIKI

Beberapa tindakan terapeutik dalam keperawatan keluarga menurut SIKI meliputi:

- Edukasi Kesehatan (Pendidikan Kesehatan Keluarga):** memberikan informasi terkait pola hidup sehat dan perawatan anggota keluarga yang sakit.
- Dukungan Emosional (Emotional Support):** memberikan motivasi dan dukungan psikologis kepada keluarga.
- Manajemen Stres (Stress Management):** mengajarkan teknik coping kepada keluarga yang mengalami tekanan emosional.
- Peningkatan Kapasitas (Family Coping Enhancement):** meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi kondisi kronis atau situasi darurat.

Dengan pendekatan terapeutik yang efektif, keluarga tidak hanya menjadi penerima perawatan tetapi juga mitra aktif dalam proses perawatan kesehatan. Hal ini meningkatkan keberhasilan intervensi keperawatan serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

c. Tindakan Edukasi

Tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pasien merawat dirinya dengan membantu pasien memperoleh perilaku baru yang dapat mengatasi masalah. Tindakan ini umumnya menggunakan kata-kata 'ajarkan', 'anjurkan', atau 'latih'.

1) Definisi

Tindakan edukasi adalah intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keluarga dalam mendukung kesehatan individu dan keluarga sebagai satu kesatuan. Edukasi ini

membantu keluarga memahami masalah kesehatan, memilih perilaku sehat, dan mengambil peran aktif dalam proses perawatan.

2) Tujuan Tindakan Edukasi

- a) Meningkatkan pengetahuan keluarga: Membantu keluarga memahami masalah kesehatan dan langkah-langkah perawatan.
- b) Meningkatkan keterampilan perawatan: Mengajarkan keluarga cara merawat anggota yang sakit atau dengan kebutuhan khusus.
- c) Mengubah perilaku kesehatan: Mendorong keluarga untuk mengadopsi pola hidup sehat.
- d) Meningkatkan kemandirian keluarga: Membantu keluarga memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendukung kesehatan.

3) Komponen Tindakan Edukasi

Tindakan edukasi mencakup beberapa aspek berikut:

a) Edukasi Tentang Penyakit

- Penjelasan tentang diagnosis, penyebab, gejala, dan komplikasi penyakit.
- Informasi tentang pengobatan, termasuk dosis, waktu, dan efek samping obat.

b) Edukasi Promosi Kesehatan

- Pola hidup sehat, seperti gizi seimbang, olahraga, dan manajemen stres.
- Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi.

c) Edukasi Tindakan Perawatan

- Teknik perawatan spesifik, seperti pemberian obat, perawatan luka, atau perawatan pasien bedrest.
- Panduan mengatasi situasi darurat, seperti serangan asma atau hipoglikemia.

d) Edukasi Pemanfaatan Sumber Daya

- Informasi tentang layanan kesehatan yang tersedia, seperti fasilitas kesehatan, program imunisasi, atau program gizi.

4) Prinsip-Prinsip Tindakan Edukasi

- a) Berpusat pada keluarga: Edukasi disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan keluarga.
- b) Interaktif: Melibatkan keluarga secara aktif dalam proses edukasi.
- c) Komunikasi yang jelas: Menggunakan bahasa sederhana dan sesuai tingkat pemahaman keluarga.
- d) Relevansi: Informasi yang diberikan harus relevan dengan masalah kesehatan yang dihadapi.

- e) Berulang: Edukasi dilakukan secara berulang untuk memastikan pemahaman yang baik.
- 5) Langkah-Langkah Tindakan Edukasi
- a) Pengkajian:
- Menilai tingkat pemahaman, kebutuhan, dan preferensi keluarga.
 - Mengidentifikasi hambatan belajar, seperti literasi rendah atau kendala budaya.
- b) Perencanaan:
- Menentukan tujuan edukasi berdasarkan kebutuhan keluarga.
 - Menyiapkan bahan ajar, seperti leaflet, video, atau demonstrasi langsung.
- c) Pelaksanaan:
- Memberikan informasi secara jelas dan terstruktur.
 - Menggunakan metode yang sesuai, seperti diskusi, demonstrasi, atau role-play.
- d) Evaluasi:
- Mengukur tingkat pemahaman keluarga melalui tanya jawab atau pengulangan informasi.
 - Mengevaluasi perubahan perilaku atau keterampilan keluarga.
- 6) Contoh Tindakan Edukasi Berdasarkan SIKI
- a) Pendidikan Kesehatan Keluarga (Family Health Education): Memberikan informasi tentang pola makan sehat, cara mencegah penularan penyakit, dan pentingnya imunisasi.
- b) Edukasi Pengelolaan Penyakit Kronis (Chronic Disease Management Education): Mengajarkan cara mengontrol tekanan darah untuk pasien hipertensi atau manajemen gula darah untuk pasien diabetes.
- c) Edukasi Perawatan Mandiri (Self-Care Education): Memberikan pelatihan kepada keluarga tentang perawatan luka atau penggunaan alat bantu kesehatan. Didemostrasikan oleh perawat.
- d) Edukasi Gizi (Nutritional Education): Mengajarkan cara menyusun menu seimbang untuk meningkatkan status gizi keluarga.

Dengan memberikan edukasi yang tepat, keluarga dapat menjadi mitra aktif dalam proses perawatan, meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga yang sakit, serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Edukasi dalam keperawatan keluarga adalah langkah penting untuk membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

d. Tindakan Kolaborasi

Tindakan yang membutuhkan kerjasama baik dengan perawat lainnya maupun dengan profesi kesehatan lainnya. Tindakan ini membutuhkan gabungan pengetahuan, dan keterampilan dari berbagai profesi Kesehatan. Tindakan ini umumnya menggunakan kata-kata 'kolaborasi', 'rujukan', atau 'konsultasikan'.

1) Definisi

Tindakan kolaborasi adalah serangkaian intervensi yang melibatkan kerja sama antara perawat, anggota keluarga, tenaga kesehatan lain, serta pihak terkait dalam memberikan asuhan yang komprehensif untuk mencapai kesehatan optimal keluarga. Tindakan kolaborasi ini dirancang untuk menangani kebutuhan kompleks yang melibatkan berbagai disiplin ilmu.

2) Tujuan Tindakan Kolaborasi

- a) Menyelesaikan masalah kesehatan yang kompleks: Memanfaatkan keahlian lintas disiplin untuk mengatasi masalah yang membutuhkan penanganan khusus.
- b) Meningkatkan akses keluarga terhadap layanan kesehatan: Menghubungkan keluarga dengan fasilitas atau layanan kesehatan yang relevan.
- c) Mempercepat pemulihan anggota keluarga: Mengintegrasikan terapi fisik, psikologis, dan sosial.
- d) Mengoptimalkan sumber daya: Memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien melalui kerja sama antarprofesi.

3) Prinsip-Prinsip Tindakan Kolaborasi

- a) Komunikasi efektif: Setiap pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing.
- b) Kerja tim: Berfokus pada pendekatan multidisiplin untuk mencapai tujuan bersama.
- c) Berpusat pada keluarga: Semua keputusan dan tindakan harus memperhatikan kebutuhan, preferensi, dan keterlibatan keluarga.
- d) Koordinasi yang baik: Setiap langkah intervensi harus terkoordinasi untuk menghindari tumpang tindih atau kesalahpahaman.

4) Komponen Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi melibatkan beberapa aspek berikut:

a) Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan

- Merujuk pasien ke dokter, ahli gizi, atau fisioterapis sesuai kebutuhan.
- Mendiskusikan rencana pengobatan dengan tim kesehatan, seperti ahli farmasi untuk pengaturan obat.

- b) Kolaborasi dengan Keluarga
 - Mengedukasi keluarga tentang peran mereka dalam mendukung proses perawatan.
 - Membangun kepercayaan antara keluarga dan tim kesehatan.
 - c) Kolaborasi dengan Komunitas
 - Menghubungkan keluarga dengan sumber daya komunitas, seperti posyandu, puskesmas, atau layanan sosial.
 - Berkoordinasi dengan kader kesehatan atau pekerja sosial untuk mendukung perawatan keluarga.
 - d) Kolaborasi Antarprofesi
 - Melibatkan psikolog untuk membantu masalah kesehatan mental keluarga.
 - Bekerja sama dengan pekerja sosial untuk menyediakan dukungan finansial atau logistik.
- 5) Langkah-Langkah Tindakan Kolaborasi
- a) Pengkajian:
 - Mengidentifikasi kebutuhan kesehatan keluarga yang memerlukan intervensi dari pihak lain.
 - Menentukan prioritas tindakan berdasarkan masalah kesehatan yang kompleks.
 - b) Perencanaan:
 - Menyusun rencana intervensi kolaboratif bersama tim kesehatan.
 - Melibatkan keluarga dalam menyusun rencana untuk memastikan dukungan mereka.
 - c) Pelaksanaan:
 - Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan atau pihak eksternal untuk menjalankan intervensi.
 - Melibatkan keluarga dalam setiap langkah perawatan.
 - d) Evaluasi:
 - Menilai efektivitas kerja sama dalam menyelesaikan masalah kesehatan keluarga.
 - Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.
- 6) Contoh Tindakan Kolaborasi Berdasarkan SIKI
- a) Kolaborasi dalam Manajemen Penyakit Kronis:

Bekerja sama dengan dokter dan ahli gizi untuk menangani diabetes atau hipertensi pada anggota keluarga.

b) Kolaborasi Psikologis:

Merujuk keluarga dengan masalah emosional atau konflik keluarga ke psikolog atau konselor.

c) Kolaborasi Sosial:

Menghubungkan keluarga kurang mampu dengan program bantuan sosial, seperti BPJS atau bantuan pangan.

d) Kolaborasi dalam Perawatan Luka:

Berkoordinasi dengan dokter bedah atau ahli perawatan luka untuk perawatan yang lebih intensif.

Dengan tindakan kolaborasi yang efektif, perawat dapat memberikan asuhan yang terintegrasi dan holistik kepada keluarga. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mengatasi masalah kesehatan yang kompleks, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

B. Tindakan Keperawatan dalam Mencapai 5 Tugas Kesehatan Keluarga

Kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit berkaitan dengan sejauh mana keluarga dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota yang mengalami gangguan kesehatan. Kemampuan ini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi dalam merawat anggota keluarga yang sakit agar dapat mencapai pemulihan optimal. Tindakan keperawatan berbasis edukasi, dukungan, dan intervensi langsung untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mencapai **5 tugas kesehatan keluarga**

1. Mengenali masalah kesehatan keluarga

Tugas ini mencakup kemampuan keluarga dalam mengidentifikasi tanda dan gejala penyakit serta faktor risiko kesehatan.

Tindakan keperawatan:

- Memberikan **penyuluhan** tentang tanda-tanda penyakit umum, faktor risiko, dan cara pencegahannya atau masalah kesehatan yang dihadapi.
- Mengajarkan teknik **pemantauan kesehatan** (misalnya cara mengukur suhu, tekanan darah, atau kadar gula darah).
- Mendorong keluarga untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

2. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat

Keluarga harus mampu menentukan apakah masalah pada anggota keluarga yang sakit dirasakan sebagai masalah oleh keluarga, seberapa berat masalah tersebut dirasakan oleh keluarga, dan informasi apa yang sudah dimiliki keluarga.

Tindakan keperawatan:

- a. Mengidentifikasi konsekuensi jika tidak melakukan tindakan yang tepat.
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki keluarga untuk mengatasi masalah.
- c. Mendiskusikan tentang konsekuensi tiap tindakan yang akan diambil.

3. Merawat anggota keluarga yang sakit

Keluarga bertanggung jawab dalam memberikan perawatan yang sesuai kepada anggota yang sakit.

Tindakan keperawatan:

- a. Melatih keterampilan dasar (mendemonstrasikan) seperti cara merawat luka, memberikan obat, atau melakukan perawatan pasien dengan penyakit kronis.
- b. Memberikan panduan tentang gizi dan diet yang sesuai untuk pemulihan.
- c. Mengajarkan teknik perawatan kebersihan dan mobilisasi pasien agar mencegah komplikasi seperti dekubitus (luka akibat tekanan).
- d. Menggunakan alat dan fasilitas yang ada di rumah.
- e. Mengawasi keluarga melakukan perawatan.

4. Memodifikasi lingkungan agar sehat

Lingkungan yang bersih dan sehat dapat mencegah penyakit dan mempercepat pemulihan pasien. Perawat dapat membantu keluarga untuk menemukan cara bagaimana membuat lingkungan yang sehat.

Tindakan keperawatan:

- a. Menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan keluarga.
- b. Melakukan perubahan lingkungan keluarga seoptimal mungkin.
- c. Menilai kondisi rumah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lingkungan yang lebih sehat.
- d. Memberikan edukasi tentang sanitasi rumah yang baik (misalnya ventilasi udara, kebersihan air, dan pembuangan limbah).
- e. Mendorong keluarga untuk menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di rumah.

5. Menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia

Keluarga harus mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada, baik puskesmas, rumah sakit, maupun klinik.

Tindakan keperawatan:

- a. Memberikan informasi tentang lokasi dan jenis layanan kesehatan yang tersedia.
- b. Membantu keluarga dalam mengakses jaminan kesehatan seperti BPJS atau asuransi lainnya.

- c. Mengajarkan pentingnya imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan skrining penyakit.

Perawat memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas keluarga untuk menjalankan tugas kesehatannya. Dengan edukasi, pelatihan, dan dukungan yang tepat, keluarga dapat lebih mandiri dalam merawat anggotanya dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Peran perawat dalam meningkatkan kemampuan keluarga untuk merawat anggota keluarga yang sakit diantaranya adalah:

1. Edukasi: memberikan informasi tentang penyakit, perawatan, dan pencegahan komplikasi.
2. Pelatihan: mengajarkan keterampilan dasar dalam merawat pasien di rumah.
3. Dukungan emosional: memberikan motivasi dan membantu keluarga mengelola stres.
4. Koordinasi layanan kesehatan: membantu keluarga mengakses fasilitas kesehatan yang sesuai.

C. Soal Latihan

Soal Pilihan Ganda Biasa.

Pilih jawaban yang paling tepat !.

1. Pada diagnosis gangguan proses keluarga pada keluarga TK.L berhubungan dengan perubahan fungsi kesehatan keluarga, perawat mengimplementasi dukungan koping keluarga. Tindakan edukasi perawat yang paling tepat pada implementasi tersebut adalah
 - A. Merujuk untuk terapi keluarga
 - B. Menginformasikan fasilitas perawatan kesehatan yang tersedia
 - C. Mendengarkan masalah, perasaan, dan pertanyaan dari keluarga
 - D. Menjelaskan strategi pengembalian kehidupan keluarga yang normal
 - E. Mempertahankan interaksi yang berkelanjutan dengan anggota keluarga
2. Pada diagnosis ketidakpatuhan pengobatan TB Paru pada keluarga Tn.A berhubungan dengan program terapi TB Paru yang kompleks dan lama, perawat mengimplemetasikan dukungan kepatuhan program pengobatan TB. Tindakan terapeutik perawat yang paling tepat pada kasus tersebut adalah
 - A. Membuat komitmen menjalani program pengobatan TB Paru dengan baik
 - B. Mengidentifikasi kepatuhan menjalani program pengobatan TB Paru
 - C. Menginformasikan program pengobatan TB Paru yang harus dijalani
 - D. Menganjurkan keluarga untuk mendampingi pasien selama menjalani program pengobatan TB Paru.

- E. Mengajukan keluarga untuk konsultasi ke perawat program TB di Puskesmas
3. Pada diagnosis manajemen DM pada keluarga Tn.C tidak efektif berhubungan dengan kompleksitas program pengobatan DM., perawat mengimplementasikan mengenai dukungan keluarga merencanakan perawatan DM pada Ny.C. Tindakan terapeutik perawat yang paling tepat pada kasus tersebut adalah
- A. Mengajarkan cara perawatan DM yang bisa dilakukan keluarga
 - B. Mendengarkan masalah, perasaan, dan pertanyaan dari keluarga
 - C. Menginformasikan program pengobatan DM yang harus dijalani
 - D. Mengidentifikasi tindakan (manajemen DM) yang dapat dilakukan keluarga
 - E. Memotivasi pengembangan sikap dan emosi keluarga yang mendukung upaya kesehatan (manajemen DM).
4. Pada diagnose manajemen DM pada keluarga Tn.C tidak efektif berhubungan dengan kompleksitas program pengobatan DM., perawat mengimplementasikan mengenai dukungan keluarga merencanakan perawatan DM pada Ny.C. Tindakan edukasi perawat yang paling tepat pada kasus tersebut adalah
- A. Menginformasikan cara perawatan DM yang bisa dilakukan keluarga
 - B. Mendengarkan masalah, perasaan, dan pertanyaan dari keluarga
 - C. Menginformasikan program pengobatan DM yang harus dijalani
 - D. Mengidentifikasi tindakan (manajemen DM) yang dapat dilakukan keluarga
 - E. Memotivasi pengembangan sikap dan emosi keluarga yang mendukung upaya kesehatan (manajemen DM).
5. Perawat mendemonstrasikan teknik napas dalam dan batuk efektif pada klien keluarga dengan kasus ISPA di rumah. Perawat tersebut melakukan tindakan
- A. Edukasi
 - B. Terapeutik
 - C. Observasi
 - D. Advokasi
 - E. Kolaborasi

Soal Essai.

1. Sebutkan dan jelaskan definisi dari intervensi dan tindakan keperawatan keluarga !.
2. Jelaskan perbedaan observasi sebagai tindakan keperawatan dan sebagai pengkajian !

3. Jelaskan bagaimana tindakan kolaborasi perawat pada asuhan keperawatan keluarga !.
4. Uraikan bagaimana tindakan keperawatan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatannya !.
5. Uraikan bagaimana tindakan keperawatan untuk meningkatkan keterampilan keluarga dalam merawat pasien stroke dengan kelemahan otot dan kekakuan sendi !.

Kunci Jawaban :

1. B
2. A
3. E
4. A
5. A

D. Rangkuman Materi

Tindakan keperawatan keluarga adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan oleh perawat puskesmas untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan pada keluarga. Tindakan-tindakan pada intervensi keperawatan keluarga terdiri dari observasi, therapeutic, edukasi dan kolaborasi. Tindakan keperawatan keluarga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi 5 tugas kesehatan keluarga; mengenal masalah kesehatan yang dihadapi keluarga, mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan, merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan, memodifikasi lingkungan yang mendukung penyelesaian masalah kesehatan, dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada untuk mengatasi masalah kesehatan pada keluarga.

E. Glosarium

Observasi; pengamatan yang dilakukan secara cermat dan sistematis terhadap suatu objek, fenomena, atau situasi untuk mendapatkan informasi atau data.

Edukasi; proses pembelajaran atau pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap individu/keluarga.

Kolaborasi; kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Terapeutik; segala hal yang berkaitan dengan penyembuhan atau perawatan kesehatan, baik fisik maupun mental.

F. Daftar Pustaka

- Bastable, S. B. (2019). *Nurse as Educator: Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice* (5th Edition). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
- Friedman, M.M., Marilyn R, Bowden, Vicky R., Jones, and Elaine, (2020). *Family Nursing: Research, Theory, and Practice*. (6th ed.). Pearson.
- Herman, J., & Murtini, E. (2020). "Peran Perawat dalam Edukasi Kesehatan Keluarga: Tinjauan Literatur". *Jurnal Keperawatan & Kesehatan*, 8(3), 25-30.
- Hood, L. J. (2018). *Leddy & Pepper's Conceptual Bases of Professional Nursing* (9th Edition). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- Kakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Robinson, M., & Hanson, S. M. (2018). *Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research* (6th ed.). FA Davis.
- Nies, M. A., & McEwen, M. (2018). *Community/Public Health Nursing: Promoting the Health of Populations*. Elsevier.
- Nursalam. (2020). *Konsep dan Penerapan Metodologi Asuhan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017). *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) edisi 1*. DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) edisi 1*. DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2020). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) edisi 1*. DPP PPNI.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2020). *Fundamentals of Nursing* (10th Edition). Elsevier.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community* (10th Edition). St. Louis: Mosby/Elsevier.
- Sukmawati, T., & Wulandari, D. (2021). "Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Keluarga melalui Edukasi Kesehatan di Komunitas". *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1), 15-20.
- Taylor, S.E., (2020). *Health psychology* (11th ed.). McGraw-Hill.

WHO, (2021). *Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030*.

BAB 8

TREN DAN ISsUE KEPERAWATAN KELUARGA

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran topik ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Mampu menerapkan pengetahuan tentang konsep dan praktik keperawatan berbasis keluarga secara profesional, etis, dan responsif terhadap perubahan zaman.
- Mampu menganalisis tren dan isu kontemporer dalam keperawatan keluarga yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
- Mampu berkolaborasi secara interprofesional dalam upaya promosi, pencegahan, kuratif, dan rehabilitatif berbasis keluarga.
- Mampu menggunakan teknologi dan data terkini dalam menyusun rencana asuhan keperawatan keluarga.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan berbagai tren yang berkembang dalam keperawatan keluarga di tingkat nasional dan global.
- Mengidentifikasi isu-isu utama dalam keperawatan keluarga yang relevan dengan konteks Indonesia.
- Menganalisis dampak tren dan isu tersebut terhadap praktik keperawatan keluarga.
- Merancang respon strategis keperawatan keluarga terhadap perubahan tren dan isu yang ada.

Sub-CPMK

Untuk mencapai CPMK di atas, mahasiswa diharapkan dapat:

- Mendeskripsikan konsep family-centered care, homecare, dan palliative care dalam keperawatan keluarga.
- Menguraikan perubahan demografi dan sosial budaya yang mempengaruhi struktur dan fungsi keluarga.
- Mengidentifikasi isu-isu utama seperti penyakit tidak menular, peran gender dalam keluarga, dan tantangan parenting.
- Menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah dan sistem kesehatan terhadap layanan keperawatan keluarga.
- Menganalisis studi kasus tentang keluarga dengan masalah kesehatan kronik atau risiko bencana.
- Merumuskan intervensi keperawatan keluarga berbasis komunitas dalam menghadapi isu yang aktual.
- Menyusun rencana edukasi kesehatan berbasis keluarga sesuai konteks budaya dan kebutuhan spesifik keluarga.

Pendahuluan

Keperawatan keluarga sebagai bagian integral dari praktik keperawatan komunitas mengalami perkembangan yang signifikan seiring dinamika sosial, demografis, dan teknologi kesehatan. Perubahan struktur keluarga, peningkatan jumlah lansia, prevalensi penyakit kronis, serta tuntutan pelayanan berbasis nilai dan budaya menempatkan keluarga sebagai pusat dari intervensi keperawatan yang holistik dan preventif.

Dalam konteks global, tren keperawatan keluarga kini mengarah pada family-centered care, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan kesehatan keluarga, peningkatan partisipasi keluarga dalam pengambilan keputusan, serta pendekatan interprofesional dalam pelayanan primer. Di Indonesia, isu-isu seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, pergeseran pola penyakit, ketimpangan sosial-ekonomi, dan kesiapan keluarga dalam menghadapi bencana menjadi tantangan nyata bagi perawat keluarga.

Pemahaman terhadap tren dan isu keperawatan keluarga mutlak diperlukan agar perawat mampu menyusun rencana asuhan yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis bukti. Bab ini membahas dinamika tersebut, disertai analisis dampaknya terhadap praktik keperawatan keluarga serta strategi penguatan peran perawat dalam menghadapi perubahan yang terjadi.

A. Perubahan Tren dalam Keperawatan Keluarga

Perkembangan ilmu keperawatan dan dinamika sosial masyarakat telah mendorong terjadinya berbagai perubahan signifikan dalam praktik keperawatan keluarga. Keperawatan keluarga tidak lagi sekadar dipahami sebagai praktik perawatan yang dilakukan di lingkungan rumah, melainkan sebagai pendekatan komprehensif yang menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam upaya pemeliharaan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan. Dalam dua dekade terakhir, perubahan tren ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi informasi, perkembangan paradigma pelayanan kesehatan, hasil penelitian ilmiah terkini, dan tantangan-tantangan baru dalam sistem kesehatan masyarakat. Bagian ini akan menguraikan secara mendalam empat tren utama yang membentuk arah baru dalam praktik keperawatan keluarga, yaitu family-centered care, digitalisasi dan teknologi kesehatan, keperawatan berbasis bukti (evidence-based family nursing), serta kolaborasi interprofesional.

1. Family-Centered Care

Family-centered care merupakan pendekatan yang semakin banyak diterapkan dalam praktik keperawatan keluarga karena memberikan pengakuan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam proses penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan keluarga sebagai pendamping pasien, tetapi mengakui keluarga sebagai mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait asuhan keperawatan. Dalam kerangka family-centered care, nilai, budaya, kebiasaan, dan preferensi keluarga menjadi bagian penting yang harus dihormati oleh tenaga kesehatan. Perawat tidak sekadar memberikan instruksi, tetapi membangun komunikasi yang efektif dan empatik dengan anggota keluarga, mengedukasi mereka secara menyeluruh, serta melibatkan mereka dalam setiap tahap pengambilan keputusan klinis, terutama ketika pasien tidak mampu menyuarakan kebutuhannya sendiri.

Penerapan family-centered care terbukti mampu meningkatkan kepuasan keluarga terhadap layanan kesehatan, meningkatkan efektivitas intervensi keperawatan, serta memperkuat kepatuhan terhadap terapi yang diberikan. Hal ini sangat penting dalam pengelolaan penyakit kronik, kondisi terminal, atau perawatan anak-anak, di mana dukungan keluarga memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan terapi. Dengan demikian, perawat keluarga dituntut untuk memiliki kompetensi komunikasi interpersonal yang tinggi, empati budaya, serta

keterampilan dalam membina hubungan terapeutik jangka panjang dengan keluarga.

2. Digitalisasi dan Teknologi Kesehatan

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan revolusioner dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan dan keperawatan keluarga. Perawat kini dihadapkan pada peluang besar dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada keluarga. Penggunaan telehealth dan telemonitoring memungkinkan perawat untuk melakukan pemantauan status kesehatan anggota keluarga secara jarak jauh, memberikan edukasi melalui platform daring, serta merespon kebutuhan mendesak tanpa harus hadir secara fisik. Teknologi ini sangat membantu terutama dalam situasi geografis yang sulit dijangkau atau pada masa krisis seperti pandemi.

Aplikasi mobile health (mHealth) juga menjadi alat penting dalam mendukung praktik keperawatan keluarga. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengingatkan jadwal minum obat, mencatat gejala harian pasien, atau memberikan edukasi kesehatan berbasis kebutuhan spesifik keluarga. Sistem informasi keluarga berbasis digital pun telah dikembangkan di beberapa negara untuk menyimpan data kesehatan seluruh anggota keluarga dalam satu platform yang dapat diakses oleh tenaga kesehatan secara aman dan efisien.

Namun, pemanfaatan teknologi ini juga menuntut perawat keluarga untuk mengembangkan kompetensi digital, termasuk keterampilan literasi digital, keamanan data, dan penguasaan perangkat lunak kesehatan. Integrasi antara teknologi dan pelayanan keperawatan keluarga bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas, berkelanjutan, dan personal terhadap perawatan berbasis rumah tangga.

3. Keperawatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Family Nursing)

Dalam era modern, praktik keperawatan tidak lagi dapat didasarkan hanya pada pengalaman atau intuisi semata. Perawat keluarga kini dituntut untuk mampu menerapkan keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice) dalam setiap langkah intervensinya. Evidence-based family nursing merupakan pendekatan yang menggabungkan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis perawat, serta preferensi dan nilai-nilai keluarga dalam proses pengambilan keputusan keperawatan. Pendekatan ini menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan efektivitas pelayanan keperawatan keluarga.

Penerapan evidence-based nursing membutuhkan kemampuan perawat dalam mencari, memahami, menilai, dan mengintegrasikan hasil penelitian terkini

ke dalam praktik sehari-hari. Sebagai contoh, dalam mengelola penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung di lingkungan keluarga, perawat harus mampu mengidentifikasi pedoman klinis terbaru, menyesuaikan intervensi dengan konteks sosial budaya keluarga, serta mengevaluasi hasil asuhan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, keperawatan berbasis bukti tidak hanya meningkatkan kualitas intervensi, tetapi juga memperkuat legitimasi profesi perawat sebagai ilmuwan klinis yang mampu menjembatani riset dan praktik.

4. Peran Interprofesional dalam Keperawatan Keluarga

Perubahan tren dalam keperawatan keluarga juga ditandai dengan semakin menguatnya kebutuhan akan kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan. Keluarga yang menghadapi masalah kesehatan kompleks tidak dapat ditangani oleh satu profesi saja. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai tenaga profesional seperti dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, fisioterapis, dan pekerja sosial menjadi sangat penting dalam menyediakan perawatan yang menyeluruh dan terpadu. Dalam konteks ini, perawat keluarga memiliki peran kunci sebagai koordinator, penghubung, dan fasilitator antarprofesi.

Perawat keluarga harus mampu menyusun rencana asuhan yang melibatkan masukan dari berbagai tenaga kesehatan, menjembatani komunikasi antarprofesi, serta menjamin bahwa semua intervensi dilakukan secara sinergis sesuai kebutuhan keluarga. Kolaborasi yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memberikan pengalaman positif bagi keluarga karena mereka merasa didukung oleh tim kesehatan yang saling terintegrasi.

Peran interprofesional ini juga mendorong perawat untuk mengembangkan kompetensi tambahan seperti manajemen konflik, kepemimpinan kolaboratif, dan komunikasi lintas-budaya. Dalam jangka panjang, sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga serta memperkuat peran perawat keluarga dalam sistem kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis.

B. Isu-Isu Kontemporer Dalam Keperawatan Keluarga

Perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan telah membawa munculnya berbagai isu kontemporer yang memengaruhi praktik keperawatan keluarga di Indonesia maupun secara global. Isu-isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga mencakup aspek psikososial, budaya, politik kesehatan, dan ketimpangan akses terhadap layanan. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, perawat keluarga perlu memiliki sensitivitas terhadap

konteks sosial masyarakat dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan yang terus berkembang. Isu-isu ini juga harus dipahami sebagai peluang untuk memperkuat peran keperawatan keluarga sebagai pilar penting dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

1. Peningkatan Beban Penyakit Tidak Menular dalam Lingkup Keluarga

Salah satu isu yang paling menonjol adalah meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, kanker, dan gangguan metabolik lainnya. PTM kini tidak lagi terbatas pada usia lanjut, tetapi juga mulai menyerang kelompok usia produktif, bahkan remaja, sebagai akibat dari pola hidup sedentari, konsumsi makanan cepat saji, stres kronis, dan rendahnya kesadaran terhadap gaya hidup sehat. Dalam konteks keluarga, hal ini menjadi tantangan karena penyakit kronik memerlukan manajemen jangka panjang, keterlibatan keluarga dalam pengobatan, serta perubahan gaya hidup bersama.

Perawat keluarga diharapkan mampu melakukan pendekatan promotif dan preventif yang sistematis, mulai dari edukasi kesehatan, pemantauan rutin, hingga fasilitasi rujukan apabila diperlukan. Asuhan keperawatan tidak hanya terfokus pada individu yang sakit, tetapi pada seluruh anggota keluarga sebagai satu unit, yang turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan. Ketidakmampuan keluarga dalam memahami, merawat, atau menyesuaikan diri terhadap penyakit kronik anggota keluarga dapat memperburuk kondisi pasien dan menambah beban psikologis keluarga secara keseluruhan.

2. Kesehatan Mental dalam Dinamika Keluarga Modern

Masalah kesehatan jiwa dan gangguan emosional kini menjadi isu yang semakin nyata dalam kehidupan keluarga. Urbanisasi, tekanan ekonomi, disrupsi teknologi, dan menurunnya interaksi sosial yang sehat telah memperbesar risiko gangguan kecemasan, depresi, dan stres kronik, baik pada orang tua, anak, maupun lansia. Pandemi COVID-19 misalnya, telah menunjukkan bagaimana isolasi sosial dan ketidakpastian ekonomi dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga, meningkatkan kekerasan domestik, dan menyebabkan trauma psikologis jangka panjang.

Dalam praktik keperawatan keluarga, isu ini harus ditanggapi secara serius. Perawat tidak hanya perlu mengenali gejala awal gangguan mental, tetapi juga harus mampu memberikan dukungan emosional, edukasi mengenai kesehatan jiwa, serta mengarahkan keluarga kepada layanan kesehatan jiwa profesional. Peran perawat keluarga sebagai early detector dalam konteks kesehatan jiwa

sangat penting, mengingat masih adanya stigma terhadap gangguan mental di banyak komunitas. Kesehatan jiwa tidak dapat dipisahkan dari kesehatan fisik dan sosial, sehingga pendekatan keperawatan harus bersifat holistik dan inklusif.

3. Dampak Krisis dan Bencana terhadap Ketahanan Keluarga

Isu kontemporer berikutnya yang turut memengaruhi praktik keperawatan keluarga adalah meningkatnya frekuensi bencana alam dan krisis kesehatan global. Indonesia sebagai negara rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi, sering kali mengalami gangguan pada sistem pelayanan kesehatan yang berdampak langsung terhadap keluarga. Selain itu, pandemi dan krisis ekonomi global juga memberikan tekanan besar terhadap sistem kekebalan sosial dalam keluarga, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

Keluarga menjadi unit yang paling rentan terhadap dampak krisis ini. Kehilangan tempat tinggal, pengangguran, gangguan pendidikan anak, dan kesulitan mengakses layanan kesehatan menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. Perawat keluarga perlu memiliki kapasitas dalam disaster nursing, yaitu pengetahuan dan keterampilan dalam menangani kondisi darurat berbasis keluarga. Peran perawat dalam membangun ketahanan keluarga (family resilience), mengorganisasi bantuan, memberikan pertolongan pertama psikologis, serta menyusun rencana kontingensi keluarga menjadi bagian penting dari intervensi keperawatan di masa krisis.

4. Ketimpangan Sosial dan Akses Terhadap Layanan Kesehatan

Ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi isu struktural yang berdampak besar terhadap kesehatan keluarga. Banyak keluarga di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis, serta rendahnya literasi kesehatan. Dalam beberapa kasus, keluarga bahkan mengandalkan pengobatan tradisional yang tidak terstandarisasi sebagai pilihan utama karena kendala finansial dan geografis. Hal ini memperbesar risiko keterlambatan diagnosis, ketidaktepatan intervensi, dan meningkatnya angka morbiditas.

Perawat keluarga dihadapkan pada tantangan ganda untuk menjembatani kesenjangan ini dengan pendekatan komunitas. Perawat perlu hadir secara aktif di lingkungan keluarga untuk mengenali hambatan akses, melakukan pendekatan persuasif, serta mengembangkan program pemberdayaan keluarga dan komunitas lokal. Intervensi berbasis kesetaraan dan keadilan sosial merupakan fondasi penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan keluarga yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Transformasi Struktur dan Fungsi Keluarga

Transformasi dalam struktur keluarga turut memunculkan berbagai isu baru dalam praktik keperawatan. Perubahan pola keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga inti, meningkatnya angka perceraian, keluarga tunggal, keluarga lansia tanpa pendamping, serta pergeseran peran gender telah menciptakan dinamika yang kompleks dalam perawatan kesehatan di rumah. Misalnya, dalam keluarga tunggal, peran pengasuhan dan pencari nafkah disatukan dalam satu individu, sehingga beban ganda yang ditanggung dapat mempengaruhi kualitas perawatan dan perhatian terhadap kesehatan.

Perawat keluarga perlu memahami bahwa setiap keluarga memiliki konteks unik yang tidak dapat digeneralisasi. Oleh karena itu, asesmen terhadap struktur, peran, pola komunikasi, dan sumber daya internal keluarga harus dilakukan secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa intervensi keperawatan yang diberikan tepat sasaran dan dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat diri dan anggota keluarganya secara mandiri.

C. Implikasi terhadap Praktik Keperawatan Keluarga

Perubahan tren dan isu-isu kontemporer dalam keperawatan keluarga yang telah dibahas sebelumnya memberikan dampak yang luas dan mendalam terhadap praktik keperawatan di berbagai tingkat layanan. Keperawatan keluarga tidak lagi dapat dipahami sebagai perpanjangan dari keperawatan komunitas atau klinis semata, melainkan sebagai praktik profesional yang otonom, strategis, dan adaptif terhadap kebutuhan kompleks keluarga masa kini. Dalam konteks ini, implikasi terhadap praktik keperawatan keluarga mencakup berbagai aspek, mulai dari tuntutan kompetensi perawat, perluasan peran dalam pelayanan, hingga penguatan sistem pendukung dan kebijakan berbasis keluarga.

1. Tuntutan terhadap Peningkatan Kompetensi Profesional Perawat Keluarga

Perkembangan keperawatan keluarga menuntut transformasi dalam kemampuan dan kompetensi perawat. Perawat keluarga kini tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dasar dalam memberikan asuhan fisik, tetapi juga kemampuan untuk melakukan pendekatan holistik terhadap dinamika sosial, psikologis, budaya, dan lingkungan dalam keluarga. Ini termasuk keterampilan dalam melakukan komunikasi terapeutik lintas usia dan generasi, pemahaman terhadap norma budaya lokal, literasi digital untuk pemanfaatan teknologi kesehatan, serta penguasaan prinsip keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice).

Selain itu, kompetensi dalam melakukan asesmen keluarga secara menyeluruh, mengenali risiko kesehatan keluarga secara preventif, dan merancang intervensi yang spesifik terhadap masalah kesehatan keluarga juga

menjadi hal yang esensial. Kepekaan terhadap konteks sosial, kemampuan advokasi, serta keterampilan membangun jejaring komunitas menjadi modal penting dalam menghadapi kompleksitas kasus dalam keluarga yang beragam.

2. Perluasan Peran Perawat dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Keluarga

Perawat keluarga kini memiliki peran yang lebih luas dibandingkan peran tradisional yang hanya berfokus pada aspek kuratif atau pengobatan di rumah. Dalam era pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada promosi dan pencegahan, perawat keluarga menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran kesehatan di tingkat rumah tangga. Tugas perawat tidak lagi sekadar memberikan edukasi, tetapi juga menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung perubahan perilaku, melakukan pemantauan kesehatan secara rutin, dan memfasilitasi pengambilan keputusan dalam keluarga terkait pilihan layanan kesehatan yang tepat.

Peran perawat sebagai navigator dalam sistem layanan kesehatan juga semakin menonjol, terutama dalam membantu keluarga memahami prosedur administrasi, kebijakan kesehatan pemerintah, dan akses terhadap bantuan sosial atau layanan spesialisik. Dalam keluarga dengan lansia, anak berkebutuhan khusus, atau pasien dengan penyakit terminal, perawat seringkali berperan sebagai jembatan antara keluarga dan berbagai penyedia layanan kesehatan lain. Keterampilan koordinasi dan manajemen kasus menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada keluarga bersifat terintegrasi, efisien, dan manusiawi.

3. Penguatan Pendekatan Kolaboratif dan Interprofesional

Implikasi penting lainnya adalah perlunya membangun pendekatan kolaboratif dan interprofesional yang kuat dalam penyusunan dan pelaksanaan intervensi keperawatan keluarga. Tidak satu pun tenaga kesehatan yang mampu menyelesaikan masalah kompleks keluarga secara individual. Oleh karena itu, perawat keluarga harus mampu bekerja sama dengan berbagai profesi lain seperti dokter umum, ahli gizi, psikolog, pekerja sosial, dan penyuluh kesehatan masyarakat. Peran perawat di sini tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai koordinator tim interprofesional yang memastikan bahwa setiap langkah intervensi berbasis pada kebutuhan nyata keluarga dan dilakukan secara terkoordinasi.

Kemampuan dalam membangun komunikasi efektif, menyusun rencana asuhan kolaboratif, dan mengelola konflik antardisiplin menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan. Dalam banyak kasus, keberhasilan pelayanan kesehatan

keluarga ditentukan bukan hanya oleh jenis intervensi, tetapi oleh seberapa baik koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam pelayanan tersebut.

4. Dukungan Kebijakan dan Sistem terhadap Praktik Keperawatan Keluarga

Implikasi terakhir yang tidak kalah penting adalah kebutuhan akan dukungan sistemik dan kebijakan yang memfasilitasi peran perawat keluarga. Dalam banyak sistem kesehatan, pengakuan formal terhadap posisi dan kontribusi perawat keluarga masih belum optimal. Padahal, jika ditopang oleh kebijakan yang kuat, perawat keluarga memiliki potensi besar untuk menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.

Dukungan kebijakan bisa berbentuk penguatan sistem rujukan primer-sekunder-tercier, insentif untuk kunjungan rumah, pelatihan kompetensi berkelanjutan, serta integrasi sistem teknologi informasi kesehatan yang dapat diakses oleh perawat. Pemerintah daerah juga dapat memainkan peran strategis dalam membangun jejaring perawat keluarga berbasis komunitas, serta menyediakan regulasi yang mempermudah praktik keperawatan di luar institusi formal, seperti praktik mandiri keperawatan atau layanan berbasis komunitas.

Dengan dukungan sistem yang memadai, perawat keluarga tidak hanya akan menjalankan tugas secara optimal, tetapi juga mampu berinovasi dalam pengembangan model pelayanan yang responsif, berkelanjutan, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

D. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Pendekatan family-centered care dalam keperawatan keluarga menekankan bahwa?
 - A. Keputusan medis diambil sepenuhnya oleh tenaga kesehatan profesional.
 - B. Perawat bertindak sebagai pelaksana instruksi keluarga.
 - C. Keluarga dilibatkan sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan asuhan.
 - D. Pasien menjadi pusat perhatian dan keluarga tidak diikutsertakan.
 - E. Asuhan keperawatan hanya diberikan pada individu yang sakit.

Kunci Jawaban: C. Keluarga dilibatkan sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan asuhan.

2. Salah satu manfaat penggunaan teknologi digital seperti telehealth dalam keperawatan keluarga adalah?
 - A. Membatasi tanggung jawab perawat hanya pada pasien rumah sakit.
 - B. Mengurangi interaksi langsung antara keluarga dan perawat.
 - C. Memungkinkan pemantauan kesehatan keluarga secara jarak jauh dan efisien.

- D. Menghilangkan kebutuhan edukasi keluarga oleh perawat.
- E. Meningkatkan ketergantungan pasien terhadap aplikasi kesehatan.

Kunci Jawaban: C. Memungkinkan pemantauan kesehatan keluarga secara jarak jauh dan efisien.

3. Praktik keperawatan keluarga berbasis bukti (evidence-based family nursing) bertujuan untuk?

Dalam menghadapi bencana atau krisis kesehatan, peran strategis perawat keluarga adalah:

- A. Menggantikan pengalaman klinis perawat dengan hasil riset.
- B. Mengandalkan naluri perawat dalam pengambilan keputusan.
- C. Menghapus keterlibatan keluarga dari proses perawatan.
- D. Menstandarkan semua intervensi tanpa mempertimbangkan konteks keluarga.
- E. Menggabungkan bukti ilmiah, pengalaman klinis, dan preferensi keluarga.

Kunci Jawaban: E. Menggabungkan bukti ilmiah, pengalaman klinis, dan preferensi keluarga.

4. Dalam menghadapi bencana atau krisis kesehatan, peran strategis perawat keluarga adalah?

- A. Menyusun rencana kontingensi dan membangun ketahanan keluarga.
- B. Mengarahkan keluarga untuk pindah ke rumah sakit terdekat.
- C. Menunggu instruksi dari tenaga kesehatan lainnya.
- D. Menghindari keterlibatan langsung agar tidak terdampak.
- E. Fokus pada penanganan individu tanpa memperhatikan konteks keluarga.

Kunci Jawaban: A. Menyusun rencana kontingensi dan membangun ketahanan keluarga.

5. Transformasi struktur dan fungsi keluarga, seperti meningkatnya jumlah keluarga tunggal, menjadi tantangan bagi keperawatan keluarga karena?

- A. Keluarga tunggal tidak membutuhkan dukungan kesehatan dari luar.
- B. Seluruh tanggung jawab perawatan tertumpu pada satu individu.
- C. Intervensi keperawatan tidak dapat dilakukan di lingkungan keluarga.
- D. Anak-anak menjadi sepenuhnya mandiri tanpa pengawasan orang tua.
- E. Layanan kesehatan berbasis rumah menjadi tidak relevan.

Kunci Jawaban: B. Seluruh tanggung jawab perawatan tertumpu pada satu individu.

E. Rangkuman Materi

Perkembangan pesat dalam dinamika sosial, demografi, budaya, serta kemajuan teknologi informasi telah memengaruhi wajah keperawatan keluarga secara menyeluruh. Keperawatan keluarga kini bergerak melampaui praktik individual di rumah, menuju pendekatan profesional yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis bukti. Dalam konteks ini, keluarga tidak lagi diposisikan sebagai objek perawatan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kekuatan, nilai, dan partisipasi aktif dalam seluruh proses pelayanan kesehatan.

Pendekatan family-centered care menjadi pondasi penting dalam membangun hubungan yang setara antara perawat dan keluarga, dengan menekankan penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga serta keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan klinis. Selain itu, kemajuan digitalisasi membuka peluang besar bagi perawat keluarga untuk memanfaatkan telehealth, mHealth, dan sistem informasi kesehatan keluarga sebagai media peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, terutama pada wilayah terpencil atau dalam kondisi krisis seperti pandemi.

Penerapan evidence-based family nursing menjadi landasan ilmiah yang esensial dalam meningkatkan kualitas intervensi, legitimasi profesi, serta keselamatan pasien dan keluarganya. Perawat dituntut tidak hanya mampu mengakses dan memahami bukti ilmiah, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam konteks nilai budaya dan preferensi masing-masing keluarga.

Perubahan tren juga membawa kebutuhan akan kolaborasi interprofesional yang lebih kuat, mengingat kompleksitas masalah kesehatan keluarga tidak dapat ditangani oleh satu profesi saja. Kolaborasi lintas sektor dengan dokter, ahli gizi, psikolog, dan pekerja sosial menjadi syarat mutlak bagi terciptanya pelayanan yang holistik dan berkelanjutan.

Di sisi lain, berbagai isu kontemporer seperti peningkatan penyakit tidak menular dalam rumah tangga, gangguan kesehatan jiwa, dampak krisis dan bencana, serta ketimpangan akses layanan kesehatan memerlukan respons strategis dan adaptif dari perawat keluarga. Transformasi struktur keluarga seperti meningkatnya jumlah keluarga tunggal, lansia tanpa pendamping, dan pergeseran peran gender turut memperluas cakupan tanggung jawab perawat dalam asesmen dan penyusunan rencana asuhan yang berbasis konteks.

Implikasi dari seluruh tren dan isu ini mencakup tuntutan peningkatan kompetensi perawat dalam komunikasi lintas generasi dan budaya, literasi digital, advokasi sosial, serta penyusunan intervensi yang relevan dengan kebutuhan spesifik keluarga. Selain itu, diperlukan dukungan sistemik dan kebijakan

pemerintah yang memfasilitasi praktik keperawatan keluarga secara berkelanjutan melalui penguatan jejaring, insentif layanan primer, dan pengakuan profesional formal.

Dengan pemahaman mendalam terhadap tren dan isu keperawatan keluarga, mahasiswa keperawatan diharapkan mampu berpikir kritis, bersikap reflektif, serta bertindak secara kolaboratif dan etis dalam menyusun rencana asuhan keperawatan yang tidak hanya responsif terhadap perubahan zaman, tetapi juga solutif terhadap realitas yang dihadapi masyarakat. Integrasi antara pengetahuan teoritis, keterampilan praktis, dan pemahaman nilai-nilai keluarga merupakan kunci utama dalam menghasilkan perawat keluarga yang profesional, tangguh, dan relevan di masa depan.

F. Glosarium

Advokasi Kesehatan

Tindakan aktif perawat untuk membela dan mendukung hak serta kepentingan kesehatan keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap layanan kesehatan.

Asesmen Keluarga

Proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang struktur, fungsi, interaksi, dan kondisi kesehatan anggota keluarga sebagai dasar dalam menyusun rencana keperawatan.

Digitalisasi Kesehatan

Transformasi sistem pelayanan kesehatan dari metode manual ke teknologi digital, seperti penggunaan aplikasi kesehatan, rekam medis elektronik, dan sistem informasi keluarga.

Disaster Nursing

Cabang keperawatan yang berfokus pada persiapan, tanggapan, dan pemulihan dalam situasi bencana, termasuk intervensi terhadap keluarga yang terdampak secara langsung.

Early Detector

Peran perawat dalam mengenali gejala awal suatu masalah kesehatan fisik atau mental dalam keluarga untuk mencegah perburukan kondisi melalui intervensi dini.

Empati Budaya

Kemampuan perawat untuk memahami, menghargai, dan menyesuaikan layanan keperawatan dengan nilai, kebiasaan, dan kepercayaan budaya keluarga yang dilayani.

Evidence-Based Family Nursing

Pendekatan keperawatan keluarga yang menggabungkan bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis perawat, serta nilai dan preferensi keluarga dalam proses asuhan keperawatan.

Family-Centered Care (FCC)

Pendekatan dalam asuhan keperawatan yang menempatkan keluarga sebagai mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perawatan, dengan menghormati nilai dan peran mereka.

Family Resilience (Ketahanan Keluarga)

Kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali dari tekanan atau krisis yang dihadapi, termasuk bencana, penyakit kronik, atau gangguan psikososial.

Homecare

Pelayanan keperawatan yang diberikan kepada klien dan keluarganya di rumah, baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Interprofesional

Pendekatan pelayanan kesehatan yang melibatkan kolaborasi antara berbagai profesi seperti perawat, dokter, ahli gizi, psikolog, dan pekerja sosial untuk menghasilkan intervensi yang holistik.

Ketimpangan Sosial Kesehatan

Kesenjangan dalam akses, kualitas, dan hasil layanan kesehatan yang terjadi akibat perbedaan status sosial, ekonomi, geografi, atau budaya.

Kolaborasi Interprofesional

Kerja sama terintegrasi antara berbagai profesi dalam sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas hidup pasien dan keluarganya.

Komunikasi Terapeutik

Teknik komunikasi profesional yang digunakan perawat untuk membangun hubungan saling percaya dengan pasien dan keluarga, serta mendukung proses penyembuhan.

Kompetensi Digital

Kemampuan perawat untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dalam praktik keperawatan, termasuk penggunaan aplikasi kesehatan, pencatatan data elektronik, dan edukasi daring.

Literasi Digital

Keterampilan individu, termasuk perawat dan keluarga, dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital untuk meningkatkan kesehatan.

mHealth (Mobile Health)

Pemanfaatan perangkat seluler seperti smartphone atau tablet untuk mendukung praktik keperawatan, misalnya melalui pengingat minum obat atau aplikasi edukasi kesehatan keluarga.

Paradigma Pelayanan Kesehatan

Sistem nilai dan prinsip yang menjadi dasar pendekatan pelayanan kesehatan, seperti bergesernya dari model kuratif ke model promotif dan preventif berbasis keluarga.

Palliative Care

Perawatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan keluarganya, melalui pengendalian nyeri, dukungan emosional, dan spiritual.

Pelayanan Kesehatan Berbasis Komunitas

Pelayanan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk keluarga, dalam semua prosesnya.

Promotif dan Preventif

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan (promotif) dan mencegah terjadinya penyakit atau komplikasi (preventif) yang menjadi bagian integral dalam keperawatan keluarga.

Rencana Asuhan Keperawatan Keluarga

Dokumen sistematis yang memuat langkah-langkah intervensi perawat terhadap masalah kesehatan dalam keluarga, disusun berdasarkan hasil asesmen dan analisis masalah.

Sinergi Lintas Profesi

Koordinasi dan kerja sama antara profesi kesehatan yang berbeda untuk mencapai tujuan pelayanan keperawatan keluarga secara maksimal.

Telehealth

Pelayanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh melalui media elektronik, memungkinkan komunikasi dan konsultasi antara perawat dengan pasien/keluarga secara real-time.

Telemonitoring

Pemantauan kondisi pasien atau anggota keluarga secara jarak jauh menggunakan perangkat digital yang mengirimkan data kesehatan secara langsung kepada perawat atau tenaga kesehatan lainnya.

G. Daftar Pustaka

- American Nurses Association. (2015). Code of ethics for nurses with interpretive statements. Nursesbooks.org.
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. M. H. (2018). Family health care nursing: Theory, practice, and research (6th ed.). F.A. Davis Company.
- Mubarak, W. I., & Chayatin, N. (2020). Ilmu keperawatan komunitas: Teori dan praktik dalam keperawatan. Salemba Medika.
- Nies, M. A., & McEwen, M. (2018). Community/public health nursing: Promoting the health of populations (7th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). Fundamentals of nursing (10th ed.). Elsevier.
- Rachmawati, I. N., & Efendi, F. (2019). Keperawatan keluarga: Teori dan aplikasi dalam praktik keperawatan. Salemba Medika.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). Public health nursing: Population-centered health care in the community (10th ed.). Elsevier.
- Truglio-Londrigan, M., & Lewenson, S. B. (2018). Public health nursing: Practicing population-based care (3rd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- World Health Organization. (2021). State of the world's nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003293>
- Yosep, I. (2020). Keperawatan keluarga: Teori dan praktik klinik berbasis evidence-based. Pustaka Baru Press.

PROFIL PENULIS



Dr. Drs. Supriadi, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom. Lahir di Garut, 15 Juli 1964. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan di PSIK FK Universitas Padjadjaran Bandung, Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Komunitas di FIK Universitas Indonesia Jakarta, dan Pendidikan Doktoral Bidang Pendidikan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Pengalaman mengajar dimulai sejak tahun 1988 dalam berbagai bidang Keperawatan Dasar (Falsafah & Teori Keperawatan, KDK dan Kebijakan Kesehatan) dan Bidang Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga dan Keperawatan Gerontik (KKG). Penulis juga aktif sebagai peneliti, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, penulis buku serta nara sumber terkait pengembangan keperawatan kesehatan masyarakat dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Penulis dapat dihubungi melalui email: supriadifalah@gmail.com

Pesan untuk pembaca:

Jadilah insan yang penuh manfaat untuk orang banyak, tidak ada kata malas membaca untuk hidup penuh arti.



Dr. Iskim Luthfa, S.Kep., Ns., M.kep. Penulis lahir di Demak, 20 Juni 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 lulus pada tahun 2007 dan Ners tahun 2009 di Universitas Muhammadiyah Semarang. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan studi S3 di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan sejak tahun 2009 sampai sekarang sebagai Dosen Program Studi Fakultas Ilmu Keperawatan Departemen Keperawatan Komunitas, Universitas Islam Sultan Agung. Penulis aktif dalam berbagai

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Penulis juga aktif dalam organisasi profesi sebagai pengurus IPEGRI Jawa Tengah bidang Pelayanan dan Humas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: iskimluthfa@unissula.ac.id

Motto: "Hidup adalah perjalanan, jadi nikmati setiap langkahnya"

PROFIL PENULIS



Enik Suhariyanti, S.Kep., Ners., M.Kep. Lahir di Temanggung Jawa Tengah pada tanggal 19 Januari 1976. Menyelesaikan pendidikan D3 Keperawatan (1997) di PAM Keperawatan Dep Kes Semarang, S1 Keperawatan (2002) dan Program Profesi Ners (2004) di PSIK FK Universitas Airlangga Surabaya, S2 Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya (2013), saat ini sedang menjalani pendidikan S3 Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya dengan peminatan Keperawatan Keluarga, Komunitas dan Gerontik.

Penulis aktif sebagai dosen tetap Keperawatan di FIKES Univ. Muh. Magelang sejak tahun 2003 dan FIKES Univ. Galuh Ciamis sejak tahun 2022, mengampu mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, Pemenuhan Kebutuhan Manusia, Promosi Kesehatan, Keperawatan Kritis, Keperawatan Bencana serta Keperawatan Keluarga, Komunitas dan Gerontik. Pengalaman organisasi penulis aktif di organisasi Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI), serta aktif di DPD PPNI Kabupaten Ciamis sebagai anggota. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: esuhariyanti@gmail.com

Motto hidup yakni "Maju Terus Pantang Mundur-Bismillah Kita Bisa."



Ns. Arneliwati, M.Kep. Lahir di Pekanbaru, 15 Februari 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Akademi Keperawatan (AKPER) (2000), S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Universitas Andalas - Padang (2003) Program Studi Profesi Ners Universitas Andalas - Padang (2004),. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia – Jakarta, Keperawatan Komunitas dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004 sebagai Dosen DIII Akademi Perawat (AKPER) Universitas Abdurrahman Tabrani. Saat ini penulis bekerja di

Universitas Riau mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik dan Kebencanaan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan aktif dalam berbagai organisasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: arneliwati20@gmail.com

Motto: "*Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.*"

PROFIL PENULIS



Nur Fadhilah, M.Kes., Ph.D. lahir di Gisting Kabupaten Tanggamus, 20 Juli 1975 dari seorang ayah bernama Khozin Abdullah dan ibu Fairah Marhamah. Menikah dengan M. Yusup dan dikarunia 2 orang putra (M. Haeqal Phasa & M. Zidane Al Ghifarry) dan seorang putri (Keysha Yasmine Asshafira). Pendidikan terakhir S3 diselesaikan di Mahsa University Malaysia tahun 2023. Kariernya dimulai pada tahun 1998 sebagai perawat pelaksana di RSUAM Propinsi Lampung, di tahun yang sama penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Aktif sebagai dosen pengajar pada tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan kekhususan Mata Kuliah; Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik, Promosi Kesehatan dan Metodologi Penelitian. Sebagai bentuk dedikasi penulis dalam dunia pendidikan, penulis telah menghasilkan berbagai buku dan karya ilmiah, dan penulis konsen dalam program pencegahan dan pengendalian TBC berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PPNI Kabupaten Pringsewu, ketua Majelis Kesehatan PDA Kota Bandar Lampung, dan diberikan amanah sebagai Koordinator Indonesia Ramah Lansia (IRL) Kota Bandar Lampung, sebagai anggota MPKSDU PWM Lampung. Berbagai penghargaan sebagai dosen terbaik tingkat propinsi dan Nasional pernah diraih, dan tahun 2024 terpilih sebagai sosok inspiratif tingkat Propinsi.

"Don't stop when you're tired, stop when you're done"



Nety Mawarda Hatmanti, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Kediri, 27 April 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 di Stikes Yarsis yang saat ini berubah nama menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saat ini penulis bekerja di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya mengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan dan Keperawatan Keluarga. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan Pembina Hima. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nety.mawarda@unusa.ac.id

PROFIL PENULIS



Yanyan Bahtiar, S.Kp., M.Kep., lahir di Tasikmalaya, 26 Februari 1977, dari orang tua Hj. Ooh Chulasoh dan H. Zaenal Muksin dan berdomisili di Kota Tasikmalaya. Pendidikan dasar mulai dari SDN Kawalu 2, SMPN 1 Tasikmalaya, dan SMAN 1 Tasikmalaya. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan UNPAD Bandung. Selesai menempuh sarjana keperawatan di tahun 2003. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 di program magister Fakultas Keperawatan UNPAD Bandung konsentrasi keperawatan komunitas dan lulus pada tahun 2011.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 menjadi staf dosen di STIKep Muhammadiyah Tasikmalaya. Mulai tahun 2005 sampai sekarang, penulis bekerja sebagai dosen tetap di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebagai dosen tetap, penulis mengampu mata kuliah keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, keperawatan komunitas, keperawatan manajemen bencana, metodologi penelitian, PBAK, dan keperawatan komplementer. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma dan organisasi profesi PPNI Kota Tasikmalaya serta ikatan perawat komunitas (IPKKI) Jawa Barat. Penulis juga pernah menjabat sebagai ketua unit penelitian Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dari tahun 2016-2020; menjadi kepala unit bisnis Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 2020-2024, dan berlanjut periode kedua sampai sekarang. Penulis pernah menjadi dosen berprestasi tingkat Poltekkes Kemenkes RI di tahun 2012 dan mendapat juara harapan 2. Penulis juga sebagai praktisi terapis komplementer yang bersertifikat Hypnotherapy IBH Jakarta; SEFTer, TSP, Taouch therapy, dan Ruqiyah therapy. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yanyan.bahtiar@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id

Motto: "Jadilah orang yang bermanfaat dimanapun kita berada"



Ns Flora Sijabat S.Kep., MNS. Lahir di Bukit Tinggi, 08 September 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan di AKPER Sari Mutiara Medan. Melanjutkan S1 Keperawatan pada Program Studi Keperawatan di STIKes Sari Mutiara Indonesia. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Kasetsart University Bangkok, Thailand dan lulus pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1999-2004 bekerja di RSU Sari Mutiara. Pada tahun 2015-2024 bekerja di Universitas Sari Mutiara Indonesia sebagai Ketua program studi D3 Keperawatan. Tahun 2024- saat ini bekerja sebagai wakil dekan di Fakultas

Pendidikan Vokasi Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sari Mutiara Indonesia mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga, dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pembicara dalam seminar nasional / International, dan publikasi, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: florasijabat316@gmail.com

Motto: "Dream big, work hard."

Sinopsis

Keluarga adalah fondasi utama dalam kehidupan manusia—tempat pertama dan utama dalam pembentukan nilai, dukungan emosional, dan pemeliharaan kesehatan. Dalam dunia keperawatan modern, pemahaman terhadap keluarga sebagai satu kesatuan sistem yang saling memengaruhi menjadi kunci dalam memberikan asuhan yang efektif dan berkelanjutan.

Buku "Keperawatan Keluarga" ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan literatur yang komprehensif dan aplikatif dalam praktik keperawatan yang berfokus pada keluarga. Di dalamnya, pembaca akan menemukan konsep-konsep dasar keperawatan keluarga, teori dan model yang digunakan dalam pendekatan asuhan, serta strategi pengkajian dan intervensi yang sesuai dengan berbagai dinamika dan kondisi keluarga.

"Keperawatan Keluarga" bukan sekadar buku ajar, tetapi cerminan komitmen profesi keperawatan untuk hadir lebih dekat, lebih peduli, dan lebih bermakna dalam kehidupan setiap keluarga.

Keluarga adalah fondasi utama dalam kehidupan manusia tempat pertama dan utama dalam pembentukan nilai, dukungan emosional, dan pemeliharaan kesehatan. Dalam dunia keperawatan modern, pemahaman terhadap keluarga sebagai satu kesatuan sistem yang saling memengaruhi menjadi kunci dalam memberikan asuhan yang efektif dan berkelanjutan.

Buku "Keperawatan Keluarga" ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan literatur yang komprehensif dan aplikatif dalam praktik keperawatan yang berfokus pada keluarga.

Di dalamnya, pembaca akan menemukan konsep-konsep dasar keperawatan keluarga, teori dan model yang digunakan dalam pendekatan asuhan, serta strategi pengkajian dan intervensi yang sesuai dengan berbagai dinamika dan kondisi keluarga.

"Keperawatan Keluarga" bukan sekadar buku ajar, tetapi cerminan komitmen profesi keperawatan untuk hadir lebih dekat, lebih peduli, dan lebih bermakna dalam kehidupan setiap keluarga.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

